

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-graduação em Direito

Liliane Almeida de Menezes

**O DIREITO HUMANO À SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A aquisição de
vacinas contra a covid-19 no Brasil e os ecos da colonialidade**

Belo Horizonte – MG

2026

Liliane Almeida de Menezes

O DIREITO HUMANO À SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A aquisição de vacinas contra a covid-19 no Brasil e os ecos da colonialidade

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Direito.

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães

Área de concentração: Democracia, Constituição e Internacionalização

Belo Horizonte – MG

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

M543d Menezes, Liliane Almeida de
O direito humano à saúde em tempos de pandemia: a aquisição de vacinas contra a covid-19 no Brasil e os ecos da colonialidade / Liliane Almeida de Menezes. Belo Horizonte, 2026.
158 f. : il.

Orientador: José Luiz Quadros de Magalhães
Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Direito

1. COVID-19, Pandemia de, 2020 - Brasil. 2. Direitos humanos. 3. Direito à saúde. 4. COVID-19 (Doença) - Brasil - Vacinação. 5. Vacinas. 6. Colonialidade. 7. Legislação brasileira. 8. Pesquisa bibliográfica. I. Magalhães, José Luiz Quadros de. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.

SIB PUC MINAS

CDU: 342.7:614

Liliane Almeida de Menezes

O DIREITO HUMANO À SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A aquisição de vacinas contra a covid-19 no Brasil e os ecos da colonialidade

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Direito.

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães

Área de concentração: Democracia, Constituição e Internacionalização

Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães – PUC Minas (Orientador)

Profa. Dra. Flaviane de Magalhães Barros Bolzan de Moraes – PUC Minas (Banca Examinadora)

Prof. Dr. Mário Lucio Quintão Soares – PUC Minas (Banca Examinadora)

Profa. Dra. Maria de Lourdes Monteiro Albertini PUC Minas (Banca Examinadora)

Prof. Dr. Jorge Fulgêncio da Silva Chaves - UFVJM (Banca Examinadora)

Belo Horizonte, 10 de abril de 2026.

Aos meus pais (*in memoriam*),

que, mesmo na ausência, permanecem como presença
constante em minha vida.

AGRADECIMENTOS

Após quatro anos de intensa dedicação acadêmica, registro meus agradecimentos àqueles que contribuíram para a construção desta tese.

Expresso especial reconhecimento à orientação recebida ao longo do percurso, através do prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães, fundamental para o amadurecimento teórico e metodológico da pesquisa, bem como para o contato com referenciais críticos do pensamento contemporâneo que inspiraram e sustentaram as reflexões aqui desenvolvidas.

Agradeço, igualmente, às contribuições acadêmicas dos professores que fazem parte do programa de pós-graduação em Direito da PUC/MG, que possibilitaram o aprimoramento da investigação, por meio de leituras atentas, debates qualificados e observações rigorosas, essenciais ao aprofundamento analítico do trabalho.

Registro, ainda, minha gratidão às parcerias construídas ao longo dessa trajetória, marcadas pelo companheirismo e pelo apoio constante nos desafios enfrentados durante o processo de pesquisa e escrita.

Agradeço a todos os familiares, aos colegas e aos amigos pelo estímulo, pela paciência e pela compreensão.

“Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.”

Eduardo Galeano, *O livro dos abraços*

RESUMO

A presente tese analisa o direito humano à saúde no contexto da pandemia da COVID-19, a partir do exame crítico do processo de aquisição de vacinas pelo Brasil, interpretado à luz da teoria da colonialidade. Parte-se da compreensão de que a pandemia expôs, de forma aguda, as assimetrias estruturais que organizam o sistema internacional, especialmente no que se refere à produção, à distribuição e ao acesso a tecnologias em saúde, revelando a persistência de lógicas coloniais que condicionam a atuação dos Estados periféricos. O trabalho investiga de que maneira a colonialidade do poder e do saber influenciaram na elaboração das legislações emergenciais brasileira necessárias para a aquisição de imunizantes, bem como na elaboração das cláusulas contratuais para aquisição das vacinas no combate a COVID-19. Examina-se, nesse contexto, como a dependência tecnológica, a concentração da produção de imunizantes em países centrais e a atuação de grandes corporações farmacêuticas impactaram a soberania sanitária nacional e limitaram a efetivação do direito humano à saúde. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza jurídico-crítica, fundamentada na revisão bibliográfica interdisciplinar e na análise documental e normativa de atos legislativos, políticas públicas e instrumentos internacionais de direitos humanos. O tratamento empírico do material coletado foi realizado com base na técnica da análise de conteúdo, nos termos propostos por Laurence Bardin, contemplando as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A partir da categorização temática e da análise das recorrências discursivas, evidenciou-se que o processo de aquisição de vacinas pelo Brasil esteve condicionado por estruturas globais assimétricas, pela imposição de cláusulas contratuais desequilibradas e por uma inserção subordinada do país nas cadeias globais de produção e distribuição de tecnologias em saúde. A tese sustenta a necessidade de repensar os marcos jurídicos e institucionais da saúde global, fortalecer a capacidade estatal e tecnológica do Brasil e adotar uma perspectiva decolonial como caminho para a efetivação do direito humano à saúde em contextos de emergência sanitária e para a construção de maior autonomia e justiça global.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Direito Humano à Saúde. Vacina. Brasil. Colonialidade.

ABSTRACT

This dissertation analyzes the human right to health in the context of the COVID-19 pandemic, based on a critical examination of Brazil's vaccine acquisition process, interpreted in light of the theory of coloniality. It starts from the understanding that the pandemic starkly exposed the structural asymmetries that organize the international system, particularly with regard to the production, distribution, and access to health technologies, revealing the persistence of colonial logics that condition the actions of peripheral States. The study investigates how the coloniality of power and knowledge influenced the drafting of Brazilian emergency legislation required for the acquisition of vaccines, as well as the formulation of contractual clauses for vaccine procurement in the fight against COVID-19. In this context, it examines how technological dependence, the concentration of vaccine production in central countries, and the actions of major pharmaceutical corporations impacted national health sovereignty and limited the realization of the human right to health. The research adopts a qualitative approach of a legal-critical nature, grounded in an interdisciplinary literature review and in documentary and normative analysis of legislative acts, public policies, and international human rights instruments. The empirical treatment of the collected material was conducted based on the content analysis technique proposed by Laurence Bardin, encompassing the stages of pre-analysis, material exploration, and treatment of results, inference, and interpretation. Through thematic categorization and the analysis of discursive recurrences, it was evidenced that Brazil's vaccine acquisition process was conditioned by asymmetric global structures, the imposition of unbalanced contractual clauses, and the country's subordinate insertion into global chains of production and distribution of health technologies. The dissertation argues for the need to rethink the legal and institutional frameworks of global health, strengthen Brazil's state and technological capacity, and adopt a decolonial perspective as a pathway to the effective realization of the human right to health in contexts of health emergencies and to the construction of greater autonomy and global justice.

KEYWORDS: COVID-19. Human Right to Health. Vaccine. Brazil. Coloniality.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Art.	Artigo
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CF	Constituição Federal
CID	Classificação Internacional de Doenças
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONASS	Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CONASEMS	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
DUDH	Declaração Universal dos Direitos Humanos
DOU	Diário Oficial da União
EC	Emenda Constitucional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EUA	Estados Unidos da América
FMI	Fundo Monetário Internacional
G20	Grupo dos Vinte
H1N1	Influenza A (H1N1)
HR	Human Rights
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
MS	Ministério da Saúde
MP	Ministério Público
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OEA	Organização dos Estados Americanos
OMS	Organização Mundial da Saúde
OMC	Organização Mundial do Comércio

ONU	Organização das Nações Unidas
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
PDP	Parceria para o Desenvolvimento Produtivo
PNI	Programa Nacional de Imunizações
PND	Plano Nacional de Desenvolvimento
RNA	Ácido Ribonucleico
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS-CoV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
SciELO	Scientific Electronic Library Online
SUS	Sistema Único de Saúde
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE	União Europeia
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	COLONIALISMO, COLONIALIDADE E MODERNIDADE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DECOLONIAL.....	22
2.1	Do colonialismo à colonialidade: permanências estruturais do poder imperial.....	23
2.2	A colonialidade do poder: crítica a modernidade	32
2.3	Da colonialidade do saber: conhecimento eurocentrado e a supressão de epistemes locais.....	36
2.4	A colonialidade do ser: desumanização das populações periféricas.....	39
3	O DIREITO HUMANO À SAÚDE SOB O OLHAR CRÍTICO DECOLONIAL....	43
3.1	A construção histórica dos direitos humanos no mundo	44
3.2	O Direito Humano à saúde e as marcas da colonialidade	48
3.3	Descolonizar o Direito humano à Saúde: desafios para uma justiça global e intercultural	54
4	A PANDEMIA DA COVID-19 E A AQUISIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PARA ASSEGURAR O DIREITO HUMANO À SAÚDE: REFLEXOS DA COLONIALIDADE	58
4.1	A pandemia no mundo: desigualdades sanitárias	60
4.2	A pandemia da COVID-19 no Brasil: respostas normativas, impactos socioeconômicos e vulnerabilidades estruturais.....	64
4.2.1	<i>A produção mundial das vacinas e a hierarquização entre Norte e Sul Global.....</i>	<i>69</i>
5	A POSIÇÃO PERIFÉRICA DO BRASIL E AS DINÂMICAS NORMATIVAS E CONTRATUAIS NA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID-19	78
5.1	O processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19 no Brasil.....	79
5.2	As alterações normativas brasileiras e a reprodução da colonialidade no enfrentamento a COVID-19	82
5.2.1	<i>A colonialidade do poder: submissão do Brasil na compra do imunizante</i>	<i>84</i>
5.2.2	<i>A colonialidade do saber na regulação e contratação de vacinas contra a COVID-19 no Brasil</i>	<i>98</i>
5.3	Uma análise da narrativa midiática sobre os contratos para aquisição de vacinas e a reprodução da colonialidade do poder no discurso público	103
5.3.1	<i>A colonialidade do poder e sua influência quando da contratualização de imunizantes para o combate a COVID-19 no Brasil.....</i>	<i>106</i>
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	128
	REFERÊNCIAS	132
	APÊNDICE I.....	147
	APÊNDICE II.....	148

APÊNDICE III	157
APÊNDICE IV.....	158

1 INTRODUÇÃO

A trajetória que culminou nesta tese é atravessada por minhas experiências profissionais, acadêmicas e humanas que moldaram minha percepção crítica sobre o Estado brasileiro, sua forma de atuação, sua vulnerabilidade estrutural e, sobretudo, os modos pelos quais a colonialidade, enquanto padrão global de poder, continua a organizar relações políticas, jurídicas e econômicas no século XXI.

Minha formação como advogada e professora universitária, aliada à prática institucional como Procuradora-Geral do Município de Teófilo Otoni/MG durante a pandemia da COVID-19, conferiu-me um lugar singular de observação e de intervenção de um dos períodos mais desafiadores da história recente. Inserida diretamente no núcleo decisório da gestão municipal durante a crise sanitária, em estreita articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, convivi cotidianamente com as tensões, urgências e limitações que permearam a aquisição de insumos, a busca por vacinas, a celebração de contratos e as negociações com instâncias federativas.

Assim, esta tese não emerge apenas de inquietações teóricas, mas de vivências concretas. Surgiu do encontro entre minha prática jurídica, minha atuação institucional em defesa do interesse público e da coletividade e da minha formação acadêmica comprometida com uma leitura crítica interdisciplinar em relação ao direito, a sociologia e a antropologia.

É justamente a partir dessa vivência concreta dentro da Administração Pública, que se tornou possível compreender a pandemia da COVID-19 como um episódio sanitário, e, principalmente, como um dos mais marcantes eventos políticos, sanitários e civilizatórios do século XXI, que revelou a vulnerabilidade das estruturas estatais e a persistência de desigualdades históricas que organizam o sistema-mundo desde o período colonial.

A emergência sanitária global não apenas expôs as fragilidades dos sistemas nacionais de saúde, como também tornou visíveis os mecanismos profundos da colonialidade que modulam, ainda hoje, o acesso à ciência, às tecnologias de saúde e às condições básicas de existência.

Nesse contexto, a saúde, formalmente reconhecida em tratados internacionais e na Constituição brasileira de 1988 como direito humano fundamental (Ventura, 2013) atravessou um campo disseminado por disputas geopolíticas, interesses econômicos transnacionais, racionalidades mercadológicas e hierarquias globais de produção de conhecimento.

A compreensão crítica desse fenômeno exigiu ir além das leituras biomédicas e epidemiológicas convencionais, situando a pandemia e a aquisição das vacinas, em especial

pelo governo federal brasileiro, como parte de uma estrutura histórica de longa duração. É nesse sentido que a teoria da colonialidade formulada por Aníbal Quijano, ofereceu arcabouço conceitual indispensável para a pesquisa que culminou com a elaboração desta tese.

Para Quijano (2005), a modernidade não pode ser separada da colonialidade, pois o mundo moderno se constituiu por meio da classificação racial da população, da imposição de epistemologias eurocentradas, da exploração econômica e da produção de subjetividades hierarquizadas. Esse tripé, raça, saber e poder econômico, continua organizando o mundo contemporâneo, produzindo assimetrias profundas entre o denominado Norte e Sul Global, uma referência aos países desenvolvidos e em desenvolvimento respectivamente.

A colonialidade, como pode ser visto ao longo desta tese, também atravessou o campo da saúde e expressou o modo como a atenção sanitária, progressivamente, passou a ser regida por valores mercantis e por dinâmicas corporativas internacionais que hierarquizaram vidas, saberes e territórios. Na pandemia, tal condição atingiu seu ápice: países detentores de tecnologia dominaram a produção das vacinas, impuseram regimes contratuais assimétricos, conseqüentemente, estabeleceram preços diferenciados e relegaram nações periféricas a posições de dependência e espera. A governança global, longe de se estruturar sob um paradigma de equidade, reiterou a lógica da acumulação e da exclusão.

A produção global das vacinas contra a COVID-19, tecnicamente, tratou-se de uma corrida internacional cujas etapas foram controladas por corporações farmacêuticas transnacionais situadas nos países centrais (Norte Global). Politicamente, observou-se a reprodução da dependência em relação aos países em desenvolvimento (Sul Global).

No caso brasileiro, a pandemia ocasionada pela COVID-19, foi agravada, dentre outras questões, pelo retardamento ao acesso aos imunizantes. Embora este fato tenha sido anteriormente discutido, não foi explorada a forma como a colonialidade influenciou, simultaneamente, a elaboração das legislações emergenciais, as condições de negociação dos contratos internacionais para aquisição de imunizantes, a dependência tecnológica estruturante e o posicionamento do Brasil nas cadeias globais de produção de vacinas.

Esta tese buscou preencher essa lacuna, oferecendo uma análise integrada da pandemia da COVID-19 a partir da colonialidade, compreendendo-a não apenas como crise epidemiológica, mas também como síntese de um padrão global de poder que submeteu o Brasil a um regime persistente de subalternização quando da aquisição dos imunizantes, o que caracterizou o ineditismo da tese, comprovado através dos resultados da pesquisa exploratória realizada.

Com base nos resultados da pesquisa exploratória sistematizada no APÊNDICE I desta tese, foi possível delinear um panorama consistente acerca da produção acadêmica entre os anos de 2020 e 2025 no que se refere ao direito humano à saúde e seus possíveis pontos de interlocução com os temas da vacinação, colonialidade, indústria farmacêutica/corporações transnacionais e da pandemia da COVID-19.

O levantamento, realizado nas bases de dados: Google Acadêmico, SciELO Brasil, BDTD e Periódicos da CAPES, evidenciaram, em um primeiro momento, a expressiva quantidade de trabalhos que abordaram isoladamente cada um desses descritores, sobretudo aqueles relacionados à COVID-19 e ao direito humano à saúde, o que demonstra a centralidade do debate sanitário no contexto pandêmico e pós-pandêmico.

Todavia, quando se avança da análise quantitativa geral para a interlocução temática entre o direito humano à saúde e os demais descritores, foi possível observar uma redução significativa do número de trabalhos que efetivamente articularam tais categorias de forma integrada. Embora haja registros que relacionem o direito humano à saúde com vacinação, colonialidade, indústria farmacêutica ou COVID-19, essas produções se mostraram fragmentadas e, em grande medida, limitada a abordagens setoriais, sem aprofundamento crítico das relações estruturais que atravessam esses fenômenos. Essa constatação tornou-se ainda mais evidente quando se procedeu à aplicação de expressões booleanas mais específicas, desenhadas para captar pesquisas que dialogassem diretamente com o objeto central desta tese.

Com efeito, a busca combinada pelos termos “direito humano à saúde”, “vacina/imunizante”, “colonialidade” e “COVID-19”, bem como pela inclusão da dimensão da indústria farmacêutica e das corporações transnacionais, resultou em número extremamente reduzido de trabalhos, sendo que nenhum deles apresentou aderência suficiente ao recorte teórico-metodológico proposto.

A ausência de estudos selecionados, mesmo diante de resultados brutos inicialmente identificados em algumas bases, revelou uma lacuna relevante na literatura acadêmica: inexistem, no período analisado, pesquisas que enfrentaram de modo articulado e crítico a realização do direito humano à saúde no contexto da pandemia, à luz dos ecos da colonialidade e das dinâmicas de poder impostas pelo complexo farmacêutico-industrial transnacional.

Dessa forma, os achados da pesquisa exploratória não apenas justificaram, como reforçaram a originalidade e a relevância científica da presente tese. A inexistência de trabalhos aderentes ao tema evidenciou a necessidade de uma investigação que ultrapassasse análises normativas ou epidemiológicas isoladas, propondo uma leitura integrada entre direitos humanos, saúde global, colonialidade e estruturas econômicas transnacionais.

Assim, esta pesquisa se insere em um campo ainda pouco explorado, contribuindo para o avanço do debate acadêmico e oferecendo subsídios teóricos e críticos para a compreensão das desigualdades estruturais que marcaram o acesso a vacinas e a efetivação do direito humano à saúde no período pandêmico. Trata-se de uma abordagem inovadora, pois desloca a narrativa da pandemia de uma compreensão meramente conjuntural para uma leitura estrutural, capaz de iluminar padrões históricos que se reproduzem sob novas formas.

O referencial teórico dialoga com autores centrais do pensamento decolonial, como Aníbal Quijano, Achille Mbembe, Aimé Césaire, Boaventura de Sousa Santos, Catherine Walsh, Edgardo Lander, Walter Mignolo, Henrique Dussel, José Luiz Quadros de Magalhães, María Lugones, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel e Rita Segato. Complementarmente, incorpora análises de pesquisadores da saúde global e direitos humanos como Alejandro Médici, Deisy Ventura, Immanuel Wallerstein, Lynn Hunt, Paulo Buss e Sueli Gondolfi Dallari que discutem a relação entre governança, saúde pública, direitos humanos e desigualdades transnacionais.

Além de todo o entrelaçamento teórico acima citado, a pesquisa que culminou nesta tese, examinou os atos normativos publicados durante o período que compreendeu a emergência em saúde pública nacional no Brasil (2020/2022), referente à aquisição de vacinas contra a COVID-19. Assim, inicialmente, foram catalogadas todas as legislações federais publicadas no Diário Oficial da União (DOU) durante o período de emergência em saúde pública de importância nacional, e na sequência foram extraídas as legislações referentes à aquisição de imunobiológicos pelo estado brasileiro, na eminência de demonstrar como o processo legislativo nacional, embora destinado a dar respostas emergenciais, reproduziu dependências estruturais, flexibilizou garantias jurídicas e ampliou margens contratuais das empresas farmacêutica sob a ótica da colonialidade.

Durante a pesquisa também foi analisado contextos midiáticos (entrevistas de autoridades brasileiras, depoimentos na CPI da COVID-19, matérias jornalísticas, sites de instituições nacionais e internacionais) uma vez que os contratos firmados com as transnacionais farmacêuticas e o governo federal não estão disponíveis para consulta devido cláusula de confidencialidade (Brasil, 2025).

A partir desse panorama, o problema de pesquisa que orientou esta tese se apresentou na seguinte questão de pesquisa: como as relações de aquisição de imunizantes entre o Estado brasileiro e as indústrias farmacêuticas transnacionais, reproduziram estruturas de colonialidade, tensionando a efetividade do direito humano à saúde no combate a COVID-19?

O problema central que se coloca reside na forma pela qual a aquisição de vacinas incorporou, de maneira explícita ou implícita, assimetrias de poder que foram capazes de afetar a soberania decisória do Estado e tensionar a efetividade do direito humano fundamental à saúde, evidenciando fortes traços de colonialidade nesta relação.

As normas editadas em caráter emergencial, ao flexibilizarem procedimentos, controles e critérios tradicionais do direito administrativo e sanitário, passaram a admitir a centralidade de referenciais externos, como certificações, autorizações e decisões de autoridades sanitárias estrangeiras, em detrimento da autonomia regulatória nacional. Estas normas, justificada pelo discurso da urgência e da excepcionalidade, reforçaram relações de dependência histórica entre centros produtores de tecnologia e Estados consumidores periféricos.

De modo convergente, os contratos celebrados para aquisição de vacinas entre o governo federal brasileiro e as indústrias farmacêuticas transnacionais evidenciaram um cenário de profunda assimetria contratual, marcado por cláusulas de confidencialidade, limitação de responsabilidade das contratadas, eleição de foro estrangeiro e renúncia, ainda que tácita, à jurisdição nacional brasileira.

Nesse contexto, a resposta ao problema de pesquisa não se restringe apenas à análise da legalidade formal das leis emergenciais ou dos contratos firmados, mas se insere em uma dimensão estrutural mais ampla como acima citado. Trata-se, portanto, de investigar como a colonialidade, enquanto matriz histórica e contemporânea de poder, se manifestou no direito brasileiro no contexto da crise sanitária ocasionado pela COVID-19, influenciando escolhas normativas e determinando cláusulas contratuais que impactaram diretamente na soberania estatal, na proteção da vida e na sedimentação do direito à saúde.

Com relação aos objetivos desta tese, os mesmos desempenharam papel central na organização lógica e metodológica da investigação, orientando tanto o percurso teórico quanto a análise empírica. Nesta perspectiva, o objetivo geral consistiu em analisar de que modo as relações estabelecidas entre o Estado brasileiro e as grandes indústrias farmacêuticas transnacionais, no contexto da aquisição de imunizantes para o enfrentamento da COVID-19, reproduziram estruturas de colonialidade, tensionando a efetividade do direito humano à saúde.

A importância do objetivo proposto manifestou-se no seu potencial explicativo acerca da posição estrutural ocupada pelo Brasil no mercado global de vacinas. Ao investigar de que modo a produção global dos imunizantes e os arranjos jurídicos nacionais reproduziram padrões colonialidade, o estudo contribuiu para o entendimento das razões pelas quais o país permaneceu em condição de vulnerabilidade sanitária, apesar de dispor de um sistema público de saúde universal e de capacidade científica instalada. Tal reflexão é relevante não apenas para

a compreensão do passado recente, mas para a formulação de respostas futuras mais soberanas, equitativas e comprometidas com a efetivação do direito fundamental à saúde.

Para alcançar o objetivo geral desta tese e, conseqüentemente, responder à sua questão de pesquisa, perseguiu os seguintes objetivos específicos:

a) Compreender e sistematizar os fundamentos teóricos do pensamento decolonial, com ênfase nas categorias da colonialidade do poder, do saber e do ser analisando sua constituição histórica no âmbito do projeto da modernidade e sua permanência nas estruturas sociais, políticas, jurídicas e econômicas contemporâneas.

b) Analisar o direito humano à saúde a partir de uma perspectiva crítica decolonial, problematizando as noções de universalidade e neutralidade do discurso dos direitos humanos, a fim de evidenciar as vulnerabilidades estruturais produzidas pela colonialidade e discutir a necessidade de descolonização do campo jurídico dos direitos humanos.

c) Investigar como a pandemia da COVID-19, no contexto brasileiro, evidenciou relações hierárquicas entre países do Norte e do Sul Global, especialmente no que se refere à produção, distribuição e acesso às vacinas, revelando a reprodução de estruturas de colonialidade no enfrentamento da emergência sanitária.

d) Analisar criticamente as alterações normativas brasileiras e a imposição de cláusulas contratuais para a aquisição de vacinas contra a COVID-19, identificando em ambos a incidência da colonialidade do poder e do saber, bem como seus impactos sobre a autonomia estatal e a efetivação do direito humano à saúde.

A pesquisa realizada para elaboração desta tese adotou uma abordagem qualitativa, analítico-interpretativa, fundamentada no método de análise de conteúdo, desenvolvido por Laurence Bardin (2020), por sua capacidade de revelar estruturas latentes, regularidades discursivas e padrões decisórios que operaram no interior dos textos normativos, institucionais e científicos relacionados à aquisição de vacinas contra a COVID-19 pelo Estado brasileiro.

A opção metodológica decorre da natureza complexa do objeto de estudo, que articula dimensões jurídicas, políticas, tecnológicas e geopolíticas inscritas em uma matriz histórica de colonialidade. Para tanto, foi adotada as etapas clássicas do método que consistiu em:

a) Pré-análise: precedeu na delimitação criteriosa do *corpus* documental, realizada a partir de um lapso temporal, ou seja, durante o início e fim da decretação pelo governo federal brasileiro de estado de emergência em saúde pública de importância nacional, que correspondeu ao período de 03 de fevereiro de 2020 a 22 de abril de 2022. Observando a pertinência temática (normas e documento vinculados à aquisição de imunizantes).

Nessa etapa, definiu-se o conjunto de categorias preliminares orientadas pelo marco teórico da colonialidade. Procedeu-se, ainda, à construção de uma matriz de leitura com eixos jurídico-normativos, político-institucionais e técnico-científicos.

b) Exploração do material: Esta fase foi dedicada à codificação e decomposição analítica do *corpus* documental, mediante identificação de unidades de registro, segmentos temáticos e núcleos de sentido capazes de expressar a presença ou a reprodução de padrões coloniais no processo de aquisição de vacinas.

Os documentos foram examinados em seu conteúdo explícito como as disposições normativas, justificativas técnicas, discursos oficiais de autoridades institucionais, informações em sites do governo federal, depoimentos e mídias jornalísticas.

c) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: Nesta etapa se procedeu à articulação crítica entre os dados empíricos e o referencial teórico da colonialidade, buscando identificar como os dispositivos normativos brasileiros produzidos no contexto de emergência sanitária, bem como a elaboração contratual para aquisição de imunobiológicos, incorporaram os padrões coloniais de poder global, especialmente no tocante à dependência tecnológica de insumos farmacêuticos, à subordinação às regras internacionais, às limitações nas negociações contratuais com as multinacionais farmacêuticas e ao posicionamento periférico do Brasil nas cadeias globais de produção de imunizantes.

O *corpus* documental foi composto pelos seguintes grandes conjuntos:

a) documentos normativos: legislações federais emergenciais, referente a aquisição de vacinas para o combate a COVID-19 no Brasil, durante o período de emergência pública em saúde nacional.

b) reportagens, depoimentos, entrevistas de autoridades sanitárias e institucionais sobre aquisição de vacinas para o combate a COVID-19 no Brasil.

c) dados e documentos institucionais de organismos nacionais e internacionais: relatórios, resoluções e bases de dados da OMS, OPAS, OMC, PNUD, ONU, governo federal brasileiro e outras entidades multilaterais que atuaram na governança global da COVID-19, especialmente no tocante à aquisição e distribuição de imunobiológicos.

A escolha dessa metodologia permitiu compreender o fenômeno investigado não como um evento isolado, mas como expressão de uma longa duração histórica de dependências estruturais, hierarquias globais e constrangimentos jurídicos que moldam a atuação do Estado brasileiro. Ao mobilizar fontes normativas, documentos e dados institucionais a tese buscou garantir rigor analítico, densidade empírica e consistência teórico-metodológica, permitindo

interpretar a aquisição de vacinas no Brasil como fenômeno simultaneamente jurídico, político, econômico e colonial.

A presente tese encontra-se estruturada em quatro capítulos originados a partir dos objetivos específicos apresentados anteriormente, além da introdução e das considerações finais, organizados de modo a articular progressivamente os fundamentos teóricos decoloniais com a análise jurídico-política da pandemia da Covid-19 e da aquisição de vacinas pelo Brasil.

O Capítulo 2 foi dedicado à construção do marco teórico, examinando os conceitos de colonialismo, colonialidade e modernidade, a partir das contribuições do pensamento decolonial. Nesse capítulo, foram abordadas as permanências estruturais do poder imperial e desenvolvidas as categorias analíticas da colonialidade do poder, do saber e do ser, fundamentais para a compreensão das hierarquias geopolíticas, epistemológicas e ontológicas que informam as relações globais contemporâneas.

O Capítulo 3 precedeu de uma análise profunda dos direitos humanos, com especial atenção ao direito humano à saúde, examinando sua construção histórica e suas tensões internas à luz de uma leitura crítica decolonial. Buscou-se demonstrar como o discurso universalista dos direitos humanos convive com práticas excludentes e hierarquizadas, além de ter discutido os desafios teóricos e jurídicos para a descolonização do direito à saúde no contexto de uma justiça global intercultural.

No Capítulo 4, a tese analisou a pandemia da Covid-19 como fenômeno global e local, evidenciando as desigualdades sanitárias que marcaram sua evolução e seus impactos. A abordagem contempla tanto o cenário internacional quanto a realidade brasileira, destacando as vulnerabilidades estruturais do país e a forma como a produção mundial de vacinas reproduziu uma hierarquização entre o Norte e o Sul Global, condicionando o acesso aos imunizantes.

O Capítulo 5 concentrou-se na análise do Brasil enquanto país periférico, examinou as dinâmicas contratuais e normativas relacionadas à aquisição de vacinas contra a Covid-19. Foram investigados os processos de compra dos imunizantes, as alterações legislativas adotadas durante a emergência sanitária e a forma como essas medidas revelaram a dependência científica e tecnológica do país. O capítulo aprofundou, ainda, na análise das manifestações da colonialidade quando da elaboração das legislações para aquisição da vacina e das cláusulas contratuais impostas para sua aquisição.

Por fim, as considerações finais sistematizaram os principais “achados” da tese, retomando o problema e os objetivos propostos, e apontaram reflexões críticas sobre os impactos da colonialidade na efetivação do direito humano à saúde, especialmente em contextos de crises sanitárias globais.

Assim, constatou-se que a presente tese se insere na linha de pesquisa Direitos Humanos, Integração e Estado Plurinacional, ao investigar o direito humano à saúde em contextos pandêmicos, compreendido não apenas como garantia jurídica formal, mas como expressão concreta das assimetrias históricas que estruturam o sistema internacional e os Estados nacionais.

A pandemia da COVID-19 evidenciou que o acesso à saúde, embora reconhecido como direito fundamental e humano, permanece condicionado por dinâmicas de poder que produzem exclusões sistemáticas, especialmente nos países e populações situados à margem dos centros hegemônicos de decisão.

Ao articular o direito humano à saúde com os eixos analíticos da integração e Estado plurinacional, a tese propôs uma leitura crítica que valoriza a interculturalidade e a cooperação solidária entre os povos. Buscou-se, assim, demonstrar que a superação das desigualdades intensificadas em tempos de pandemia exige a reconstrução das bases do Estado e das relações internacionais a partir de um paradigma de direitos humanos comprometido com a justiça social, a dignidade humana e o reconhecimento da diversidade histórica e cultural.

2 COLONIALISMO, COLONIALIDADE E MODERNIDADE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DECOLONIAL

A história da modernidade ocidental é indissociável da experiência do colonialismo, cuja consolidação deu origem a um padrão duradouro de dominação que se prolonga para além de sua dimensão histórica imediata, manifestando-se por meio da colonialidade. O colonialismo europeu, especialmente aquele que se estruturou na América Latina e no continente africano, constituiu o primeiro sistema mundial de dominação, responsável por organizar de forma hierárquica a economia, a política e a produção do conhecimento sob a centralidade da Europa moderna.

Posteriormente, esse sistema passou a ser compreendido não apenas como um processo de ocupação e dominação territorial, mas como um projeto global que articula relações assimétricas de poder, saber e ser, conformando subjetividades, epistemologias e estruturas institucionais em escala planetária.

Embora o colonialismo, enquanto regime jurídico-político formal, tenha sido progressivamente desmantelado ao longo do século XX, os mecanismos estruturais de dominação por ele engendrados não foram superados. Ao contrário, tais padrões persistem e se reproduzem no mundo contemporâneo por meio da colonialidade, que sobreviveu aos processos de descolonização formal e continua a orientar as dinâmicas globais, condicionando as relações internacionais, a produção do conhecimento e a organização das desigualdades sociais.

Conforme destaca Walter Mignolo (2017), o conceito de colonialidade foi introduzido por Aníbal Quijano no final da década de 1980 e início dos anos 1990, conferindo novo sentido analítico à noção tradicional de colonialismo. Ao deslocar o foco do domínio político-territorial para as estruturas profundas de poder, Quijano ampliou a compreensão do colonialismo, evidenciando sua permanência para além do período histórico formal de colonização.

Aníbal Quijano (2005), sociólogo e pensador humanista peruano, sustentou, ao longo de sua obra, que o colonialismo não se encerrou com os processos de independência, mas se perpetua por meio da colonialidade, compreendida como a face oculta da modernidade. Trata-se de um conjunto estruturado de relações de poder que articula hierarquias raciais, econômicas e epistêmicas, responsáveis por sustentar o sistema-mundo moderno até a contemporaneidade.

Nesse sentido, enquanto o colonialismo pode ser entendido como um fato político-histórico situado, a colonialidade configura-se como uma estrutura de longa duração, isto é, uma matriz persistente de dominação que organiza, de forma hierarquizada, a economia global,

a cultura e a produção do conhecimento. Portanto, a partir desse processo histórico de afirmação da centralidade europeia, emergiu um novo sistema de dominação social, no qual foram forjadas identidades destinadas a classificar e diferenciar os povos.

O conceito de “raça” passou, então, a operar como categoria central desse sistema, sendo construído socialmente para justificar e naturalizar a dominação, a exploração econômica e a hierarquização das populações sob a égide da Europa moderna. A colonialidade consolidou-se, assim, como uma estrutura duradoura de poder, organizando a economia global, a cultura e o conhecimento científico e tecnológico, tendo a racialização como um de seus principais eixos constitutivos.

Nesse contexto, a raça tornou-se princípio organizador da divisão do trabalho, das formas de autoridade e da produção do conhecimento, legitimando a suposta superioridade europeia e a inferiorização dos povos colonizados, tais como indígenas, africanos, mestiços, asiáticos e latino-americanos, entre outros.

A partir desse marco teórico, serão abordados os fatores históricos que conduziram ao surgimento e à consolidação do colonialismo, bem como sua transformação em colonialidade, com destaque para as categorias da colonialidade do poder, do saber e do ser compreendidas como formas estruturais e, frequentemente, invisibilizadas de dominação que permanecem ativas na contemporaneidade.

2.1 Do colonialismo à colonialidade: permanências estruturais do poder imperial

Historicamente, o feudalismo caracterizado como um sistema político, social e econômico, surgiu na Europa Ocidental, com a desagregação do Império Romano, seguida das invasões bárbaras.

Esta forma de organização teve como peculiaridades os feudos, com a vassalagem agrária, além de uma economia que se destinava ao consumo local, fato que gerou uma dependência da exploração do solo e uma centralização de poder baseado na posse de terra, na autossuficiência e numa sociedade hierarquizada, sem mobilidade social (Soares, 2008).

O sistema feudal perdurou por anos, tendo iniciado seu declínio somente a partir do século XIII por diversos fatores, dentre os quais a propagação da peste negra, as Cruzadas, a formação dos burgos no entorno das feiras, a expansão do comércio e o advento dos Estados nacionais.

A economia da Europa feudal passava nesse período por uma crise interna muito profunda, que sacudia seus alicerces sociais. As classes dominantes destruíam umas às outras, em grande escala. O sistema de propriedade da terra, base da estrutura econômica, se desfazia, e a reorganização em curso apontava para uma distribuição muito mais igualitária. Os pequenos camponeses demonstravam grande eficiência como produtores. As estruturas políticas ficavam em geral mais fracas, e a preocupação com a luta fratricida entre os politicamente poderosos deixava pouco tempo para reprimir a força crescente das massas populares. O cimento ideológico do catolicismo estava sob grande pressão; movimentos igualitários nasciam no seio da própria igreja. As coisas estavam de fato desmoronando. (Wallerstein, 2001, p.39)

Ao analisar o momento histórico de transição e o processo de declínio do feudalismo, Quintão Soares (2008) sustentou que a ordem feudal sucumbiu em razão da expansão da mercancia nos centros urbanos. A economia natural, característica do sistema feudal, entrou em colapso à medida que foi progressivamente substituída pela economia monetária, impulsionada pela intensificação das trocas comerciais e pela ampliação das relações mercantis com o Oriente.

O crescimento das rotas comerciais e a dinamização do comércio contribuíram para a consolidação das cidades como polos econômicos relevantes, ampliando significativamente suas fontes de renda e enfraquecendo a centralidade da terra como principal fator de riqueza. Nesse contexto, a circulação de mercadorias passou a adquirir valor econômico superior ao da propriedade fundiária, ao passo que as relações de produção foram gradativamente reorganizadas, deslocando-se do trabalho servil para formas de trabalho livre e assalariado.

Com o esgotamento do Estado feudal, emerge o Estado Moderno, o qual, conforme assinala José Luiz Quadros de Magalhães (2012), constituiu-se a partir de uma aliança estratégica entre os interesses econômicos do clero, da nobreza e da burguesia emergente. Essa articulação foi viabilizada pela institucionalização da coerção e pela racionalização administrativa por meio da burocracia estatal, criando as condições políticas, jurídicas e econômicas necessárias à consolidação do capitalismo.

A formação do Estado moderno a partir do século XV ocorre após lutas internas onde o poder do rei se afirma perante os poderes dos senhores feudais unificando o poder interno, unificando os exércitos e a economia, para então afirmar este mesmo poder perante os poderes externos, os impérios e a igreja. Tratando-se de um poder unificador numa esfera intermediária, pois cria um poder organizado e hierarquizado internamente, sobre os conflitos regionais, as identidades existentes anteriormente a formação do Reino e do Estado nacional que surge neste momento e de outro lado, se afirma perante o poder da Igreja e dos impérios. Este é o processo que ocorre em Portugal, França e Inglaterra. (Magalhães, 2012, p.23)

O Estado moderno consolidou-se, assim, como uma instituição político-jurídica caracterizada pela soberania, pela delimitação territorial, pela existência de uma população permanente, pela organização do poder por meio da divisão de funções estatais e pela capacidade de estabelecer relações com outros Estados, bem como de exercer o monopólio

legítimo do uso da força. Distingue-se das formas políticas anteriores sobretudo pela centralização do poder e pela institucionalização da coerção, elementos fundamentais à manutenção da ordem e da estabilidade social.

Nesse processo de construção conceitual, destacam-se as contribuições de pensadores clássicos como Nicolau Maquiavel, Jean Bodin e Thomas Hobbes, cujas formulações teóricas foram decisivas para a compreensão do Estado moderno como entidade dotada de poder coercitivo centralizado. Esses autores enfatizaram a necessidade de um poder político forte e unificado como condição para a preservação da ordem, da segurança e da estabilidade política em contextos marcados por conflitos e fragmentação do poder.

Maquiavel (2010), em particular, rompeu com a tradição medieval ao separar a política da ética, sustentando que a eficácia do governo e a conservação do poder justificariam os meios empregados pelo governante. Para o autor, a estabilidade do Estado dependia da capacidade do príncipe de compreender e manejar as categorias da *virtù* e da *fortuna*, de modo a assegurar o controle político e a autoridade necessária à manutenção do poder. A centralidade da autoridade política, nesse sentido, apresentava-se como elemento indispensável à estabilidade do governo e à preservação da unidade estatal.

o longo do processo histórico, contudo, o Estado moderno passou por distintas fases e transformações estruturais. A primeira dessas etapas correspondeu ao advento da monarquia absolutista, predominante entre os séculos XVI e XVIII, caracterizada pela concentração do poder nas mãos do monarca, pela legitimação divina da autoridade real e pela inexistência de limites jurídicos expressos, notadamente de natureza constitucional. Nesse contexto, o absolutismo foi sustentado por teorias políticas e religiosas que atribuíram ao rei poderes ilimitados, de origem divina, permitindo-lhe controlar um exército permanente e instituir um sistema tributário centralizado, conforme a clássica formulação de Jean Bodin acerca da soberania indivisível do poder estatal (Bodin, 2011).

Entretanto, com a eclosão das revoluções burguesas e a difusão da ideologia liberal — em especial a partir das Revoluções Inglesa, Francesa e Norte-Americana —, o modelo absolutista entrou em colapso, dando lugar ao processo de formação do Estado Liberal. Eric Hobsbawm analisa esse período como um momento de profundas rupturas políticas e sociais, no qual a ascensão da burguesia e a institucionalização do constitucionalismo liberal redefiniram os limites do poder estatal e afirmaram novos paradigmas de organização política baseados na liberdade individual e na legalidade (Hobsbawm, 2012).

O Estado Liberal representou, assim, a expressão institucional dos ideais iluministas e permaneceu hegemônico até o final do século XIX, quando passou a enfrentar críticas

crescentes em razão das desigualdades sociais produzidas pelo desenvolvimento capitalista. Norberto Bobbio sustenta que tais contradições evidenciaram os limites do liberalismo clássico e impulsionaram a transição para o Estado Social de Direito, marcado pela ampliação das funções estatais e pela incorporação de políticas públicas voltadas à promoção do bem-estar social e à mitigação das desigualdades estruturais (Bobbio, 2017).

Esse novo paradigma buscou organizar a economia, proteger os grupos sociais mais vulneráveis e garantir a prestação de serviços públicos capazes de mitigar as desigualdades estruturais. Todavia, em muitos contextos, o Estado Social degenerou em políticas públicas de caráter meramente assistencialista, sem enfrentar de forma estrutural as causas das desigualdades sociais.

Posteriormente, com a intensificação das lutas políticas e a valorização da democracia como forma de concretização da soberania popular, consolidou-se o paradigma do Estado Democrático de Direito, que articulou os elementos do Estado de Direito com a centralidade da participação democrática (Baracho, 1988). Esse modelo não se limitou à mera justaposição formal dessas categorias, mas representa um conceito inovador, dotado de potencial transformador do *status quo*, ao incorporar princípios democráticos, participativos e emancipatórios.

O Estado Democrático de Direito inaugurou, desse modo, um novo paradigma de cidadania plena, marcado pelo reconhecimento do *status processualis* no âmbito do Direito Constitucional. No Brasil, tal modelo foi expressamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que consagrou a democracia, os direitos fundamentais e a justiça social como pilares do ordenamento jurídico.

Todo esse processo histórico de rupturas paradigmáticas e de reconfiguração das formas estatais produziu impactos significativos no setor produtivo e nas relações de trabalho, fazendo emergir o capitalismo, cujo desenvolvimento ocorreu entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, sobretudo na Europa Ocidental.

Para Braudel (1996), o capitalismo nasceu nas “dobras” do mundo feudal, não rompendo de forma imediata com as estruturas anteriores, mas desenvolvendo-se paralelamente a elas até substituí-las progressivamente. Esse sistema, por meio da *lex mercatoria*, foi capaz de reorganizar profundamente as relações comerciais, dando origem a uma complexa rede industrial e mercantil de alcance global.

Wallerstein (2001), por sua vez, sustenta que a ideia de progresso operou como elemento legitimador do capitalismo, justificando a mercantilização generalizada da vida social e

obscurando seus efeitos negativos sob o argumento de que os benefícios econômicos superariam os prejuízos sociais e humanos.

A consolidação definitiva do capitalismo, contudo, ocorreu com a Revolução Industrial, iniciada no Reino Unido e posteriormente difundida para a Alemanha e outros países europeus a partir do final do século XVIII. Esse processo revolucionou as relações de trabalho, promoveu a ascensão da indústria moderna e transformou profundamente os modos de produção, gerando a necessidade de novos mercados, fontes de matérias-primas e formas de energia.

A Revolução Industrial representou a transição para novos processos produtivos na Grã-Bretanha, na Europa continental e nos Estados Unidos, incluindo a substituição dos métodos manuais pela produção mecanizada, o desenvolvimento de processos químicos e metalúrgicos, o uso de energia a vapor e hidráulica, a criação de novas máquinas e ferramentas e a consolidação do sistema fabril mecanizado. Como consequência, a produção em massa acelerou a circulação de mercadorias e intensificou a busca por mercados consumidores (Hobsbawm, 2012).

Nesse contexto, a expansão do capitalismo passou a depender da incorporação de novos territórios dotados de matérias-primas abundantes e de mão de obra barata, geralmente escravizada, o que resultou em processos sistemáticos de dominação, exploração e subordinação, lançando as bases históricas das desigualdades globais que persistem no sistema econômico internacional contemporâneo.

José Luiz Quadros de Magalhães (2012) articula uma leitura histórico-crítica da modernidade ocidental, em chave decolonial, ao conectar a conquista da América, a violência colonial e a formação do capitalismo como sistema econômico mundial.

Em 1492, Cristóvão Colombo começa a invasão das Américas (nome dado pelos invasores europeus). Chegando nestas terras começa o processo de extermínio, assassinio, torturas e o encobrimento que durou mais de quinhentos anos até os movimentos indígenas assumirem o poder na Bolívia e se organizarem e conquistarem espaços e direitos em outros estados americanos.

A invasão do mundo, começando pela América é fundamental para o desenvolvimento do sistema econômico criado pelos europeus: o capitalismo. Não haveria capitalismo e o poderoso processo de industrialização da Europa (incluindo EUA mais tarde) sem as riquezas retiradas das Américas (ouro, cobre, prata, madeira e diversas outras riquezas do subsolo, solo e subsolo) inicialmente, assim como as riquezas da Ásia e África. Não haveria tampouco capitalismo sem instituições modernas: a moeda nacional; os bancos nacionais; os exércitos nacionais (para invadir e retirar as riquezas dos outros); a polícia nacional (especialmente para vigiar e punir os excluídos do sistema socioeconômico); o direito nacional e a religião nacional como mecanismo de uniformização de valores construindo uma massa uniformizada que se transformará nos consumidores de hoje (que devem gostar das mesmas coisas, especialmente automóveis e marcas de diversos produtos). (Magalhães, 2012. p.19)

Dessa forma, a expansão do capitalismo constituiu o fundamento histórico, econômico e político que possibilitou e impulsionou o colonialismo, o qual se expressou por meio de relações assimétricas de dominação, controle e exercício de autoridade de um Estado sobre outros territórios e povos submetidos à condição colonial. O colonialismo não se configurou apenas como um fenômeno político-territorial, mas como uma engrenagem central do sistema capitalista em formação, voltada à apropriação de riquezas, à exploração do trabalho e à subordinação estrutural das sociedades colonizadas (Wallerstein, 2001).

O período de maior expansão do colonialismo coincide com a transição para o Estado Moderno, entre os séculos XV e XVI, quando as potências europeias — especialmente Portugal e Espanha — deram início à colonização do continente americano. Esse processo esteve diretamente associado à busca por metais preciosos, recursos naturais estratégicos e novas rotas comerciais, integrando os territórios colonizados a uma economia-mundo em expansão, sendo a incorporação das Américas ao sistema mundial condição indispensável para a consolidação do capitalismo histórico, ao fornecer os insumos materiais e humanos necessários à sua expansão inicial, conforme a análise de longa duração proposta por Braudel (1996).

Para garantir sua permanência e domínio sobre os territórios conquistados, os colonizadores instituíram colônias sustentadas por rígidos mecanismos de coerção militar e controle político, acompanhados da imposição de ordenamentos jurídicos, estruturas administrativas e formas de governo alheias às realidades locais. A dominação colonial também se expressou pela imposição religiosa, cultural e epistemológica, que deslegitimou os saberes, as cosmologias e as formas de organização social dos povos originários. Nesse sentido, Quijano (2005) destaca que o colonialismo instituiu uma matriz de poder baseada na classificação racial da população mundial, naturalizando hierarquias e desigualdades que ultrapassaram o período colonial formal.

A violência colonial, portanto, não se limitou à exploração econômica dos territórios e das populações submetidas, mas produziu efeitos profundos, estruturais e duradouros sobre a história, as identidades coletivas e as formas de organização social dos povos colonizados. Conforme assinala Dussel (1993), a modernidade europeia constituiu-se simultaneamente ao processo colonial, de modo que o ideal de progresso que fundamentou o projeto moderno foi indissociável da negação da alteridade, da expropriação territorial e da objetificação dos corpos colonizados.

A relação entre colonizador e colonizado, longe de se constituir como um vínculo humano ou civilizatório, estruturou-se a partir de práticas sistemáticas de violência, coerção e desumanização. Aimé Césaire descreve com contundência essa dinâmica ao afirmar que, no

contexto colonial, “só há espaço para o trabalho forçado, a intimidação, a pressão, a política, os impostos, o roubo, o estupro, a imposição cultural, o desprezo e a desconfiança” (Césaire, 2020, p. 24).

Para o autor, tais relações não produzem encontros humanos, mas instauram uma lógica de dominação e submissão que transforma o colonizador em agente da violência institucional — capataz, carcereiro, instrumento de coerção — e o colonizado em mero instrumento de produção. Daí a formulação sintética e emblemática segundo a qual “colonização = coisificação” (Césaire, 2020, p. 24).

Nesse contexto, os regimes coloniais passaram a classificar pessoas, territórios e saberes a partir de critérios raciais, culturais e econômicos, instituindo hierarquias que naturalizaram a desigualdade e legitimaram a práxis da dominação. Esse processo de classificação não apenas organizou a exploração material, mas também produziu efeitos epistemológicos e simbólicos, ao desqualificar os modos de vida, os conhecimentos e as cosmologias dos povos colonizados. Assim, a violência colonial operou simultaneamente nos planos econômico, político, jurídico e cultural, estruturando uma matriz de poder cujas permanências seguem informando as relações de subordinação no mundo contemporâneo.

Conforme sustenta Quintão Soares (2008), os Estados submetidos ao processo de colonização herdaram não apenas estruturas econômicas dependentes, mas também simulacros de organizações políticas estatais, instituições fragilizadas e excludentes, bem como constituições de caráter meramente semântico, destituídas de efetividade material. A formação estatal nos países colonizados, portanto, ocorreu de maneira subordinada, reproduzindo modelos institucionais europeus dissociados das realidades sociais, culturais e históricas locais.

No caso brasileiro, o processo de colonização teve início com a chegada dos portugueses em 1500, embora a efetiva organização do controle colonial tenha se consolidado apenas a partir da instituição das capitanias hereditárias, em 1534. O domínio colonial português estendeu-se formalmente até 1822, com a declaração da independência política do Brasil, sem que isso implicasse, contudo, a superação imediata das estruturas coloniais de poder, exploração e desigualdade, as quais permaneceram como elementos constitutivos da formação social e econômica brasileira, conforme a interpretação clássica de Caio Prado Júnior (2011).

Durante o período colonial, a economia brasileira estruturou-se em ciclos produtivos voltados prioritariamente à exploração e à exportação de recursos naturais. A primeira atividade econômica sistemática foi a extração do pau-brasil, utilizado como corante na Europa, que marcou o início da exploração predatória do território e dos povos originários (Prado Júnior, 2011). Com as expedições colonizadoras realizadas entre 1530 e 1532, a exploração do pau-

brasil cedeu espaço à economia açucareira, que se consolidou como a principal base da economia colonial até o século XVIII, organizada em grandes propriedades monocultoras e sustentada pelo trabalho escravizado.

A economia do açúcar, fortemente dependente da mão de obra escrava africana, entrou em declínio a partir da segunda metade do século XVII, em razão da perda de competitividade no mercado internacional, sobretudo diante da concorrência de holandeses, franceses e ingleses, bem como em decorrência da descoberta de jazidas auríferas no interior do território, especialmente na região das Minas Gerais, no século XVIII (Fausto, 1996).

O ciclo do ouro inaugurou uma nova fase da exploração colonial, marcada pela intensificação da economia mineradora e pela ampliação do uso da mão de obra escravizada, submetida a condições extremamente degradantes de trabalho nas lavras e minas. A mineração atraiu fluxos populacionais significativos, promoveu o surgimento de diversos núcleos urbanos e contribuiu para a ocupação do interior do território, deslocando parcialmente o eixo econômico do litoral para as regiões centrais da colônia (Holanda, 1994).

No início da colonização, a exploração do trabalho recaiu principalmente sobre os povos originários, que foram progressivamente dizimados ou submetidos a processos de expulsão e violência sistemática. Posteriormente, essa mão de obra foi substituída pela escravização em larga escala de africanos, trazidos compulsoriamente ao Brasil por meio do tráfico negreiro transatlântico.

Assim, o colonialismo representou para a América Latina e, em especial para o Brasil, a exploração dos recursos minerais, agrícolas, desapossamento dos povos originários dos seus bens, disseminação da cultura e religião local, escravidão e imposição administrativa e cultural e se estendeu-se até 1822, quando a independência política em relação a Portugal foi proclamada. Todavia, a ruptura política não implicou a superação das estruturas coloniais que historicamente organizaram a sociedade brasileira.

Com efeito, a independência não significou o fim da exploração colonial, uma vez que o Estado nacional optou por preservar elementos centrais herdados do período colonial, tais como a manutenção da forma monárquica de governo, a unidade territorial construída sob lógica autoritária, a economia agrária voltada à exportação e a continuidade da escravidão da mão de obra africana. Esses fatores evidenciam que a emancipação política ocorreu sem uma transformação estrutural das bases econômicas, sociais e raciais que sustentavam o sistema colonial.

Nesse sentido, a exploração econômica não foi interrompida ao longo do processo histórico brasileiro, limitando-se a assumir novas formas. As potências europeias e,

posteriormente, outros centros hegemônicos do sistema internacional permaneceram como protagonistas, exercendo influência decisiva sobre os rumos econômicos e políticos do país, por meio de mecanismos de dependência, subordinação e assimetria estrutural.

Conforme assinala Alejandro Medici (2020), o colonialismo não se restringiu apenas à dominação territorial direta, persistiu por meio de formas renovadas de controle e exploração, articuladas a dispositivos de poder racializados. Para o autor, a colonialismo manifesta-se em múltiplas dimensões da vida social, expressando-se, por exemplo, no racismo estrutural e ambiental, nas desigualdades de gênero e na geopolítica dos bens ambientais, revelando a permanência de hierarquias coloniais no interior das sociedades formalmente independentes.

O colonialismo actual manifesta-se em muitas áreas: racismo ambiental, género, também na geopolítica da disputa sobre bens ambientais a partir das estratégias de segurança que o definem, mais o controlo e/ou exploração no âmbito das políticas neoliberais promovidas pelas agências económico-financeiras e políticas neoliberais. Basicamente, como explicou Zaffaroni, o colonialismo nega-nos: nega-nos da afirmação a priori antropológica etnocêntrica, racista, sexista, capitalista, o nosso carácter de povos coloridos, sexuados, solidários, diversos, produto do sincretismo de todos os grupos historicamente afectados pela construção de uma modernidade colonial e excludente. Nega os nossos direitos de nos relacionarmos com a mãe terra de várias formas para satisfazer as nossas necessidades. Discutir os projectos globais de desenvolvimento e extractivismo. Nega a nossa vontade de nos integrarmos a nível regional e mundial de forma autónoma, solidária, fazendo o pluralismo e o diálogo bens em si mesmos. Nega ou afecta seriamente a nossa capacidade de autonomia e auto-governo, de nos dar as nossas mediações de coexistência e instituições mediadas culturalmente. Nega, portanto, os nossos direitos e a nossa soberania. (Medici, 2020, p.96-97)

Para Aníbal Quijano (2005), o chamado “fim formal” do colonialismo não significou a extinção das relações de exploração e dominação construídas no período colonial. Ao contrário, a Europa promoveu uma reconfiguração discursiva dessas relações, passando a sustentá-las por meio de narrativas centradas no progresso, na razão e na universalidade. Dessa forma, as estruturas de dominação colonial permaneceram em funcionamento, ainda que sob novas modalidades, expressas nas dimensões econômica, racial e epistêmica denominada colonialidade.

Segundo o autor, a colonialidade constitui um modo específico de organização do mundo, baseado na classificação hierárquica das pessoas, dos saberes e dos corpos, segundo critérios raciais e culturais impostos pela experiência histórica europeia. Nesse contexto, a hierarquia racial emerge como um elemento central da dominação colonial, operando como uma codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados, assumida pelos primeiros como fundamento das relações de poder necessárias à consolidação da conquista.

É precisamente nesse ponto que reside a relevância analítica da distinção entre “colonialismo” e “colonialidade”. Enquanto o colonialismo refere-se a um sistema histórico-

administrativo de dominação direta, a colonialidade permite compreender a persistência das formas coloniais de poder para além do encerramento formal das administrações coloniais. Trata-se de um padrão de dominação produzido e reproduzido por culturas, instituições e estruturas sociais inseridas no sistema-mundo capitalista moderno/colonial/patriarcal.

Nessa direção, Ramón Grosfoguel (2007) conceitua a colonialidade como um processo estruturante fundamental do sistema-mundo moderno/colonial, responsável por articular as regiões periféricas à divisão internacional do trabalho a partir de uma hierarquia racial e étnica que naturaliza a desigualdade e legitima a subordinação. Para o autor, o colonialismo persiste nas estruturas contemporâneas de conhecimento, poder e existência por meio da colonialidade, configurando um sistema de dominação historicamente constituído, baseado na suposta superioridade europeia e na inferiorização dos povos colonizados.

Conforme assinala Ballestrin (2013), a colonialidade extrapola o marco histórico-administrativo do colonialismo e atualiza-se sob múltiplas formas na modernidade contemporânea, permeando as estruturas sociais e institucionais. A autora identifica três dimensões fundamentais da colonialidade: poder, saber e ser, que atravessam os processos sociais mais amplos e a produção de subjetividades, evidenciando a profundidade e a persistência das hierarquias coloniais nas sociedades pós-coloniais, que analisaremos na sequência.

2.2 A colonialidade do poder: crítica a modernidade

Não há consenso absoluto na historiografia acerca dos primeiros grupos humanos que ocuparam o continente americano. Todavia, é fato histórico amplamente reconhecido que, antes da chegada dos europeus, existiam na América civilizações complexas e altamente desenvolvidas, como as astecas, maias e incas. Essas sociedades pré-colombianas apresentavam elevados níveis de organização política, econômica e cultural, além de significativas realizações técnicas e simbólicas, o que desmonta a narrativa eurocêntrica que construiu a imagem de um continente vazio, primitivo ou atrasado no momento da conquista europeia (Todorov, 1993).

O Império Inca constitui um exemplo emblemático dessa complexidade civilizatória. Tratou-se de uma das formações políticas mais extensas e organizadas da América do Sul pré-colonial, ocupando território que atualmente corresponde ao Peru, Equador, Colômbia, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina, tendo como centro político-administrativo a cidade de Cusco.

Do ponto de vista técnico e material, a civilização inca destacou-se pelo domínio da engenharia, da arquitetura em pedra e da organização do trabalho coletivo, aspectos observáveis de forma paradigmática na cidade de Machu Picchu. As construções monumentais, realizadas sem o uso de argamassa, revelam profundo conhecimento geográfico, estrutural e ambiental, bem como uma racionalidade produtiva ajustada às condições naturais da Cordilheira dos Andes (Rostworowski, 2023). Esses elementos desafiam diretamente a concepção colonial que associa modernidade, ciência e técnica exclusivamente à experiência europeia.

De modo semelhante, o Império Asteca desenvolveu-se na região da Mesoamérica, abrangendo o território correspondente ao atual centro do México até áreas da Guatemala, entre os séculos XIV e XVI. No início do século XVI, sua população era estimada em aproximadamente quinze milhões de habitantes. A sociedade asteca caracterizava-se por uma organização política centralizada e fortemente hierarquizada, sustentada por uma economia agrícola altamente produtiva, por intensas atividades comerciais e por um sistema militar expansionista (León-Portilla, 1987).

A civilização Maia, por sua vez, desenvolveu-se nas regiões da Península de Yucatán, no México, bem como em territórios hoje correspondentes a Honduras, Guatemala e Belize. Estruturada em cidades-Estado, possuía centros urbanos relevantes, como Calakmul, Tikal e Copán, com população estimada em até 1,5 milhão de pessoas. Os maias dominaram técnicas avançadas de irrigação, engenharia e arquitetura em pedra, responsáveis pela construção de templos, pirâmides e palácios monumentais, além de apresentarem notáveis avanços nos campos da matemática e da astronomia. Tais realizações atestaram o elevado nível de sofisticação técnica e simbólica dessa civilização, profundamente impactada pelo processo de conquista europeia no contexto da expansão marítima ibérica protagonizada por Portugal e Espanha (Sharer; Traxler, 2006).

A despeito da pluralidade civilizatória que existiu no continente americano, a colonização da América Latina estruturou-se predominantemente como um modelo de colônia de exploração, orientado para o abastecimento dos mercados externos. Tal modelo baseou-se na apropriação intensiva dos recursos naturais e econômicos dos territórios colonizados, bem como na utilização sistemática de mão de obra indígena e africana escravizada, em benefício direto das metrópoles europeias.

Nesse sentido, a exploração colonial materializou-se, de forma concreta, na extração de recursos naturais estratégicos, como ouro e prata, e na produção de gêneros agrícolas voltados à exportação — a exemplo do açúcar, do tabaco e, posteriormente, do café — cultivados em grandes unidades produtivas. Esse arranjo econômico esteve sob a hegemonia das potências

coloniais europeias, especialmente Espanha, Portugal, França e Inglaterra, responsáveis pela ocupação, controle e reorganização dos extensos territórios latino-americanos segundo os interesses do mercado internacional (Prado Junior, 2011).

Conforme analisa Quijano (2005), a posição privilegiada adquirida pela Europa com a América, mediante o controle do ouro, da prata e de outras mercadorias produzidas pelo trabalho gratuito de indígenas, negros e mestiços, permitiu aos europeus disputar e consolidar o controle do comércio mundial. A monetarização progressiva do mercado global, impulsionada pelos metais preciosos americanos, possibilitou o domínio das redes de intercâmbio que conectavam regiões como China, Índia, Ceilão, Egito e o Oriente Médio, concentrando o controle do capital comercial, do trabalho e dos recursos produtivos no mercado mundial.

Dessa forma, a história da América Latina foi marcada por profundas influências externas, de modo que sua formação política, econômica e social ocorreu sob intensas interferências estrangeiras, especialmente europeias. A dominação patrimonialista incidiu sobre todas as esferas da vida social, resultando na construção de paradigmas baseados na racionalidade europeia como modelo universal.

Segundo Enrique Dussel (1993), o processo de conquista da América não se restringiu à dominação territorial, mas implicou a colonização da própria vida cotidiana dos povos indígenas e, posteriormente, dos africanos escravizados. Tal dinâmica operou por meio da negação radical da alteridade e da imposição de um modelo civilizatório europeu erigido como parâmetro universal de humanidade. Nesse sentido, a América Latina constituiu-se historicamente como a grande colônia da Europa moderna, integrada de forma estruturalmente subordinada ao projeto de expansão do capitalismo e da racionalidade ocidental.

O autor descreve esse movimento expansionista como legitimado por uma retórica moral e civilizatória que encobria a violência constitutiva da própria modernidade europeia. Em nome da civilização, da razão e de um suposto ideal universal de humanidade, a alteridade foi sistematicamente aniquilada, e as fronteiras do mundo europeu foram violentamente ampliadas para incorporar outros povos a uma ordem hierarquizada e controlada.

A partir dessa leitura crítica, o autor sustenta que o marco fundacional da modernidade europeia não se encontra no Iluminismo, mas na invasão da América, momento em que se institui uma racionalidade que se legitima pela subalternização do outro. Nesse processo, a categoria raça emerge como um dos principais fundamentos ideológicos da dominação colonial, operando como mecanismo de legitimação das hierarquias sociais impostas pela conquista.

Aníbal Quijano (2005) demonstra que a expansão colonial europeia deu origem a um novo padrão global de poder, fundado na naturalização das relações de superioridade europeia.

A raça converteu-se no eixo organizador das relações sociais, estruturando a distribuição do trabalho, do prestígio, da autoridade e do conhecimento. Esse padrão, denominado colonialidade do poder, sobrevive ao fim do colonialismo formal, enraizando-se nas estruturas sociais, institucionais e epistêmicas das sociedades modernas.

Walter Mignolo (2017) corrobora com a referida afirmação, uma vez que para o autor a colonialidade constitui o lado mais obscuro e estrutural da modernidade. Para o autor, modernidade e colonialidade formam um binômio inseparável, no qual a afirmação da modernidade europeia depende da subordinação e do apagamento de outras histórias, epistemologias e formas de existência. Essa crítica é aprofundada por Maldonado-Torres (2008), ao sustentar que o discurso moderno oculta a centralidade da experiência colonial em sua própria constituição, apresentando-se como universal e atemporal. Ao fazê-lo, invisibiliza as condições históricas, geopolíticas e coloniais que possibilitaram sua emergência, naturalizando relações de dominação e exclusão.

Santiago Castro-Gómez (2005) complementa essa análise ao afirmar que a modernidade opera como uma máquina geradora de alteridades, que, em nome da razão e da ciência, exclui a hibridez, a multiplicidade e a contingência das formas concretas de vida. Longe de promover um universalismo efetivo, a racionalidade moderna institui fronteiras epistêmicas rígidas que hierarquizam culturas e saberes.

Nesse sentido, a colonialidade do poder configura-se como um padrão duradouro de dominação que articula raça, trabalho, conhecimento, gênero e autoridade, sustentando as relações globais de dependência entre Norte e Sul Global. Trata-se de um elemento estruturante do sistema-mundo capitalista moderno, cuja origem histórica remonta à experiência colonial americana (Quijano, 2005).

Rita Segato (2021) destaca que a teoria da colonialidade do poder reposiciona a raça como categoria central de análise, evidenciando seu papel estratégico na expropriação de valor e na organização da hierarquia global. A classificação racial cristaliza-se como fundamento da nova ordem mundial, estruturando categorias como negro, indígena, branco, Europa e América em uma lógica de poder assimétrica.

Por fim, Quijano (2005) esclarece que a classificação social baseada na raça funciona como mecanismo permanente de distribuição dos sujeitos na estrutura social do trabalho, reproduzida continuamente pela colonialidade do poder. Dessa forma, a modernidade europeia revela-se inseparável da dominação colonial, sendo a colonialidade não uma consequência tardia, mas sua condição fundacional e permanente do poder.

2.3 Da colonialidade do saber: conhecimento eurocentrado e a supressão de epistemes locais

O eurocentrismo consolidou uma hierarquia epistêmica global que posiciona o Norte Global como o espaço legítimo de produção da ciência, da racionalidade e do conhecimento universal, ao passo que relega o Sul Global à condição de objeto de estudo, de campo empírico ou de mera fonte de dados a serem interpretados a partir de referenciais externos.

Essa assimetria não se configura como uma simples preferência cultural ou epistemológica, mas como um sistema estruturado de poder, responsável por organizar a produção do saber, a construção das narrativas históricas e a própria configuração das relações internacionais. Conforme sustenta Aníbal Quijano, o eurocentrismo opera como uma racionalidade hegemônica que universaliza a experiência histórica europeia e a impõe como parâmetro exclusivo de validade do conhecimento, produzindo a subalternização sistemática de outros saberes e modos de existência (Quijano, 2005).

Tal perspectiva privilegia acontecimentos, processos e atores vinculados à experiência europeia, conferindo-lhes centralidade explicativa e normatividade histórica, enquanto marginaliza, silencia ou distorce as contribuições de outras civilizações, como as africanas, asiáticas, ameríndias e árabes. O resultado é a consolidação de uma narrativa histórica seletiva, que invisibiliza trajetórias alternativas de desenvolvimento social, político e científico e reduz a pluralidade das experiências humanas a um único eixo civilizatório.

Essa hierarquização epistêmica sustenta uma narrativa linear e evolucionista da história, segundo a qual o progresso da humanidade seria o desdobramento natural e exclusivo da experiência europeia e de seus projetos coloniais. Tal leitura reforça a ideia de que a modernidade constitui um estágio superior e universal da evolução social, desconsiderando as violências, rupturas e assimetrias que marcaram sua expansão global.

Nesse sentido, Laender (2005) observa que o início do colonialismo europeu nas Américas não representou apenas um acontecimento político ou econômico isolado, mas inaugurou uma nova forma de organizar o mundo. Tratou-se de um processo simultaneamente material e simbólico, que envolveu não apenas a dominação territorial e populacional, mas também a imposição de um modo específico de pensar, de produzir conhecimento e de narrar a história. Assim, o colonialismo instituiu padrões duradouros de poder e saber que continuam a moldar as estruturas epistêmicas e políticas do mundo contemporâneo.

Com o início do colonialismo na América inicia-se não apenas a organização colonial do mundo mas – simultaneamente – a constituição colonial dos saberes, das

linguagens, da memória e do imaginário. Dá-se início ao longo processo que culminará nos séculos XVIII e XIX e no qual, pela primeira vez, se organiza a totalidade do espaço e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do planeta, presentes e passados – numa grande narrativa universal. Nessa narrativa, a Europa é – ou sempre foi – simultaneamente o centro geográfico e a culminação do movimento temporal. Nesse período moderno primevo/colonial dão-se os primeiros passos na articulação das diferenças culturais em hierarquias cronológicas e do que Johannes Fabian chama de a negação da simultaneidade. Com os cronistas espanhóis dá-se início a “massiva formação discursiva de construção da Europa/Ocidente e o outro, do europeu e o Índio, do lugar privilegiado do lugar de enunciação associado ao poder imperial. (Lander, 2005, p. 10)

A partir dessa lógica, o que passou a ser assumido pelas ciências sociais como tempo histórico universal corresponde, na realidade, ao tempo europeu, isto é, à experiência histórica particular da modernidade ocidental elevada à condição de parâmetro universal. Tal operação resultou na exclusão sistemática dos saberes indígenas, africanos, camponeses e populares, frequentemente classificados como não científicos, irracionais ou atrasados. O conhecimento moderno europeu foi universalizado, enquanto tudo aquilo que dele divergisse foi relegado ao campo da ignorância, da superstição ou da não cientificidade.

No plano epistemológico, o eurocentrismo manifestou-se por meio da imposição de critérios, métodos e paradigmas de pesquisa derivados da tradição científica europeia, apresentados como neutros e universais, em detrimento de formas de conhecimento produzidas em contextos culturais distintos. Essa dinâmica reforça hierarquias epistêmicas e contribui para a desvalorização de saberes locais, configurando aquilo que a literatura decolonial denomina colonialidade do saber.

A colonialidade do saber revela um padrão persistente de dominação epistêmica que continua operando mesmo após o fim formal do colonialismo. Um legado estrutural do eurocentrismo que dificulta a compreensão do mundo a partir das realidades concretas e das epistemes próprias dos povos historicamente subalternizados. Esse processo resulta na destruição, marginalização ou silenciamento sistemático de saberes não ocidentais, fenômeno que Boaventura de Sousa Santos (2010) define como epistemicídio, caracterizado pela supressão de conhecimentos locais, muitas vezes por meio da imposição violenta ou institucional de um cânone epistêmico dominante.

A colonialidade do saber, portanto, não se limita ao passado colonial, mas constitui um eixo estruturante da modernidade, perpetuando desigualdades no campo da produção do conhecimento. A expansão das formas europeias de saber consolidou a hegemonia epistêmica do ocidente, projetando em escala global conceitos, imagens e representações elaboradas no interior da cultura europeia para classificar, hierarquizar e subordinar povos não europeus. Essa expansão das fronteiras europeias, impulsionada pela colonização, esteve associada ao

desenvolvimento de revoluções científicas que ampliaram o domínio sobre a natureza e a cultura, tanto nos territórios metropolitanos quanto coloniais, mantendo os países periféricos em uma posição estrutural de subordinação epistêmica.

O conhecimento produzido pelos povos subjugados foi historicamente situado em um campo de conflito e enfrentou a hostilidade do processo colonizador. A consolidação da prática científica europeia e de seus projetos epistemológicos resultou na desqualificação sistemática de outros modos de conhecer, considerados incompatíveis com os parâmetros da racionalidade moderna. Lander (2005), em diálogo com Castro-Gómez (2005), chama atenção para os desafios que precisam ser superados na produção do conhecimento, especialmente na América Latina, onde o principal obstáculo reside na necessidade de uma efetiva descolonização das ciências sociais e da filosofia.

Importa destacar que essa hierarquização epistêmica não se restringe ao campo acadêmico, mas exerce influência direta sobre políticas públicas, produção científica e formulação de respostas a crises globais. Durante a pandemia de COVID-19, a colonialidade do saber manifestou-se de forma contundente, especialmente na definição das agendas de pesquisa, no acesso desigual à informação científica e na elaboração das estratégias de enfrentamento da crise sanitária, evidenciando as assimetrias estruturais do sistema internacional do conhecimento.

Compreender a colonialidade do saber e suas consequências, particularmente no contexto da pandemia de COVID-19, torna-se fundamental para repensar os modelos de governança global da saúde. No caso brasileiro, essa reflexão implica o fortalecimento da ciência nacional, a valorização de epistemologias locais e a construção de políticas de cooperação internacional mais horizontais, capazes de romper com padrões históricos de subalternização científica e tecnológica.

Superar o eurocentrismo não significa negar as contribuições da experiência europeia, mas reconhecer que elas constituem apenas uma parte de um mosaico mais amplo de histórias e epistemologias. Esse movimento exige a ampliação dos horizontes interpretativos, a valorização de múltiplas formas de conhecimento e a promoção de uma narrativa global que reconheça a interdependência e a pluralidade das sociedades humanas. Trata-se de um desafio simultaneamente intelectual e político, fundamental para a construção de um mundo mais equitativo, no qual nenhuma região se imponha como centro absoluto de verdade.

Nesse contexto crítico, Walter Mignolo (2008) afirma que a desobediência epistêmica constitui condição necessária para a descolonização do conhecimento, propondo o conceito de

geopolítica do conhecimento como estratégia para criar espaços de enunciação situados fora da lógica eurocêntrica, nos quais saberes “outros” possam dialogar de forma horizontal.

Nelson Maldonado-Torres (2008) amplia esse debate ao incorporar a dimensão ontológica da crítica decolonial, ressaltando que a colonialidade do saber está intrinsecamente vinculada à colonialidade do ser, isto é, à desumanização dos sujeitos colonizados. Assim, a descolonização do conhecimento implica, necessariamente, uma descolonização ontológica, voltada à restauração da dignidade e da humanidade dos sujeitos epistemicamente negados.

A colonialidade do saber evidencia, portanto, o modo como o conhecimento moderno se constituiu a partir da exclusão sistemática de outros modos de pensar e existir. O desafio contemporâneo reside em pensar uma descolonização crítica e dialógica, que reconheça as interdependências históricas e os hibridismos culturais, sem abdicar da luta por justiça epistêmica. Assim, o debate sobre a colonialidade do saber não se esgota na denúncia da dominação, mas aponta para a reconstrução de epistemologias plurais e interconectadas, capazes de compreender o mundo a partir de múltiplas experiências históricas, linguísticas e ontológicas.

2.4 A colonialidade do ser: desumanização das populações periféricas

A colonialidade do ser constitui uma das dimensões centrais do pensamento decolonial latino-americano, ao lado da colonialidade do poder e da colonialidade do saber. Tal categoria foi sistematizada, sobretudo, por Nelson Maldonado-Torres (2007), que buscou evidenciar como a experiência colonial ultrapassa as esferas econômica, política e epistêmica, incidindo diretamente sobre a própria constituição ontológica do sujeito moderno. Nessa perspectiva, a colonialidade não se limita à organização externa das relações sociais, mas infiltra-se nas formas de existência, de subjetivação e de reconhecimento do humano.

Em termos analíticos, a colonialidade do ser refere-se à negação sistemática da humanidade plena dos sujeitos colonizados, produzindo formas de desumanização que os situam em uma condição ontológica inferior. Trata-se de uma dimensão existencial da dominação moderna, na qual determinados corpos, vidas e experiências são desqualificados, tornados descartáveis ou invisíveis, legitimando práticas de violência, exploração e exclusão. Assim, a colonialidade do ser revela como a modernidade ocidental instituiu hierarquias ontológicas que continuam a operar no presente, condicionando quem pode ser reconhecido como plenamente humano e quem permanece situado nas zonas de não-ser.

Segundo Maldonado-Torres (2007a) a constituição do mundo moderno está intrinsecamente vinculada a um novo padrão de dominação e exploração que surgiu com a expansão da rota comercial atlântica, no qual raça e capitalismo se articulam de forma indissociável. A partir das reflexões sobre modernidade, colonialidade e espacialidade, Nelson Maldonado-Torres desenvolveu o conceito de colonialidade do ser, aprofundando a crítica decolonial ao demonstrar que a dominação colonial não se limita apenas às esferas do poder e do conhecimento.

Para o autor, se a colonialidade do poder organiza hierarquias socioeconômicas e políticas, e a colonialidade do saber regula a produção e a legitimação do conhecimento, a colonialidade do ser incide diretamente sobre a condição ontológica dos sujeitos colonizados, produzindo processos sistemáticos de desumanização e negação da humanidade plena. Assim, a colonialidade do ser revela o caráter profundamente ontológico da experiência colonial, evidenciando que a modernidade se constitui não apenas por estruturas materiais e epistêmicas, mas também pela produção de hierarquias de existência que persistem no mundo contemporâneo.

Ao dialogar diretamente com Aníbal Quijano (2005) e Walter D. Mignolo (2008), Maldonado-Torres (2007a) reconhece que sua formulação deriva das reflexões desses autores sobre a modernidade e a colonialidade, bem como sobre a maneira pela qual o mundo moderno se estruturou a partir da colonização. Essa matriz colonial organiza a vida social por meio de hierarquias raciais (superioridade/inferioridade), da divisão internacional do trabalho (centro/periferia), da configuração eurocêntrica do Estado e da imposição de um regime de conhecimento que privilegia a ciência e a racionalidade ocidentais. A colonialidade do ser emerge, assim, como a camada mais profunda dessa estrutura de dominação.

Portanto, a colonialidade do ser pode ser compreendida como o nível mais radical da dominação colonial, na medida em que atua sobre a subjetividade, a identidade e a autocompreensão dos sujeitos colonizados, internalizando a lógica da inferiorização. Dela decorre a necessidade de uma descolonização ontológica, isto é, de um processo capaz de reconstruir o ser para além dos parâmetros impostos pela modernidade colonial, restaurando a humanidade negada aos sujeitos subalternizados.

Nesse sentido, o conceito de colonialidade do ser responde à necessidade de esclarecer os efeitos da colonialidade na experiência vivida, e não apenas no plano cognitivo ou ideológico. Maldonado-Torres (2007a) destaca que essa noção dialoga profundamente com a fenomenologia e a filosofia existencial, ao mesmo tempo em que aponta seus limites eurocêntricos quando confrontadas com a experiência da subalternidade racial e colonial.

Conforme o autor, a reflexão sobre a colonialidade do ser, oferece uma chave interpretativa fundamental para compreender os vínculos entre a ontologia ocidental e o projeto colonial moderno, revelando que a própria noção de ser foi historicamente associada à exclusão de determinados sujeitos da plena condição humana.

O autor demonstra, que o colonialismo não apenas oprime econômica e socialmente, mas afeta profundamente os modos de ser e de existir dos sujeitos colonizados. Seu esforço teórico busca analisar como o ser colonizado experimenta o mundo e, simultaneamente, superar os limites eurocêntricos das tradições filosóficas clássicas. Ao articular a colonialidade do ser à ética da alteridade de Levinas e à filosofia da libertação de Dussel, Maldonado-Torres evidencia que a questão do ser na filosofia ocidental está, ainda que de forma velada, imbricada no projeto colonial que define quem tem o direito de existir plenamente.

Nesse ponto, a contribuição de Frantz Fanon (2008) revela-se fundamental, pois demonstra como o colonialismo e o racismo produzem uma verdadeira ferida ontológica, na qual o sujeito negro ou colonizado é levado a duvidar de sua própria humanidade. No mundo branco, afirma o autor, o homem negro experiencia o próprio corpo como um campo de negação, evidenciando que a colonização não apenas explora ou domina, mas nega a humanidade do sujeito colonizado, excluindo-o da categoria de “ser”. Por essa razão, Maldonado-Torres (2007a) reconhece o pensamento de Fanon como um dos primeiros diagnósticos filosóficos da desumanização enquanto estrutura permanente da modernidade colonial.

Pode-se afirmar, assim, que Frantz Fanon é um precursor da noção de colonialidade do ser, uma vez que sua análise fenomenológica do racismo e da desumanização colonial abriu caminho para as formulações posteriores de Maldonado-Torres e de outros pensadores decoloniais. Ao revelar que o colonialismo opera simultaneamente sobre o corpo, a mente e o ser, Fanon (2008) demonstra que a modernidade europeia é inseparável da negação do outro e que a libertação não pode ocorrer apenas no plano político ou econômico, devendo alcançar necessariamente o plano ontológico.

No contexto brasileiro, o traumatizante contato com o mundo branco, mediado pela irracionalidade do racismo, evidencia as marcas profundas deixadas pela colonialidade do ser na população negra, especialmente no período pós-abolição. Marina de Mello e Souza (2012) chama atenção para a condição da população negra após o fim formal da escravidão, destacando que negros e mestiços foram majoritariamente mantidos nos segmentos mais desfavorecidos da sociedade, não apenas em razão da precariedade educacional herdada, mas também pela preferência sistemática por pessoas brancas na ocupação dos postos de trabalho.

Neuza Santos Souza (1983), ao analisar os efeitos psicológicos e sociais do racismo estrutural no Brasil, evidencia que mesmo nos processos de ascensão social, a população negra permaneceu marginalizada das oportunidades educacionais e profissionais, em virtude da ausência de políticas reparatórias e da persistência do racismo institucional. Suas reflexões contribuíram para compreender que a desumanização não se limita a uma estrutura política ou epistêmica, mas constitui uma ferida ontológica que atravessa o corpo e a subjetividade dos sujeitos racializados.

Desse modo, a negação ontológica que relega o sujeito colonizado à zona do “não-ser” expressa a desumanização que estrutura sua experiência histórica e existencial. O racismo colonial inscreve-se profundamente no modo de ser, sentir e existir dos sujeitos subalternizados, tornando indispensável a busca por caminhos de superação que passem pela consciência crítica, pela reconstrução identitária e pelas múltiplas formas de resistência ontológica, política e epistemológica.

3 O DIREITO HUMANO À SAÚDE SOB O OLHAR CRÍTICO DECOLONIAL

Após a crise econômica, social e política na Europa, ocasionada pelas guerras mundiais, os direitos humanos passaram a adquiriram notoriedade. A magnitude das atrocidades cometidas durante os conflitos, com violação massiva da dignidade da pessoa humana, revelou os limites do Estado soberano e a necessidade de instituir mecanismos universais de proteção da pessoa humana, independentemente da nacionalidade, etnia, religião ou ideologia. Portanto, era necessário um legado de normatividade internacional e geopolíticas para a humanidade.

Assim, a necessidade de se garantir a todos os seres humanos o respeito e consideração por parte do Estado fez implementar mecanismos mais eficazes de controle dos atos estatais, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno, apresentando-se como uma condição *sine qua non* para que os direitos não se tornem meras declarações retóricas.

Não obstante, como resposta direta às atrocidades perpetradas durante os conflitos armados e à destruição institucional e humana promovida pelos regimes autoritários ao longo da primeira metade do século XX, instituiu-se a Organização das Nações Unidas (ONU), culminando, em 1948, na proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Esse marco normativo internacional teve como eixo estruturante a positivação do princípio da dignidade da pessoa humana, concebido como fundamento axiológico da ordem jurídica internacional contemporânea.

A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana passou a ser expressamente reconhecida nas constituições dos Estados democráticos, sobretudo por meio da incorporação dos valores e princípios consagrados na Declaração Universal de 1948 (Sarlet, 2015). Nesse contexto, tal princípio consolidou-se como um dos pilares centrais do direito contemporâneo, servindo de base normativa e interpretativa para a estruturação e a proteção dos direitos fundamentais.

O princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, pressupõe o reconhecimento do direito à saúde como condição indispensável à realização plena da existência humana. A compreensão exige uma interpretação ampliada desse direito, de modo a abarcar não apenas a ausência de enfermidades, mas o pleno bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Reconhece-se, assim, que a efetivação da dignidade humana depende da garantia de condições materiais, sociais e institucionais mínimas que assegurem uma vida saudável.

Nessa perspectiva, o direito à saúde, enquanto direito fundamental, articula-se diretamente com o constitucionalismo contemporâneo e com o sistema internacional de direitos

humanos, inserindo-se no rol dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Tal reconhecimento reflete o processo histórico de superação do Estado Liberal de Direito e a consolidação do paradigma do Estado Social de Direito, no qual se impõe ao poder público o dever de atuação positiva para a promoção do bem-estar coletivo.

Desse modo, a promoção e a proteção da saúde encontram-se intrinsecamente vinculadas à afirmação dos direitos humanos, constituindo elementos indispensáveis para a construção da cidadania plena. Os direitos humanos, nessa acepção, não devem permanecer no plano meramente declaratório ou utópico, mas efetivar-se como garantias concretas da dignidade, da liberdade e da igualdade de todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição social ou crença. Nesse contexto, o direito à saúde destaca-se como um direito fundamental essencial à edificação de uma sociedade mais justa, equitativa e solidária.

Todavia, a partir da segunda metade do século XX, sobretudo com o desenvolvimento das teorias decoloniais latino-americanas, intensificaram-se as críticas ao caráter eurocêntrico que historicamente permeia o discurso dos direitos humanos. Autores vinculados ao pensamento decolonial passaram a questionar a pretensa universalidade desse paradigma, ao evidenciar que, em diversos aspectos, ele reproduz e legitima estruturas coloniais de poder, saber e dominação.

Analisar os direitos humanos sob uma perspectiva decolonial implica, portanto, problematizar criticamente sua universalidade abstrata e repensá-los como um projeto em permanente construção, aberto à diversidade epistemológica, cultural e ontológica dos povos historicamente subalternizados. A abordagem demanda, ainda, a reconstrução pluriversal dos direitos humanos, orientada por uma interculturalidade crítica e pela valorização de múltiplas formas de existência, conhecimento e racionalidade.

3.1 A construção histórica dos direitos humanos no mundo

A construção contemporânea dos direitos humanos resulta de um longo e complexo processo histórico, profundamente marcado pela matriz eurocêntrica da modernidade ocidental. Embora frequentemente apresentados como conquistas universais e progressivas da humanidade, os direitos humanos emergem de um contexto histórico específico, associado ao projeto político, filosófico e econômico da Europa moderna. Tal projeto, ao mesmo tempo em que proclamava valores como liberdade, igualdade e dignidade, conviveu com práticas

estruturantes de dominação, tais como o colonialismo, a escravidão e o racismo, o que evidencia as contradições fundantes do discurso universalista dos direitos humanos.

Historicamente, os direitos humanos podem ser compreendidos como os valores mais significativos da convivência humana, constituindo um processo contínuo de afirmação e vigilância destinado a conter abusos de poder e assegurar a dignidade da pessoa humana, independentemente de nacionalidade, etnia, religião, sexo ou qualquer outra condição. Não se trata de um catálogo fixo ou definitivo de direitos, mas de um conjunto dinâmico, cuja conformação depende do contexto histórico, das transformações sociais, do desenvolvimento tecnológico e do surgimento de novas demandas decorrentes da evolução da vida em sociedade. Assim, os direitos humanos expandem-se e se reconfiguram à medida que novas formas de vulnerabilidade e exclusão são socialmente reconhecidas (Guerra, 2023).

Do ponto de vista conceitual, pela perspectiva internacionalista ou universalista, os direitos humanos correspondem àqueles previstos em tratados, pactos, declarações e convenções internacionais. Já sob a perspectiva constitucionalista ou positivista, são compreendidos como direitos fundamentais positivados nas Constituições dos Estados soberanos, legitimados pela soberania popular e considerados essenciais à vida digna (Lamounier; Magalhães, 2021). Essas duas perspectivas não se excluem, mas se complementam, refletindo a complexidade do processo de institucionalização dos direitos humanos nos planos interno e internacional.

Com relação a evolução histórica dos direitos humanos, esta não se deu de forma linear ou cumulativa, mas foi marcada por rupturas, disputas e tensões permanentes entre ideais normativos e realidades concretas de poder. No resgate de sua construção histórica, observa-se que, durante a Idade Média, em um contexto de fragmentação do poder político e supremacia da Igreja Católica, as concepções sobre direitos estavam fortemente subordinadas à moral religiosa. A dignidade humana era concebida como atributo inerente à criação divina, mas sua aplicação permanecia limitada por critérios como estamento social, gênero e etnia. Ainda assim, mesmo em um cenário de autocracia e hierarquização social, surgiram movimentos embrionários de reivindicação de liberdades, como a Declaração das Cortes de Leão, de 1188, e, posteriormente, a Magna Carta inglesa, de 1215, que passaram a impor limites iniciais ao poder soberano (Villey, 2007).

A Magna Carta, firmada entre o rei João Sem Terra e os barões feudais, representou um marco relevante na limitação do poder monárquico, ainda que inicialmente restrita à aristocracia fundiária inglesa. Embora não consagrasse direitos individuais no sentido moderno, o documento passou a ser interpretado como expressão de princípios gerais de legalidade, da

submissão do soberano à lei e da existência de direitos que deveriam ser respeitados pelo Estado. Consolidou-se, assim, a ideia de que existem direitos fundamentais cuja observância se impõe ao poder político, mesmo em regimes não democráticos, conforme Quintão Soares, (2000).

Com o Renascimento e a Reforma Protestante, a Europa ingressou em um processo de transição que levou à formação dos Estados nacionais modernos, caracterizados pela centralização do poder político. O feudalismo cedeu espaço à monarquia absoluta, cuja legitimação se apoiava na concepção do poder divino dos reis. Para Maluf (2022), o absolutismo monárquico possuía raízes em tradições políticas antigas, como as concepções assírias e hebraicas, e foi considerado, à época, condição necessária para a unificação territorial e política dos Estados. Contudo, o caráter ilimitado desse poder passou a ser progressivamente questionado a partir do século XVII, com o surgimento das primeiras formulações institucionais de limitação do poder estatal.

Nesse contexto, a *Petition of Right*, de 1628, estabeleceu que o rei não poderia impor tributos sem autorização do Parlamento, nem privar indivíduos de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Posteriormente, a *Habeas Corpus Act*, de 1679, proibiu as prisões arbitrárias, e o *Bill of Rights*, de 1689, reduziu de forma significativa o poder autocrático da monarquia inglesa, consolidando garantias fundamentais que se tornariam pilares do constitucionalismo moderno (Ramos, 2018).

No século XVIII, sob a influência do Iluminismo, intensificaram-se as formulações teóricas sobre direitos naturais, universais e inalienáveis. Pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu sustentaram que todos os indivíduos possuíam direitos intrínsecos à condição humana, tais como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Essas ideias exerceram profunda influência sobre documentos políticos fundamentais, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, que, além de marcar a ruptura com a Grã-Bretanha, reconheceu a soberania popular como fundamento do poder político e inaugurou uma nova etapa de proteção do indivíduo frente ao Estado, ainda que, na prática, tais direitos fossem restritos por critérios de raça, gênero e propriedade (Guerra, 2023).

Na Europa, o processo revolucionário francês culminou, em 26 de agosto de 1789, com a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, considerada um dos marcos fundacionais dos direitos humanos modernos. O documento, composto por um preâmbulo e 17 artigos, definiu direitos naturais e imprescritíveis, como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, além de afirmar a igualdade perante a lei e o princípio da separação dos poderes. Apesar das contradições internas da Revolução Francesa

e da posterior elaboração de outras declarações em 1793 e 1795, foi o texto de 1789 que se consolidou como referência normativa e simbólica para o constitucionalismo liberal, influenciando constituições e declarações de direitos em diversos países da Europa e da América Latina (Quintana, 2008; Soares, 2000).

No século XIX, iniciou-se o processo de internacionalização dos direitos humanos, impulsionado pelas transformações políticas, econômicas e sociais decorrentes da industrialização e dos conflitos armados de grande escala. Os primeiros marcos desse processo foram o Direito Internacional Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho (Lamounier; Magalhães, 2021). Em 1864, a Convenção de Genebra estabeleceu normas internacionais destinadas à proteção de combatentes feridos, doentes e da população civil em conflitos armados, consolidando o Direito Internacional Humanitário como um limite à atuação dos Estados em situações de guerra (Borges, 2006). Trata-se de um ramo dos direitos humanos voltado à humanização dos conflitos armados e à proteção dos mais vulneráveis, atuando em estreita articulação com a Cruz Vermelha Internacional (Soares, 2000).

Após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, com o objetivo de preservar a paz e a segurança internacionais por meio da cooperação entre os Estados. Embora limitada em sua eficácia, a Liga deixou como legado a criação da Corte Permanente de Justiça Internacional e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), voltada à promoção da justiça social e à proteção internacional dos direitos trabalhistas, por meio da fixação de normas relativas à jornada de trabalho, ao combate ao trabalho infantil, à proteção da mulher, à segurança no trabalho e à liberdade sindical.

O término da Segunda Guerra Mundial e a revelação das atrocidades cometidas pelo regime nazifascista impulsionaram a consolidação do sistema internacional contemporâneo de direitos humanos. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja Carta consagrou, em seu preâmbulo, o respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos fundamentais e, em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que sedimentou a ideia de uma ética universal fundada na indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (Guerra, 2023).

A DUDH tornou-se referência normativa e axiológica para o direito internacional e constitucional contemporâneo, influenciando constituições democráticas, tratados internacionais e decisões judiciais em escala global. Conforme Bobbio (2004), a chamada “era dos direitos” representa uma mudança paradigmática na história da humanidade, ao estabelecer os direitos humanos como fundamento legítimo do poder político e limite à atuação do Estado.

Nesse mesmo sentido, Cassese (2005) destaca a centralidade da Declaração Universal na formação do direito internacional dos direitos humanos, enquanto Piovesan (2023) sustenta que seus princípios adquiriram força jurídica vinculante, impondo aos Estados-membros da ONU o dever de promover e proteger os direitos nela consagrados.

A partir desse marco, consolidaram-se instrumentos internacionais e sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, como o europeu, o africano, o interamericano e o árabe, dotados de mecanismos próprios de supervisão e jurisdição. Esses sistemas buscam garantir a efetividade dos direitos humanos no plano regional, sendo suas cortes competentes para julgar violações e proferir decisões de caráter definitivo (Lamounier; Magalhães, 2021).

Não obstante os avanços normativos e institucionais, é imprescindível reconhecer que o discurso universalista dos direitos humanos se desenvolveu em íntima articulação com o projeto da modernidade europeia, o qual, paradoxalmente, conviveu com práticas de dominação colonial, exploração econômica e hierarquização racial. Essa contradição revela os limites históricos do universalismo clássico dos direitos humanos e impõe a necessidade de uma leitura crítica, capaz de dialogar com perspectivas decoloniais e com as experiências históricas dos povos subalternizados, cujas vozes foram sistematicamente silenciadas no processo de construção do direito internacional moderno.

3.2 O Direito Humano à saúde e as marcas da colonialidade

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 1948, consagrou, em seu artigo 1º, os princípios da igualdade, da dignidade e da fraternidade como fundamentos ético-jurídicos indispensáveis à convivência humana. A afirmação da igualdade entre os povos pressupõe a inexistência de distinções baseadas em raça, cor, sexo, língua, religião ou qualquer outra condição, constituindo um pilar normativo para a consolidação de direitos essenciais à humanidade. Trata-se de uma formulação que pretende universalizar a proteção da pessoa humana, ao menos no plano normativo, como resposta às barbáries e violações sistemáticas ocorridas ao longo da primeira metade do século XX.

Nesse contexto, a DUDH passou a reconhecer expressamente a saúde como um direito humano, ao assegurar, em seu artigo 25, o direito de toda pessoa a um padrão de vida adequado capaz de garantir saúde e bem-estar, compreendendo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Ao vincular a saúde às condições materiais de existência, a Declaração ampliou sua compreensão para além da ausência de doença,

associando-a à redução das desigualdades sociais e à promoção da dignidade humana (Organização das Nações Unidas, 1948).

Dentre os direitos consagrados no pós-guerra, a saúde passou a ocupar posição central como elemento estruturante da dignidade da pessoa humana e condição indispensável para o exercício dos demais direitos fundamentais. A partir dessa concepção ampla e indivisível, os direitos humanos passaram a assegurar a saúde como um direito fundamental inegociável, cuja efetivação exige não apenas prestações estatais diretas, mas também políticas públicas capazes de enfrentar determinantes sociais, econômicos e históricos da doença e da exclusão.

Conforme assinala Sueli Gandolfi Dallari (1988), a reivindicação do direito à saúde é relativamente recente, apesar de sua inserção no rol dos direitos humanos. Para a autora, a compreensão do direito à saúde demanda o resgate da própria evolução histórica dos direitos humanos, uma vez que sua formulação moderna está intrinsecamente ligada à ampliação do conceito de dignidade humana e à incorporação dos direitos sociais como direitos fundamentais exigíveis do Estado.

Como desdobramento desse processo, em abril de 1945, durante a Conferência de São Francisco que culminou na criação da Organização das Nações Unidas (ONU), representantes do Brasil e da China propuseram a criação de uma organização internacional específica para a saúde, bem como a convocação de uma conferência destinada à elaboração de sua constituição. Essa iniciativa resultou na criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), cuja Constituição foi adotada em 1946 e entrou em vigor em 1948, consagrando a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social” e reconhecendo seu caráter de direito humano fundamental (Organização Mundial da Saúde, 2024).

A partir da atuação da OMS, a saúde passou a ser concebida como um serviço de caráter universal, devendo ser garantido com qualidade e equidade a todos os povos. A organização assumiu papel central na coordenação de ações globais voltadas ao enfrentamento de doenças, epidemias e emergências sanitárias, bem como na produção de conhecimento científico, na qualificação de profissionais da saúde, na catalogação internacional de doenças e na disseminação de políticas e campanhas de saúde pública.

A consolidação da saúde como direito humano fundamental também foi reforçada com a adoção em 1966, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Pacto atribuiu caráter jurídico vinculante aos direitos sociais, impondo aos Estados-partes o dever de adotar medidas progressivas para sua efetivação, com especial atenção à saúde, ao trabalho e à educação.

O artigo 12 do PIDESC reconhece o direito de toda pessoa ao mais elevado nível possível de saúde física e mental, vinculando sua realização à melhoria das condições de vida, à prevenção de doenças e ao acesso universal a serviços de saúde.

[...]

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar:
 - a) A diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento das crianças;
 - b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente;
 - c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças;
 - d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. (Organização das Nações Unidas, 1966, art. 12)

Por intermédio do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), os direitos humanos começaram a expandir os benefícios para a cidadania, implementando as medidas necessárias que deveriam ser cumpridas pelos países signatários, incluindo o Brasil. O PIDESC ampliou a compreensão dos direitos humanos ao estabelecer que os direitos econômicos, sociais e culturais são fundamentais para a dignidade humana e que os países deveriam adotar medidas progressivas para garantir a sua efetivação (Guerra, 2023).

Nos anos seguintes, o direito à saúde novamente assumiu centralidade no cenário internacional, especialmente após a assinatura da Declaração de Alma-Ata, em 1978. Este acordo internacional reafirmou a saúde como um direito humano básico, universal e de responsabilidade dos governos, destacando os cuidados primários de saúde como a estratégia essencial para alcançar o bem-estar de todos, especialmente nos países em desenvolvimento (Organização Mundial da Saúde, 1978). A Declaração de Alma-Ata abordou a saúde pública de forma integral, reconhecendo que a saúde das populações resulta de uma interação complexa entre fatores políticos, sociais e culturais, e que a erradicação da pobreza e a promoção de integração regional e internacional eram cruciais para a melhoria da saúde (Organização Mundial da Saúde, 1978).

Essa perspectiva ampliou a compreensão dos direitos humanos e da saúde, ao associar a melhoria das condições de vida, o acesso a serviços médicos e a implementação de políticas públicas de saúde com a construção da cidadania e a promoção da justiça social entre todos os povos. É a partir dessa concepção que o direito à saúde passa a ser essencial para garantir a dignidade humana e reduzir as desigualdades sociais.

No Brasil, o direito à saúde foi incorporado de maneira expressa à Constituição Federal de 1988, com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, e com a garantia do direito à saúde no artigo 6º, que integra a saúde aos direitos sociais fundamentais, ao lado de outros direitos como educação, trabalho e segurança. A Constituição também deixa claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme expresso no artigo 196, ao assegurar que o Estado deve garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde por meio de políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (Brasil, 1988).

Dessa forma, o direito à saúde é apresentado não apenas como um direito individual, mas como um dever coletivo, que exige a ação do poder público para garantir condições dignas de vida e o acesso à saúde de qualidade. A Constituição Brasileira, ao integrar a saúde ao núcleo essencial de direitos sociais, evidencia o compromisso do Estado em garantir o bem-estar social por meio de políticas públicas que promovam a equidade e a justiça social (Esquivel; Ramos, 2015).

É possível concluir que o direito humano à saúde constitui um dos pilares estruturantes da dignidade da pessoa humana, consolidando-se como um ideal ético, político e jurídico voltado à proteção da vida. Todavia, a efetivação desse direito desenvolveu-se ao longo de uma trajetória histórica profundamente marcada pela colonialidade, o que comprometeu a concretização material de sua universalidade.

Nesse sentido, embora na contemporaneidade a saúde seja formalmente proclamada como um direito universal, tal universalidade foi — e ainda é — construída a partir de uma matriz eurocêntrica, que não logrou superar as desigualdades estruturais e as hierarquias herdadas do colonialismo. Essa lógica repercute diretamente na persistência de assimetrias no acesso aos serviços de saúde e na manutenção de profundas disparidades sanitárias entre o Norte e o Sul Global.

A construção histórica do direito à saúde como dimensão dos direitos humanos carrega, portanto, as marcas da modernidade colonial. Conforme assinala Boaventura de Sousa Santos (2007), apesar do processo de universalização jurídica dos direitos humanos no período pós-Segunda Guerra Mundial, o sistema internacional permaneceu ancorado em referenciais epistemológicos e políticos do Norte Global, relegando à marginalidade os saberes, as experiências e as concepções de saúde oriundas de povos historicamente subalternizados. Tal cenário evidencia que a universalidade proclamada no plano normativo não se traduziu, de forma equitativa, em universalidade material, mantendo-se, até os dias atuais, um padrão excludente de proteção do direito à saúde.

Para Marilena Chauí e Boaventura de Souza Santos (2013), a racionalidade biomédica ocidental, ao se tornar hegemônica, exclui outros saberes, como os tradicionais, indígenas e africanos, que são considerados irracionais e não científicos. Essa divisão entre "ciência" e "ignorância" é um reflexo do pensamento abissal, uma estrutura epistemológica que ainda perpassa o sistema internacional e que limita a efetivação de um direito à saúde verdadeiramente universal e inclusivo.

De acordo José Luiz Quadros de Magalhães (2013), o projeto de modernidade ocidental, ao afirmar ideais de liberdade e igualdade, ao mesmo tempo sustentou hierarquias raciais e culturais que subalternizaram grande parte da humanidade. Para Magalhães, o Estado moderno necessitou da "uniformização" de valores e da "padronização" de pessoas para viabilizar seu projeto hegemônico. Esse processo, por sua vez, ainda influencia as relações de poder e a distribuição de direitos no cenário global, especialmente no campo da saúde.

A colonialidade, portanto, não se limita ao período colonial histórico, mas persiste, de modo mais sutil, nas estruturas que regulam o acesso à saúde e a definição de quem são os “sujeitos” de direitos. Enquanto a modernidade e seus ideais de direitos humanos se afirmavam na Europa, este mesmo espaço geopolítico sustentava práticas de escravidão, genocídios indígenas e imperialismo econômico, evidenciando a contradição de um sistema que, ao mesmo tempo, proclamava a dignidade humana enquanto subordinava milhões de vidas ao sistema de exploração colonial (Magalhães, 2013).

Portanto, não obstante os avanços normativos e institucionais alcançados no campo do direito à saúde, o conceito hegemônico que o orienta permanece profundamente vinculado a uma matriz moderna e eurocêntrica, alicerçada na racionalidade biomédica ocidental. Tal racionalidade, ao se afirmar como paradigma universal de cientificidade e legitimidade, opera mecanismos sistemáticos de exclusão epistemológica, invisibilizando e desqualificando outros modos de produzir conhecimento e cuidar da saúde.

Conforme analisa Chauí e Santos (2013), esse fenômeno pode ser compreendido como expressão do pensamento abissal moderno, que institui uma linha de separação radical entre o “lado de cá” da ciência, da técnica e da civilização — espaço no qual se situam os saberes médicos ocidentais — e o “lado de lá”, no qual são relegados os saberes populares, indígenas, africanos e tradicionais, classificados como não científicos, irracionais ou inferiores:

Concebo as versões dominantes da modernidade ocidental como construídas a partir de um pensamento abissal, um pensamento que dividiu o mundo entre sociedades metropolitanas e coloniais. Dividiu-o de tal modo que as realidades e práticas existentes do lado de lá da linha, nas colônias, não podiam pôr em causa as universalidades das teorias e práticas que vigoravam na metrópole, do lado de cá da linha. E, nesse sentido, eram invisíveis. Ora enquanto discurso de emancipação, os

direitos humanos foram historicamente concebidos para vigorar apenas do lado de cá da linha abissal, nas sociedades metropolitanas. Tendo vindo a defender que esta linha abissal, que produz exclusões radicais, longe de ter sido eliminada com o fim do colonialismo histórico, continua sob outras formas (neocolonialismo, racismo, xenofobia, permanente estado de exceção nas relações com terroristas, trabalhadores imigrantes indocumentados, candidatos a asilo ou mesmo cidadãos comuns vítimas de políticas de austeridade, ditada pelo capital financeiro). O direito internacional e as doutrinas convencionais dos direitos humanos tem sido usados como garantes dessa continuidade. (Chauí; Santos, 2013, p. 43-44)

Essa clivagem epistemológica produziu o que Boaventura de Sousa Santos denomina epistemicídio, entendido como o processo sistemático de destruição, silenciamento e deslegitimação das formas de conhecimento locais e não hegemônicas, especialmente aquelas oriundas dos povos historicamente colonizados. Tal processo está intrinsecamente associado à expansão da modernidade colonial, que não apenas impôs um modelo único de racionalidade, mas também subordinou cultural e politicamente outras formas de existência e de produção de saber.

Nessa mesma direção, Nelson Maldonado-Torres (2008) assinala que a colonialidade se manifesta na negação da plena humanidade dos povos colonizados, operando uma desqualificação ontológica que inferioriza suas identidades, seus corpos e seus modos de vida, produzindo efeitos duradouros de desumanização que ultrapassam o período formal do colonialismo.

A crítica decolonial ao direito moderno é aprofundada por Alejandro Médici, ao demonstrar que a pretensa universalidade dos direitos humanos reproduz a lógica racial constitutiva da modernidade. Segundo o autor, o direito internacional e o próprio discurso dos direitos humanos universais foram historicamente construídos a partir de um sujeito específico, branco, europeu, masculino e proprietário cuja experiência foi elevada à condição de paradigma universal de humanidade. Desse modo, a universalização dos direitos humanos se edificou sobre a exclusão racial, cultural e política dos povos colonizados e racializados, convertendo a igualdade formal em um instrumento de reprodução das hierarquias globais (MÉDICI, 2020).

A autora Lynn Hunt (2009) a origem histórica dos direitos humanos, relata que eles não são naturais ou atemporais, mas construções sociais e culturais surgidas no contexto das transformações políticas e intelectuais do século XVIII. Nesse contexto, a noção de universalidade dos direitos humanos passa a ser objeto de questionamento crítico, na medida em que os parâmetros de humanidade, civilização e racionalidade impostos pelo Norte Global foram naturalizados como universais, invisibilizando outras cosmologias, experiências históricas e projetos de vida.

Tal universalismo abstrato, ao ignorar as desigualdades estruturais e os legados coloniais, reforça assimetrias de poder e dificulta a efetivação substantiva dos direitos nos contextos periféricos. É nesse sentido que Joaquín Herrera Flores (2009), ao desenvolver uma crítica latino-americana aos direitos humanos, sustenta que tais direitos devem ser compreendidos como produtos culturais, historicamente situados e inseparáveis das relações sociais, políticas e econômicas nas quais se constituem.

Para o autor, o discurso da universalidade dos direitos humanos constitui um paradoxo a ser superado, pois, ao se afirmar como neutro e universal, desconsidera a pluralidade cultural e as experiências históricas dos povos não europeus, especialmente aqueles marcados pelas dinâmicas coloniais. Assim, os direitos humanos não são dados naturais ou categorias abstratas, mas construções históricas resultantes de processos de luta por dignidade, emergindo das práticas sociais e das resistências dos grupos subalternizados.

Nessa perspectiva, Herrera Flores concebe os direitos humanos como um campo em permanente construção, articulado a saberes locais, práticas coletivas e a uma ética de solidariedade global, dialogando diretamente com a proposta de Marilena Chauí e Boaventura de Sousa Santos (2013) de uma teoria plural e intercultural dos direitos humanos. Ambos convergem na defesa de um paradigma que reconheça a diversidade epistêmica e cultural como condição para a efetivação concreta da dignidade humana.

Dessa forma, embora a saúde seja reconhecida, no plano normativo, como um direito humano fundamental e elemento central da dignidade e da justiça social, sua efetivação revela profundas contradições históricas e estruturais. Tais contradições evidenciam as marcas persistentes da colonialidade nas estruturas sociais, políticas e epistêmicas do mundo contemporâneo, especialmente na definição dos saberes legítimos, das políticas públicas prioritárias e dos sujeitos efetivamente contemplados pelo direito à saúde.

3.3 Descolonizar o Direito humano à Saúde: desafios para uma justiça global e intercultural

Historicamente, o direito humano à saúde, tal como positivado nos principais instrumentos internacionais de direitos humanos, deriva das concepções de bem-estar social consolidadas no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse período, a saúde passou a ser reconhecida como elemento essencial da dignidade humana e

como responsabilidade dos Estados, integrando o núcleo dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Todavia, a construção histórica do direito humano à saúde, embora frequentemente apresentada como uma conquista civilizatória da modernidade, não se deu por meio de um processo neutro, universal ou desprovido de assimetrias de poder conforme analisado anteriormente. Ao contrário, sua consolidação esteve profundamente imbricada nas estruturas políticas, econômicas e epistemológicas da modernidade ocidental, que, ao mesmo tempo em que proclamava um humanismo global, manteve e reproduziu um paradigma eurocêntrico de humanidade, racionalidade e saber. Assim, a universalização normativa dos direitos humanos não implicou a superação das hierarquias coloniais, mas, em muitos casos, contribuiu para sua resignificação e perpetuação.

Nesse sentido, Marilena Chauí e Boaventura de Sousa Santos relataram que, embora os direitos humanos tenham se consolidado como o discurso hegemônico da dignidade humana, essa hegemonia convive com uma realidade paradoxal: a maior parte da população mundial não é efetivamente sujeito de direitos humanos, mas objeto de discursos produzidos em seu nome. Para o autor, trata-se de um universalismo abstrato que não alcança materialmente aqueles situados fora do eixo central do sistema-mundo moderno (Chauí; Santos, 2013).

A crítica à universalidade abstrata dos direitos humanos é aprofundada por Joaquín Herrera Flores, que propõe compreendê-los não como categorias jurídicas fixas ou naturais, mas como processos culturais e históricos de luta pela dignidade. Para o autor, os direitos humanos — entre eles o direito à saúde — emergem das práticas sociais e das resistências dos grupos subalternizados, sendo inseparáveis do contexto histórico e cultural em que se desenvolvem. Sob essa perspectiva, a efetivação do direito à saúde exige a construção de um modelo verdadeiramente universal e equitativo, fundado na valorização da pluralidade epistêmica e no reconhecimento de diferentes saberes e práticas locais de cuidado, o que pressupõe a superação da racionalidade colonial e a adoção de uma abordagem decolonial e intercultural (Herrera Flores, 2009).

Ainda nessa direção crítica, Boaventura de Sousa Santos chama atenção para um limite estrutural da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao reconhecer apenas o indivíduo e o Estado como sujeitos de direitos. Segundo o autor, os povos somente são reconhecidos juridicamente quando transformados em Estados, o que revela a persistência de uma lógica colonial, sobretudo se considerado que, à época da elaboração da Declaração, numerosos povos encontravam-se sob dominação colonial ou sequer possuíam reconhecimento estatal. Esse modelo jurídico invisibilizou formas coletivas de existência, organização e resistência,

reforçando a exclusão de sujeitos históricos do campo dos direitos humanos (Chauí; Santos, 2013).

Descolonizar o direito humano à saúde, portanto, implica ir além da universalidade abstrata do paradigma moderno é necessário avançar em direção a uma pluriversalidade, conforme propõe Walter Dignolo (2008). A pluriversalidade apresenta-se como alternativa ao universalismo eurocêntrico que dominou a produção do conhecimento e instituiu um projeto único e homogêneo de humanidade. No campo dos direitos humanos, essa perspectiva defende a coexistência de múltiplos projetos culturais, sociais e políticos, valorizando a diversidade de modos de vida, saberes e cosmologias, especialmente aquelas historicamente subalternizadas.

Nesse horizonte, o direito à saúde deve ser repensado como um campo intercultural, no qual diferentes epistemologias possam dialogar em condições de igualdade. Isso exige reconhecer que a saúde não se restringe à ausência de doença ou ao acesso a sistemas médicos institucionalizados, mas envolve modos de existir que articulam dimensões espirituais, comunitárias, territoriais, culturais e ecológicas — aspectos frequentemente invisibilizados ou deslegitimados pela racionalidade biomédica ocidental.

A partir de uma ética decolonial, Enrique Dussel sustenta que a reconstrução dos direitos humanos deve partir das vítimas da colonialidade. Para o autor, a verdadeira universalidade não pode ser imposta a partir de um centro hegemônico, mas deve emergir do diálogo entre experiências históricas diversas, especialmente aquelas situadas no Sul Global. A ética da libertação propõe, assim, um deslocamento do centro epistemológico da modernidade, possibilitando a construção de direitos humanos enraizados na realidade concreta dos povos historicamente oprimidos (Dussel, 2023).

No plano da justiça global, os desafios da descolonização do direito humano à saúde tornam-se ainda mais evidentes diante das desigualdades estruturais que marcam o sistema internacional. A concentração de recursos tecnológicos, científicos e financeiros no Norte Global, aliada à dependência econômica e tecnológica dos países periféricos, compromete a realização equitativa desse direito. As assimetrias observadas no acesso a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde revelam que a universalidade proclamada no discurso jurídico internacional convive com práticas seletivas e excludentes, que perpetuam a lógica colonial sob novas formas, evidenciando a responsabilidade das estruturas globais na produção e manutenção dessas injustiças (Pogge, 2008).

Desse modo, os direitos humanos somente poderão tornar-se efetivamente universais quando forem descolonizados, isto é, quando reconhecerem e incorporarem os saberes, práticas e modos de vida que a modernidade historicamente silenciou. No campo da saúde, essa

descolonização passa, necessariamente, pela reconstrução de uma justiça global comprometida com a superação das desigualdades estruturais do mundo moderno, resultantes de processos históricos e econômicos transnacionais como o colonialismo, o comércio internacional assimétrico e a globalização excludente.

Tal tarefa exige o reconhecimento da persistência da colonialidade do poder, que mantém o Norte global em posição de dominação econômica, política, cultural e epistêmica sobre os países periféricos. Uma justiça global decolonial, portanto, deve incluir o reconhecimento das epistemologias e dos direitos dos povos subalternizados, rompendo com a lógica eurocêntrica e universalista que historicamente moldou as instituições internacionais e os regimes globais de saúde.

Reivindicar a saúde como direito humano sob uma perspectiva decolonial implica reconhecer os processos históricos de desumanização e exclusão que moldaram a própria noção de saúde como direito universal. Implica, ainda, reconstruir o sentido dos direitos humanos como processos históricos de luta, enraizados nas experiências concretas dos povos, fundados no diálogo intercultural, na solidariedade global e no reconhecimento da interdependência entre seres humanos e ecossistemas.

Nesse contexto, a saúde deve ser compreendida como direito à vida digna em sua integralidade, indissociável da justiça epistêmica, social e ambiental. Somente assim será possível transformar o direito à saúde de um enunciado jurídico abstrato em uma prática emancipatória efetiva.

4 A PANDEMIA DA COVID-19 E A AQUISIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA ASSEGURAR O DIREITO HUMANO À SAÚDE: REFLEXOS DA COLONIALIDADE

A história da humanidade registra a ocorrência de diversas pandemias provocadas por vírus, bactérias e outros agentes infecciosos, as quais produziram elevados índices de mortalidade e desencadearam profundas repercussões de ordem social, econômica e sanitária. Esses eventos pandêmicos, ao longo do tempo, evidenciam a vulnerabilidade estrutural das sociedades humanas diante de crises epidemiológicas de grande escala.

Entre os primeiros registros históricos de pandemias de grande impacto destacam-se aquelas ocorridas na Idade Média, notadamente as chamadas febres urbanas, com ênfase na peste negra — ou peste bubônica — causada pela bactéria *Yersinia pestis*. Originária da Ásia, a enfermidade disseminou-se rapidamente pelo continente europeu a partir de meados do século XIV, em razão das rotas comerciais e das precárias condições sanitárias das cidades medievais (Franco Júnior, 2001).

O surto pandêmico da peste negra, ocorrido entre os anos de 1347 e 1351, resultou na morte de milhões de pessoas na Eurásia. A catástrofe demográfica provocou o despovoamento de extensas regiões, o colapso de atividades econômicas, bem como transformações sociais, políticas e religiosas profundas, cujos efeitos estruturais marcaram de forma duradoura a história europeia (Fanco Junior, 2001).

Após a peste negra, o mundo voltou a enfrentar uma pandemia de proporções globais com a pandemia da gripe espanhola, ocorrida entre 1918 e 1920, foi um dos mais graves eventos sanitários da história moderna, com impacto social e mortalidade elevados em diversas regiões do mundo. No contexto brasileiro, estudiosos como Schwarcz e Starling demonstram que a crise sanitária deixou profundas marcas sociais, políticas e demográficas no país. Schwarcz; Starling (2020) enfatizam que a experiência brasileira da pandemia revelou a vulnerabilidade dos sistemas de saúde da época e as respostas sociais diante do desastre epidemiológico.

Posteriormente, ao longo do século XX, a humanidade foi novamente acometida por pandemias associadas a variantes do vírus influenza, denominada gripe asiática (*Influenza A – H2N2*), originada na China e provocou milhões de mortes em escala global. O vírus Influenza A H2N2, responsável pela pandemia de 1957–1958, originou-se de vírus aviários e se espalhou amplamente entre humanos, destacando o potencial pandêmico de subtipos de influenza e a necessidade de vigilância contínua (Jones *et al.*, 2014).

Em 1981 a população mundial passou a sofrer com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida HIV/AIDS que dizimou milhões de pessoas. Em 2024, cerca de 630 mil pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS, em comparação com aproximadamente 2,1 milhões de pessoas em 2004 e aproximadamente 1,4 milhão de pessoas em 2010. A meta para 2025 é menos de 250 mil mortes (UNAIDS, 2025).

Posteriormente, foi a vez da Gripe A (H1N1) que passou a assombrar a população mundial. A pandemia da gripe H1N1 ocorreu entre 2009 e 2010, tendo a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatado que os primeiros casos ocorreram na região do México e Estados Unidos. Nesse período, foram oficializadas 18.449 mortes no mundo, em um total de 651 mil casos (Faculdade de Medicina da UFMG, 2020).

Por fim, no ano de 2019, o mundo vivenciou o surgimento da pandemia da COVID-19, cujos primeiros registros ocorreram na República Popular da China. A rápida disseminação do vírus em escala global conferiu à crise sanitária proporções inéditas, impondo aos Estados a adoção de medidas excepcionais, dentre as quais se destacou o confinamento em massa da população como estratégia de contenção da propagação da doença e de redução dos elevados índices de morbimortalidade.

No Brasil, a COVID-19 adquiriu maior gravidade a partir do mês de março de 2020. Desde então, em razão da acelerada propagação do vírus, o país passou a enfrentar profundas consequências de ordem social, econômica e sanitária, que não apenas agravaram desigualdades históricas, como também expuseram fragilidades estruturais do sistema público de saúde e dos mecanismos de proteção social.

Dentre os efeitos mais expressivos da pandemia no contexto brasileiro, destacaram-se o colapso dos sistemas de saúde em diversos entes federativos, a escassez de insumos médicos, de leitos hospitalares e de profissionais de saúde qualificados. A esses fatores somaram-se a disseminação de desinformação, a negação do conhecimento científico — inclusive por parte de autoridades governamentais — e a demora na implementação de políticas públicas eficazes.

Nesse cenário, a vacinação emergiu como o principal instrumento para a contenção da COVID-19 e a mitigação de seus impactos. No Brasil, o processo de imunização da população teve início em 17 de fevereiro de 2021 (CNN Brasil, 2021c) em um momento em que o país se encontrava no epicentro da crise, registrando números alarmantes de contaminações e óbitos decorrentes da doença.

Ocorre que a gravidade da pandemia no território nacional, somada à falta de política pública eficaz foi tamanha que, em 27 de abril de 2021, o Senado Federal instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19, com o objetivo de apurar eventuais ações e omissões

do Governo Federal no enfrentamento da emergência sanitária (Brasil, 2021h). A referida comissão revelou-se um importante instrumento institucional para a tutela dos direitos humanos, em especial do direito fundamental à saúde, bem como para a consolidação do entendimento de que o Estado possui o dever jurídico de atuar com diligência, responsabilidade e fundamentação científica na proteção da saúde pública.

4.1 A pandemia no mundo: desigualdades sanitárias

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (2021b), a pandemia de COVID-19 teve origem em Wuhan, na província de Hubei, China. Em 30 de dezembro de 2019, foi detectado um grupo de casos de pneumonia de causa desconhecida em pacientes vinculados ao Mercado de Frutos do Mar de Huanan, um local associado à venda de animais vivos, o que levantou a hipótese de uma origem zoonótica. Amostras respiratórias coletadas de pacientes confirmaram a presença de um novo coronavírus, mais tarde denominado SARS-CoV-2.

Com o surgimento de casos, o governo chinês rapidamente iniciou medidas de contenção. As autoridades de saúde pública implementaram um sistema rigoroso de rastreamento de contatos e testes em grande escala. Wuhan foi colocada em *lockdown* no dia 23 de janeiro de 2020, isolando a cidade para prevenir a disseminação do vírus para outras regiões da China e do mundo. Além de Wuhan, outras províncias da China adotaram medidas restritivas, como o fechamento de mercados, suspensão de transportes públicos e quarentena domiciliar (Organização Mundial da Saúde, 2021b).

O relatório também indicou que o vírus se espalhou rapidamente devido à alta taxa de transmissão e à circulação de pessoas, especialmente durante o período do Ano Novo Chinês, quando milhões de cidadãos viajaram por todo o país. Como resultado, o SARS-CoV-2 se disseminou para várias províncias chinesas e, subsequentemente, para o mundo inteiro (Organização Mundial da Saúde, 2021b).

Inicialmente, acreditava-se que o surto seria contido na China, como ocorreu com epidemias anteriores, como a SARS em 2002. No entanto, em janeiro de 2020, o vírus começou a se espalhar rapidamente, chegando a outros países. Com transmissibilidade elevada, os casos começaram a ser relatados na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, e, em fevereiro, surgiram os primeiros focos significativos na Europa, principalmente na Itália. Essa rápida disseminação fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

O vírus se espalhava de forma exponencial. De acordo com o portal da Organização Pan-Americana da Saúde – paho.org (2020b), em março de 2020, a OMS declarou oficialmente que o mundo enfrentava uma pandemia. Países em todo o mundo começaram a adotar medidas de contenção: fronteiras foram fechadas, voos internacionais suspensos, e milhões de pessoas foram colocadas em quarentena. A Itália, especialmente, tornou-se um epicentro, com o sistema de saúde sobrecarregado e um número crescente de mortes, como relatou o jornal El País (El País, 2020a).

Em 2020, a cidade de Bérgamo, localizada na região da Lombardia, Itália, tornou-se um dos epicentros mais devastados pela pandemia de COVID-19. Entre março e abril daquele ano, a cidade vivenciou uma crise sem precedentes, com o sistema de saúde local completamente sobrecarregado. Hospitais lotados e profissionais de saúde exaustos tentavam lidar com o número crescente de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, muitos dos quais necessitavam de ventilação mecânica. A situação foi tão crítica que caminhões militares tiveram que ser utilizados para transportar corpos para fora da cidade, pois os crematórios e cemitérios locais não conseguiam dar conta do número de mortes, como relatou reportagem de O Globo (2020).

A rápida disseminação do vírus em Bérgamo foi atribuída, em parte, a eventos esportivos e sociais realizados pouco antes das medidas de quarentena entrarem em vigor. A região da Lombardia, particularmente densa e economicamente ativa, viu-se no epicentro do surto na Itália, com milhares de vidas perdidas em poucas semanas. Bérgamo se tornou um símbolo trágico da pandemia na Europa, e suas ruas vazias e igrejas abarrotadas de caixões chocaram o mundo, levando a um esforço global para fortalecer as medidas de contenção e socorro.

Ao mesmo tempo, outras regiões começaram a enfrentar a realidade do surto em grande escala. Nos Estados Unidos, em cidades como Nova Iorque, os hospitais atingiram níveis críticos de lotação. Em países da América Latina, como o Brasil e o México, a disseminação do vírus encontrou desafios adicionais, como a falta de infraestrutura de saúde adequada para lidar com uma crise dessa magnitude.

A proliferação do vírus trouxe desafios inéditos aos sistemas de saúde, economia e relações sociais. Com as quarentenas e lockdowns, as atividades econômicas sofreram interrupções severas, levando a uma recessão global. Milhões de empregos foram perdidos, e setores como o turismo, o comércio e a aviação enfrentaram crises sem precedentes. As pessoas, por sua vez, passaram a viver sob um isolamento social forçado, causando impacto na saúde mental de milhões.

Mas somente a vacina seria capaz de estancar o avanço da doença. Assim, laboratórios e centros de pesquisa iniciaram uma corrida para desenvolver vacinas contra o novo coronavírus. Em menos de um ano, em dezembro de 2020, as primeiras vacinas começaram a ser aprovadas e distribuídas. A vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a receber autorização de uso emergencial em diversos países, seguida por outras, como a Moderna, AstraZeneca e a vacina russa Sputnik V (Organização Pan-Americana da Saúde 2020c).

No entanto, o surgimento de novas variantes do vírus, como a variante Delta e, posteriormente, a variante Ômicron, desafiou ainda mais os esforços de controle da pandemia. Essas variantes, mais transmissíveis, fizeram com que muitos países enfrentassem novas ondas de contágio, mesmo com a vacinação em curso (Agência Brasil, 2022). A população mundial, diante dessas ameaças, precisou adaptar-se a novas regras sanitárias, como o uso contínuo de máscaras, higienização das mãos e o distanciamento social prolongado.

Além das vacinas, surgiram debates sobre tratamentos eficazes para a COVID-19. Algumas drogas, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, foram alvo de controvérsia, pois, embora inicialmente defendidas por alguns líderes e médicos, não demonstraram eficácia comprovada em ensaios clínicos. O tratamento com anticorpos monoclonais e a aplicação de oxigênio e ventiladores mecânicos tornaram-se padrões de cuidado para pacientes graves, enquanto a pesquisa médica evoluía rapidamente (Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

A COVID-19 revelou desigualdades no acesso a cuidados de saúde. Em países desenvolvidos, a vacinação avançou rapidamente, enquanto em nações em desenvolvimento, muitos enfrentaram escassez de doses e dificuldades logísticas. Isso levou a um esforço global, mediado por iniciativas como o COVAX, para garantir a distribuição equitativa de vacinas em todo o mundo.

Outro impacto profundo da pandemia foi nas relações humanas e na cultura. Com o distanciamento social, muitas celebrações e eventos foram cancelados. A educação passou por uma mudança radical com a adoção do ensino à distância, o que evidenciou desigualdades no acesso à tecnologia. As relações de trabalho também mudaram, com milhões de pessoas migrando para o trabalho remoto, uma prática que, em muitos casos, se manteve mesmo após a redução das restrições.

À medida que a vacinação avançou, os números de hospitalizações e mortes começaram a cair em muitos países. No entanto, o retorno à "normalidade" mostrou-se desafiador. Novas ondas, impulsionadas por variantes, ainda provocavam surtos localizados. As viagens

internacionais, o comércio e os grandes eventos públicos começaram a ser retomados, mas com precauções redobradas, como passaportes de vacinação e testes constantes.

O impacto psicológico da pandemia também foi significativo. O isolamento prolongado, a perda de entes queridos e o medo constante de infecção levaram a um aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. O estigma associado à doença, especialmente para os infectados e recuperados, trouxe desafios adicionais à integração social.

Em 2021, com a vacinação em massa já em curso, muitos países começaram a relaxar as medidas de restrição. No entanto, a OMS e especialistas alertaram que, apesar dos avanços, a pandemia não estava completamente controlada. Novas variantes, incertezas sobre a duração da imunidade e a hesitação vacinal continuaram a representar obstáculos significativos.

Os países também enfrentaram desafios na definição de políticas de saúde pública que equilibrassem a necessidade de proteger a população com a de reativar suas economias. O conceito de imunidade coletiva, antes defendido por muitos como uma possível solução, foi revisto à medida que variantes mais transmissíveis continuavam a emergir.

O ano de 2022 foi marcado por uma tentativa global de adaptação a uma "nova normalidade". Muitos governos optaram por conviver com o vírus, ajustando suas estratégias de saúde pública de forma a minimizar os impactos, mas aceitando que o SARS-CoV-2 permaneceria circulando por algum tempo. A vacinação continuou a ser promovida, agora com doses de reforço para aumentar a proteção contra novas variantes.

A pandemia da COVID-19, além dos impactos diretos na saúde, trouxe reflexões profundas sobre como o mundo lida com crises globais. A interdependência entre nações ficou mais evidente do que nunca, assim como as fragilidades dos sistemas de saúde e a necessidade de maior cooperação internacional. A ciência também ganhou destaque, mostrando-se um dos pilares fundamentais para enfrentar desafios de tamanha magnitude.

Hoje, embora o vírus ainda esteja presente, o desenvolvimento de vacinas eficazes, medicamentos antivirais e medidas de saúde pública aprimoradas permitem que o mundo vislumbre um futuro mais seguro. No entanto, a lição mais valiosa que a pandemia deixou foi a necessidade de preparação para futuras crises e a importância da solidariedade global. A COVID-19 foi, sem dúvida, um dos maiores desafios da humanidade no século XXI, e seus efeitos continuarão a ser sentidos por anos, tanto no âmbito da saúde quanto nas esferas econômica e social.

A pandemia de COVID-19 mudou profundamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Desde o seu surgimento até sua proliferação global, vimos o mundo enfrentar uma crise sem precedentes, que exigiu respostas rápidas e inovadoras em diversas frentes. O

legado da pandemia será marcado não apenas pelas perdas, mas também pelos avanços que nos tornaram mais resilientes frente às incertezas futuras.

4.2 A pandemia da COVID-19 no Brasil: respostas normativas, impactos socioeconômicos e vulnerabilidades estruturais

Em razão da progressiva disseminação da COVID-19 em diversos países e diante dos indícios de introdução do vírus no território nacional, o Estado brasileiro publicou, em 6 de fevereiro de 2020, a Lei nº 13.979, a primeira norma jurídica destinada a disciplinar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Brasil, 2020b).

A referida lei estabeleceu diretrizes iniciais para a contenção da doença, prevendo, entre outras medidas, o isolamento social, a quarentena, a realização de estudos e investigações epidemiológicas, a exumação de corpos, a necropsia, a cremação e o manejo de cadáveres, bem como a restrição excepcional e temporária do fluxo de pessoas por rodovias, portos e aeroportos, com controle de entrada e saída, a limitação da locomoção interestadual e intermunicipal e a requisição de bens de pessoas naturais e jurídicas.

Não obstante a relevância dessas disposições normativas as medidas adotadas mostraram-se insuficientes para conter a propagação do vírus. Diante do agravamento do cenário epidemiológico, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) (Brasil, 2020d).

Além do reconhecimento formal da ESPIN, a Portaria nº 188/2020 instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de coordenação da resposta à emergência sanitária no âmbito federal. Estruturou-se, assim, um aparato voltado ao planejamento, à organização, à coordenação e ao controle das ações a serem adotadas durante a vigência da ESPIN, bem como à articulação com gestores estaduais, distritais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), à divulgação de informações à população e à elaboração de relatórios técnicos a serem submetidos ao Ministério da Saúde (Brasil, 2020d).

Apesar da adoção dessas medidas administrativas e normativas, o avanço da contaminação não foi contido. Em 26 de fevereiro de 2020, confirmou-se oficialmente o

primeiro caso de COVID-19 no Brasil, envolvendo um homem de 61 anos, residente na cidade de São Paulo, que havia retornado de viagem à região da Lombardia, na Itália, no período de 9 a 21 de fevereiro de 2020, apresentando, dois dias após o retorno, sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza (Organização Pan-Americana da Saúde, 2020).

Com o agravamento da crise sanitária e a intensificação da circulação viral, o Ministério da Saúde reconheceu, por meio da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, a ocorrência de transmissão comunitária da COVID-19 em todo o território nacional. A referida portaria determinou, como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar de pessoas com sintomas respiratórios e daqueles que residissem no mesmo domicílio, ainda que assintomáticos, pelo período máximo de quatorze dias (Brasil, 2020e).

A partir desse marco normativo, o país passou a vivenciar uma crise sanitária de grandes proporções, cujos desdobramentos extrapolaram o campo da saúde pública, impactando de forma profunda os setores econômico, educacional e o conjunto das políticas públicas.

Importa destacar que a pandemia alcançou o Brasil em um contexto de recrudescimento da pobreza, da desigualdade social e do desemprego, após um período de declínio consistente observado entre os anos de 2003 e 2014. A extrema pobreza, que atingia aproximadamente nove milhões de pessoas em 2014, alcançava cerca de quatorze milhões em 2019. Ademais, enquanto entre 2002 e 2015 a renda domiciliar dos estados mais pobres apresentou crescimento real superior a 84%, no período compreendido entre 2015 e 2019 verificou-se redução aproximada de 10%, evidenciando um processo de empobrecimento estrutural da população brasileira (Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2022).

Nesse cenário, o Brasil figurou entre os países mais severamente impactados pela pandemia do SARS-CoV-2, ocupando a terceira posição em número absoluto de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, e a segunda colocação em número de óbitos, superado somente pelos Estados Unidos. A disseminação do vírus ocorreu de forma intensa e profundamente desigual, afetando de maneira desproporcional os segmentos populacionais mais vulnerabilizados, com maiores dificuldades para cumprir protocolos sanitários, menor acesso ao saneamento básico e restrições no acesso aos serviços de saúde (Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2022).

No plano econômico, a pandemia provocou retração significativa do Produto Interno Bruto (PIB), fechamento de empresas, elevação das taxas de desemprego e ampliação da informalidade, com impactos mais severos sobre micro e pequenos empreendimentos. No ano de 2020, o país registrou o maior índice de desemprego de sua série histórica, alcançando

aproximadamente quatorze milhões de pessoas desocupadas na quarta semana de setembro, com taxa de desocupação de 14,4%. As maiores taxas foram observadas nos estados da Bahia (19,8%), Alagoas (18,6%), Sergipe (18,4%) e Rio de Janeiro (17,4%), enquanto Santa Catarina (6,1%), Rio Grande do Sul (9,1%) e Paraná (9,4%) apresentaram os menores índices (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020).

No mesmo período, o Produto Interno Bruto brasileiro apresentou queda de 3,3%, após crescimento de 1,2% em 2019. O valor adicionado bruto dos serviços retraiu-se em 3,7%, influenciado pela redução de 4,5% no consumo das famílias. Em valores correntes, o PIB alcançou R\$ 7,6 trilhões, enquanto o PIB per capita foi de R\$ 35.935,74 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020).

Além do impacto econômico, a pandemia afetou de forma drástica o setor educacional, ocasionando a suspensão das aulas presenciais a partir de março de 2020. Escolas e universidades interromperam as atividades presenciais como medida preventiva contra o contágio, passando a enfrentar o desafio da implementação do ensino remoto.

Dados do ano de 2021 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicaram que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais, sendo que 90,1% não retornaram às aulas presenciais ao longo do ano letivo de 2020 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023a).

Sendo que no âmbito do ensino superior, o relatório divulgado pelo INEP em 2022 demonstrou que a pandemia ocasionou a suspensão das atividades presenciais, alterações nos calendários acadêmicos e mudanças nas estratégias institucionais relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023b).

Para mitigar tais impactos, as Instituições de Ensino Superior (IES) foram compelidas a desenvolver estratégias emergenciais, como a adoção de atividades remotas, a capacitação docente para o uso de tecnologias digitais e a oferta de apoio psicossocial aos discentes. Ademais, cursos da área da saúde tiveram a conclusão antecipada, com vistas a reforçar a força de trabalho no enfrentamento da COVID-19, como medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023b).

As desigualdades estruturais da educação brasileira tornaram-se ainda mais evidentes durante a pandemia, revelando um sistema historicamente fragilizado e profundamente desigual. Relatório do Banco Mundial (2020) apontou que o fechamento das escolas afetou de forma desproporcional as populações mais pobres, com potenciais impactos de longo prazo na

acumulação de capital humano e nas oportunidades futuras. Segundo o referido relatório, sem medidas de mitigação, a desigualdade social tenderia a se intensificar, com a entrada de aproximadamente 7,2 milhões de brasileiros na condição de pobreza em 2020, elevando a taxa de pobreza para 22,7% da população.

Mesmo após o encerramento oficial da pandemia em 2022, a educação brasileira continuou a enfrentar desafios significativos. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (2025), divulgado em janeiro de 2025, comparou os percentuais de crianças e adolescentes com atraso escolar ou fora da escola nos anos de 2019 e 2023, evidenciando variações expressivas, sobretudo nos anos pandêmicos.

A reconstrução do setor educacional no período pós-pandemia permanece como desafio central. Especialistas alertam que a recuperação exige compromisso de longo prazo com investimentos estruturais, valorização do magistério e maior equidade no financiamento da educação básica. Em síntese, a pandemia acentuou fragilidades históricas da educação brasileira e impôs um passivo educacional significativo, que demanda respostas coordenadas, intersetoriais e sustentáveis.

No campo da saúde pública, o período pandêmico revelou múltiplos obstáculos, como a escassez de insumos, a disseminação de desinformação, a insuficiência de leitos hospitalares, a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de respiradores e de profissionais de saúde capacitados. Tais fatores contribuíram para o agravamento da crise sanitária, colocando o Brasil, em 2020, no epicentro global da pandemia.

Entre 27 de março e 31 de dezembro de 2020, foram registrados 194.949 óbitos acumulados e 7.675.973 casos confirmados de COVID-19 no país. Ao final de 2021, o número de óbitos alcançou 619.056, evidenciando uma taxa de mortalidade significativamente superior à observada em diversos outros países (Brasil, 2020-2021g).

Estudo divulgado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2020 apontou que, embora tenha havido aumento de aproximadamente 45% no número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), grande parte dessa ampliação destinou-se exclusivamente ao atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19. O país permaneceu, assim, com infraestrutura insuficiente para o atendimento de pacientes com outras enfermidades. Ademais, o estudo evidenciou profunda desigualdade na distribuição dos leitos hospitalares, com concentração majoritária na Região Sudeste e menor oferta na Região Norte (Conselho Federal de Medicina, 2020).

Os noticiários veiculados em maio de 2023 informaram que, desde o início da pandemia, aproximadamente sete milhões de pessoas morreram em decorrência da COVID-19 em todo o

mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Desse total, cerca de 10% dos óbitos corresponderam a registros realizados no Brasil, o que evidencia que, a cada dez mortes notificadas globalmente, uma ocorreu em território brasileiro (Uol, 2023).

Nesse contexto, a vacinação consolidou-se como a principal ferramenta de controle da pandemia. Em 17 de janeiro de 2021, o Brasil iniciou a imunização de sua população (CNN Brasil, 2020b) com a aplicação da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Posteriormente, outras vacinas foram incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), como AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen.

O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi formalizado por meio da Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022, expedida pelo Ministério da Saúde, após o anúncio da Organização Mundial da Saúde acerca do fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. A decisão fundamentou-se na redução consistente de casos graves, internações e óbitos, bem como na ampla cobertura vacinal alcançada no país (Brasil, 2022a).

Não obstante, a pandemia expôs de forma contundente os limites e fragilidades do sistema de saúde pública brasileiro. Embora o país disponha de um dos maiores sistemas universais de saúde do mundo, a crise evidenciou desigualdades históricas, subfinanciamento crônico, tensões federativas e limitações na gestão da emergência sanitária.

Devido todo este contexto, foi instalada, em 27 de abril de 2021, a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19, no âmbito do Senado Federal, com o objetivo de apurar ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia. Após aproximadamente seis meses de trabalhos, a CPI realizou oitivas de autoridades, especialistas, empresários e familiares de vítimas, além da análise de documentos que indicaram falhas graves na condução da crise sanitária (Brasil, 2021h).

O relatório final da CPI, concluído em 26 de outubro de 2021, recomendou o indiciamento de 78 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas, com base, entre outros fatores, nos atrasos na aquisição de vacinas, na disseminação de desinformação, na condução da crise sanitária no Amazonas, em irregularidades na tentativa de compra da vacina Covaxin, na promoção de tratamentos sem eficácia científica comprovada e na ocorrência de mortes potencialmente evitáveis (Brasil, 2021h).

Em síntese, a crise sanitária provocada pela COVID-19 aprofundou vulnerabilidades históricas da sociedade brasileira, expondo desigualdades no acesso à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico e ao trabalho. Seus efeitos econômicos, sociais e institucionais

persistem, exigindo a formulação de políticas públicas coordenadas, investimentos sociais contínuos e a reconstrução do pacto federativo em torno da saúde, da educação e da justiça social.

4.2.1 A produção mundial das vacinas e a hierarquização entre Norte e Sul Global

O panorama econômico mundial no período imediatamente anterior à crise sanitária desencadeada pela COVID-19 já apresentava sinais consistentes de desaceleração, especialmente nos países em desenvolvimento. Na América Latina, esse contexto caracterizava-se por baixo crescimento econômico, elevada desigualdade social e fiscal, altos índices de informalidade no mercado de trabalho e limitada resiliência fiscal e institucional.

Segundo o relatório *Latin American Economic Outlook 2020*, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2020), os impactos socioeconômicos da pandemia seriam sem precedentes na região, afetando todos os países latino-americanos, com projeção de retração do Produto Interno Bruto (PIB) superior a 9% em 2020 e aumento das taxas de pobreza em 4,4 pontos percentuais no mesmo período.

A crise revelou-se particularmente severa para aproximadamente 40% da força de trabalho regional, composta por trabalhadores sem acesso a mecanismos de proteção ou assistência social. Ademais, micro e pequenas empresas — responsáveis por parcela expressiva da geração de empregos — não dispunham de capacidade financeira para absorver a mão de obra diante do fechamento de milhões de estabelecimentos, o que implicou a perda estimada de 8,5 milhões de postos de trabalho. Estudos da OCDE indicaram ainda que cerca de 60% dos trabalhadores da América Latina atuavam na informalidade e estavam expostos ao risco de retorno à pobreza, sendo que, antes mesmo da pandemia, aproximadamente 40% encontravam-se desprotegidos, sem cobertura de sistemas de seguridade social (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2020).

No campo da saúde, o dossiê produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (2022) evidenciou que, no período imediatamente anterior à pandemia, os países em desenvolvimento já apresentavam fragilidades estruturais significativas, tais como insuficiência das ações de vigilância epidemiológica, deficiências na assistência aos infectados e aos enfermos, precariedade na proteção dos trabalhadores da saúde e incapacidade de assegurar provisão adequada de medicamentos, equipamentos e insumos, especialmente no que se refere ao acesso equitativo a vacinas.

Nesse contexto, a pandemia da COVID-19 atingiu a América Latina em um momento de fragilidade econômica, social e institucional, comprometendo tanto a resposta sanitária quanto a capacidade de recuperação econômica.

Além das questões econômicas e sociais, somou-se a incapacidade política e tecnológica dos países do Sul Global em lidar com a crise sanitária, em especial o Brasil, que no combate a pandemia revelou descoordenação institucional, minimização da gravidade da doença, atrasos na adoção de medidas de contenção e forte polarização política, conforme analisado no capítulo anterior.

Tais fatos, levaram inclusive, no início de 2022 a uma incapacidade brasileira, de testagem para a detecção do SARS-CoV-2 na população. Considerada a relação entre o número de exames realizados e o contingente populacional, a capacidade nacional de testagem correspondia a aproximadamente 5% da verificada no Reino Unido, 10% da observada em Portugal e na França, 14% da registrada nos Estados Unidos e cerca de 20% daquela alcançada por países como Uruguai e Chile, revelando-se, inclusive, inferior à de diversos países do continente africano (Mathieu; Ritchie; Rodés-Guirão, 2022).

A somatória de todos estes fatores contribuiu para que o Brasil alcançasse elevados índices de contaminação e mortalidade, chegando a Barrucho (2020) informar no dia 19 de maio de 2020 que o Brasil ultrapassou a marca simbólica de mais de mil mortes diárias por COVID-19. O país registrou 1.179 novos óbitos em 24 horas e que ao todo já foram 17.971 óbitos por coronavírus e 271.628 casos confirmados, cujo alerta foi dado no início do mês de março a partir de um estudo liderado pelo laboratório de inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligado à Universidade de São Paulo (USP) e que o país chegou a ser o epicentro global da pandemia.

Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde (2024) assumiu papel central como instância coordenadora, técnica e diplomática no enfrentamento da crise sanitária global. Composta por 194 Estados-membros e um corpo técnico superior a oito mil profissionais, a OMS congrega especialistas de referência mundial nas áreas de saúde pública, epidemiologia, ciência e gestão sanitária.

A OMS foi a primeira instituição internacional a emitir alerta global sobre a nova doença respiratória identificada em Wuhan, na China, e, em 30 de janeiro de 2020, declarou o surto de COVID-19 como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março de 2020, reconheceu oficialmente a pandemia, nos termos do artigo 12 do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), aprovado pela 58ª Assembleia Mundial da Saúde em 2005 e em vigor desde 2007, consolidando-se como marco fundamental da saúde pública internacional ao

fortalecer as capacidades de avaliação, coordenação e resposta a emergências sanitárias globais (Organização Pan-Americana de Saúde, 2020a).

No âmbito da pandemia da COVID-19, a vacinação foi reconhecida pela OMS como ferramenta essencial para a redução de hospitalizações, óbitos e da propagação viral, sendo o rápido desenvolvimento de vacinas considerado imprescindível para a superação da crise. Todavia, o acesso equitativo às vacinas revelou-se um dos principais desafios globais, evidenciando profundas assimetrias entre os países.

A concentração da capacidade científica, industrial e tecnológica nos países do Norte Global permitiu a essas nações exercer controle quase exclusivo sobre a produção e distribuição dos imunizantes. Em contraste, os países do Sul Global permaneceram dependentes de doações ou de acordos desiguais de aquisição, reproduzindo a lógica centro-periferia denunciada pela teoria da colonialidade do poder, conforme analisaremos no capítulo que se segue.

Entretanto, com o objetivo de se evitar o monopólio da vacina pelos países desenvolvidos, foi criado o programa Covax Facility coordenado pela OMS, Aliança Mundial para vacinas e imunizações - GAVI e a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI, em 24 de abril de 2020 (Organização Mundial da Saúde, 2025).

O Covax facility visou acelerar a fabricação, acesso rápido e equitativo às vacinas contra a COVID-19 para todos os países, independentemente do nível de renda. Portanto, o programa fez-se necessário para garantir o acesso universal e evitar que as nações entrassem em disputa pelos imunizantes, além de se reduzir o risco de grande parte da população mundial ficar desprotegida do Coronavírus. Adotou mecanismo de distribuição justa, baseado na distribuição de cotas iguais entre os países, correspondente a 20% da sua população independente de questões econômicas, o que levou a adesão dos países em desenvolvimento (Organização Mundial da Saúde, 2025).

Na corrida pelo imunizante, o primeiro país a finalizar as etapas de produção e iniciar a vacinação da sua população contra o novo coronavírus foi o Reino Unido. No dia 08 de dezembro de 2020, o Reino Unido apresentou uma vacina inédita à base de RNA mensageiro (mRNA), a BNT162b2, aprovada para uso emergencial, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech (EL PAÍS Brasil, 2020).

Apesar dos esforços, a equidade com relação a vacina revelou uma realidade diferente, tendo o canal de notícias Cable New Network (CNN, 2020c) noticiado que cinquenta e seis países iniciaram a vacinação sendo que a grande maioria dos contemplados foram os países desenvolvidos, demonstrando, assim, o acesso desigual para o combate à doença.

Em 18 de janeiro de 2021, a ONU divulgou o alerta do Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que afirmou que o mundo estava à beira de um fracasso moral catastrófico e o preço desse fracasso será pago com vidas nos países mais pobres do mundo, e que mais de 39 milhões de doses da vacina foram administradas em pelo menos 49 países de alta renda, em contrapartida, na Guiné-Conacri, país de baixa renda, apenas 25 doses foram distribuídas até o momento (Organização das Nações Unidas, 2021a).

O Our World In Data (2021) relatou que os primeiros países a serem contemplados com a vacina contra a COVID-19 foram os europeus e norte-americanos em detrimento dos países inseridos no continente africano e na América do Sul e que até 16 de fevereiro de 2021, os Estados Unidos haviam aplicado 3.019,65 doses por milhão de pessoas e a Europa, 1.711,84 por milhão de pessoas, sendo que na mesma data, 16 de fevereiro de 2021, a América do Sul havia sido contemplada com de 1.074,01 de doses por milhão de pessoas, seguida da África com 136,99 doses por milhão de pessoas.

Em 29 de outubro de 2021, a Organização Mundial da Saúde, diante das dificuldades persistentes para assegurar a equidade no acesso às vacinas contra a COVID-19, divulgou um apelo dirigido aos líderes do G20, conclamando-os a adotar medidas concretas para garantir o acesso universal não apenas às vacinas, mas também a testes diagnósticos, tratamentos e demais tecnologias essenciais para o enfrentamento da pandemia. No referido pronunciamento, destacou-se que a profunda assimetria na distribuição dos imunizantes configurava grave violação ao direito à vida das populações mais pobres e vulneráveis, ao evidenciar que, para cada 100 pessoas em países de alta renda, haviam sido administradas 133 doses de vacinas, enquanto, nos países de baixa renda, esse número se restringia a apenas quatro doses por 100 habitantes (Organização Mundial da Saúde, 2021b).

A OMS, através de seu representante legal, ressaltou, ainda, que a desigualdade vacinal não apenas custava vidas diariamente, mas também prolongava a pandemia em escala global, colocando todas as nações em risco. Segundo a organização, a história e a ciência demonstram que somente uma ação coordenada, fundada no acesso equitativo aos recursos de saúde pública, seria capaz de conter um flagelo sanitário de alcance global como a COVID-19 (Organização das Nações Unidas, 2021a).

Esses acontecimentos inserem-se no contexto das discussões que culminaram na criação do consórcio COVAX Facility, cuja finalidade era assegurar a distribuição equitativa de vacinas em escala global. Todavia, a implementação prática desse mecanismo revelou-se aquém do pactuado. Reportagem divulgada pela CNN Brasil em 2 de janeiro de 2022, apontou que os atrasos nas doações decorreram, em grande medida, da priorização, pelos países desenvolvidos,

da aplicação de doses de reforço em suas próprias populações. Conforme noticiado, os Estados Unidos haviam se comprometido a doar 587,5 milhões de doses, mas apenas 193,4 milhões foram destinadas ao COVAX, das quais somente 140,3 milhões chegaram efetivamente aos países em desenvolvimento (Landim, 2022).

Na mesma data, a CNN Brasil informou que a União Europeia havia anunciado a disponibilização de 451,5 milhões de doses, porém apenas 298,3 milhões foram repassadas ao COVAX, sendo que somente 57,8 milhões foram efetivamente distribuídas e aplicadas. Situação semelhante ocorreu com o Reino Unido, que, embora tivesse prometido 100 milhões de doses, entregou apenas 26,2 milhões ao consórcio. Esses dados evidenciam o descumprimento parcial dos compromissos assumidos e a manutenção de profundas desigualdades no acesso aos imunizantes (Landim, 2022)

O agravamento desse cenário levou, em 1º de março de 2022, a força-tarefa de líderes multilaterais — composta pelos chefes do Fundo Monetário Internacional, do Grupo Banco Mundial, da Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial do Comércio — a publicar manifesto conjunto alertando que o acesso desigual às vacinas, testes e tratamentos continuava a prolongar a pandemia, especialmente diante da disseminação da variante Ômicron.

O documento destacou que, naquele momento, 23 países ainda não haviam vacinado sequer 10% de suas populações, enquanto 73 países não alcançavam 40% de cobertura vacinal, com perspectivas de não atingir a meta de 70% até meados de 2022. Nos países de baixa renda, majoritariamente concentrados no continente africano, apenas 7% da população estava totalmente vacinada, em contraste com 73% nos países de alta renda (Organização Mundial da Saúde, 2022b).

A crise sanitária, portanto, expôs de forma inequívoca a ausência de isonomia entre os países, revelando práticas marcadas pelo individualismo estatal, pela fragilidade da cooperação internacional e por um tratamento sistematicamente desigual entre as nações do Norte Global e aquelas situadas na África e na América Latina. Tal realidade reforça interpretações críticas fundamentadas na teoria da colonialidade do poder, segundo as quais hierarquias históricas e estruturais continuam a moldar o acesso a bens essenciais à vida.

Corroborando essa perspectiva, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2021/2022, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), evidenciou que países em desenvolvimento, historicamente submetidos a processos de colonização e exploração, foram preteridos em relação aos países desenvolvidos no acesso à imunização contra a COVID-19. O relatório aponta que tais desigualdades refletem não apenas limitações conjunturais, mas padrões estruturais de exclusão que se reproduzem em contextos de crises

globais, aprofundando assimetrias históricas entre Norte e Sul Global (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2023).

A desigualdade na aquisição de vacina para o combate a COVID-19 se entrelaça com a colonialidade, que tem como um dos eixos o capitalismo e a desigualdade social. Para Quijano (2009), a colonialidade é um dos elementos constitutivos do padrão mundial de poder capitalista, e que sempre esteve ativa uma vez que faz parte do contexto global e afeta todos os espaços de dominação, demonstrando que o fim do colonialismo não eliminou as desigualdades econômicas e políticas entre os países.

Conforme Luciana de Melo Nunes *et al.* (2023), a colonialidade foi arquitetada para ser despercebida, o que nem sempre é possível nos momentos de crise, pelo contrário, a crise pode contribuir para revelá-la como ocorreu na pandemia da COVID-19, demonstrando uma escandalosa iniquidade de acesso entre o Norte e o Sul globais às tecnologias em saúde anti-Covid-19 e nos debates e decisões para contornar o problema.

A Europa foi pioneira na aquisição de vacinas e tratamentos para o combate a pandemia, mas ignorou os países em desenvolvimentos, suas ex-colônias, o que reforça a afirmação de Quijano (2005) sobre o eurocentrismo e o domínio sobre a América Latina, seguido de países como África e Ásia.

Já em sua condição de centro do capitalismo mundial, a Europa não somente tinha o controle do mercado mundial, mas pôde impor seu domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta, incorporando-as ao “sistema-mundo” que assim se constituía, e a seu padrão específico de poder. Para tais regiões e populações, isso implicou um processo de *re-identificação histórica*, pois da Europa foram-lhes atribuídas novas identidades geoculturais. Desse modo, depois da América e da Europa, foram estabelecidas África, Ásia e eventualmente Oceania. Na produção dessas novas identidades, a colonialidade do novo padrão de poder foi, sem dúvida, uma das mais ativas determinações. (Quijano, 2005, p.121)

As afirmações de Aníbal Quijano permitem uma leitura particularmente elucidativa quando entrelaçada com o processo de aquisição e distribuição global das vacinas contra a COVID-19, na medida em que revela a permanência histórica da colonialidade no interior do sistema-mundo contemporâneo. Ao afirmar que a Europa, enquanto centro do capitalismo mundial, não apenas controlou o mercado global, mas impôs um padrão específico de poder às demais regiões, Quijano evidencia que a dominação colonial não se limitou à exploração econômica direta, mas se estruturou como um regime duradouro de hierarquização geopolítica, epistêmica e econômica.

No contexto da pandemia, essa lógica se reproduziu de forma evidente na dinâmica de produção, compra e distribuição das vacinas. Os países centrais do capitalismo global, majoritariamente localizados na Europa e na América do Norte, concentraram o controle

tecnológico, científico e produtivo dos imunizantes, bem como o acesso prioritário aos insumos farmacêuticos e às patentes. Tal controle permitiu-lhes impor, novamente, as regras do mercado mundial, estabelecendo contratos assimétricos, cláusulas restritivas e práticas de acumulação de doses (*vaccine hoarding*), enquanto países periféricos, sobretudo da África, da Ásia e da América Latina, permaneceram dependentes de doações tardias, programas multilaterais insuficientes ou negociações marcadas por forte desequilíbrio de poder.

A “re-identificação histórica” mencionada por Quijano manifesta-se, nesse cenário, na forma como determinadas regiões são implicitamente classificadas como consumidoras secundárias, destinatárias de excedentes ou de vacinas com prazos reduzidos de validade, reafirmando identidades geoculturais construídas historicamente sob o signo da subalternidade. A constituição de África, Ásia e América Latina como espaços de carência, dependência e vulnerabilidade sanitária não decorre de uma incapacidade intrínseca, mas de uma inserção estruturalmente desigual no sistema-mundo capitalista, cuja matriz colonial permanece operante.

Assim, a má distribuição global das vacinas contra a COVID-19 não pode ser compreendida apenas como falha logística ou circunstância excepcional de uma crise sanitária, mas como expressão concreta da colonialidade tal como formulada por Quijano. O acesso desigual aos imunizantes revela a continuidade de um padrão de dominação que articula economia, ciência, tecnologia e política internacional, reproduzindo hierarquias históricas e negando, na prática, o princípio da saúde como direito humano universal. A pandemia, nesse sentido, longe de romper com a lógica colonial, acabou por expô-la e aprofundá-la, reafirmando a centralidade dos países hegemônicos e a condição subordinada das regiões historicamente colonizadas.

Nesse sentido, Mbembe (2014) sustenta que a racialização e a hierarquização da vida permanecem operantes no sistema-mundo contemporâneo, definindo quais vidas são protegidas e quais são consideradas descartáveis.

Por fim a raça é uma das matérias primas com a quais fabricamos as diferenças e o excedente, isto é, uma espécie de vida que pode ser gasta ou passada sem reservas. Pouco importa se ela não exista enquanto tal e não só devido a extraordinária homogeneidade genética dos seres humanos. Ela continua produzir efeitos de mutilação, porque originariamente é e será sempre aquilo em nome do qual se operam fissuras na sociedade, se estabelecem relações do tipo guerreiro, se regulam as relações coloniais, se repatriam e se prendem pessoas cuja vidas e cuja presença são consideradas sintomas de uma condição limitada, e cuja presença é contestada porque provém nas classificações vigentes, do excedente. (Mbembe, 2014, p. 70)

O excerto de Achille Mbembe oferece uma chave interpretativa central para a compreensão da desigualdade global na distribuição das vacinas contra a COVID-19,

especialmente quando analisado à luz da colonialidade do poder e de suas continuidades no sistema internacional contemporâneo. Ao afirmar que a raça constitui uma das “matérias-primas” a partir das quais se fabricam as diferenças e o excedente, Mbembe explicita que a racialização não é um dado biológico, mas um dispositivo político e econômico de gestão da vida e da morte, por meio do qual determinadas existências são classificadas como descartáveis, passíveis de serem “gastas” sem reservas.

No contexto da pandemia, essa lógica se materializou de forma particularmente evidente na governança global da saúde. A despeito do discurso universalista que reconhece a saúde como direito humano fundamental, a distribuição das vacinas revelou a persistência de uma hierarquização racializada da vida, na qual populações situadas nos países periféricos, majoritariamente racializadas e historicamente colonizadas, foram tratadas como excedentes do sistema-mundo. A concentração inicial de doses nos países centrais, o acúmulo de estoques muito além das necessidades populacionais e a recusa em flexibilizar regimes de propriedade intelectual evidenciam que certas vidas foram implicitamente consideradas prioritárias, enquanto outras puderam ser expostas ao risco, ao adoecimento e à morte.

A noção mbembeana de excedente conecta-se diretamente à colonialidade ao revelar que a raça continua operando como critério silencioso de regulação das relações internacionais, ainda que não explicitamente nomeada. As populações da África, da América Latina e de partes da Ásia foram, mais uma vez, inseridas no circuito global não como sujeitos plenos de direitos, mas como destinatárias tardias de políticas compensatórias, como doações condicionadas, mecanismos de caridade internacional ou programas multilaterais insuficientes. Essa condição reforça a ideia de que tais vidas são toleradas na medida em que não ameaçam a estabilidade do centro, podendo ser adiadas, expostas ou sacrificadas em nome da preservação da ordem global.

Além disso, ao destacar que a raça é o fundamento a partir do qual se estabelecem “relações do tipo guerreiro” e se regulam as relações coloniais, Mbembe oferece uma lente para compreender a retórica da “segurança sanitária” adotada por Estados hegemônicos durante a pandemia. O fechamento seletivo de fronteiras, as restrições à mobilidade de determinadas populações e a criminalização de corpos racializados, especialmente migrantes e refugiados, coexistiram com a livre circulação de capitais, insumos e tecnologias voltadas à proteção dos mercados centrais. A pandemia, assim, operou como um espaço privilegiado de atualização da necropolítica, na qual o poder de decidir quem deve viver e quem pode morrer se exerce de forma estrutural e desigual.

Portanto, a má distribuição das vacinas contra a COVID-19 não constitui um desvio excepcional, mas a expressão contemporânea de uma racionalidade colonial que continua a produzir fissuras sociais, geopolíticas e raciais. A partir da leitura de Mbembe, torna-se possível afirmar que a governança global da pandemia reafirmou a colonialidade da vida, transformando a raça em um critério implícito de acesso à proteção sanitária. Nesse sentido, a pandemia não apenas revelou as desigualdades históricas do sistema-mundo, mas também aprofundou os mecanismos pelos quais certas vidas são classificadas como excedentes, confirmando a permanência da colonialidade como eixo estruturante das relações globais de poder.

A pandemia da COVID-19 serviu para evidenciar que estamos longe de viver em mundo igualitário e que a capacidade de resposta às catástrofes e desastres naturais estão diretamente vinculadas à capacidade produtiva e riqueza econômica das nações. A desigualdade vacinal não decorreu apenas da escassez de recursos materiais, mas de um modelo global de governança que privilegia os interesses de corporações transnacionais e Estados hegemônicos. Organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), embora tenham buscado mecanismos de cooperação, como o COVAX Facility, não foram capazes de subverter as barreiras impostas pelo regime de propriedade intelectual que foi capaz de consolidar o monopólio das grandes farmacêuticas e limitou a soberania sanitária das nações periféricas.

Portanto, a hierarquização entre Norte e Sul Global, não se limita a um fenômeno econômico ou técnico, mas expressa uma forma de colonialidade contemporânea, que reconfigura o poder global a partir de novas dependências. A pandemia, longe de representar uma oportunidade de superação dessas assimetrias, reafirmou a centralidade do capital e a marginalização dos povos do Sul nas estruturas de decisão e produção científica.

5 A POSIÇÃO PERIFÉRICA DO BRASIL E AS DINÂMICAS NORMATIVAS E CONTRATUAIS NA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID-19

Este capítulo apresenta a análise da posição periférica do Brasil no sistema-mundo contemporâneo e suas repercussões nas dinâmicas normativas e contratuais que estruturaram o processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19. Parte-se do pressuposto de que a pandemia, longe de representar uma ruptura com as hierarquias globais historicamente constituídas, atuou como um evento revelador e intensificador das assimetrias próprias da colonialidade do poder e do saber especialmente no campo da saúde global e da produção científica.

Inserido de forma subordinada na economia política internacional, o Estado brasileiro enfrentou a emergência sanitária condicionado por relações desiguais de dependência tecnológica, financeira e normativa. A aquisição de vacinas ocorreu em um contexto marcado pela concentração do conhecimento científico, da capacidade produtiva e do controle das patentes nos países centrais do capitalismo global, o que limitou significativamente a margem de autonomia decisória do Brasil. Tal cenário contribuiu para a adoção de arranjos normativos excepcionais, flexibilizações legislativas e cláusulas contratuais atípicas, muitas vezes incompatíveis com princípios constitucionais e com a tradição jurídica nacional, evidenciando um processo de adaptação forçada às exigências impostas por atores econômicos transnacionais.

Nesse sentido, a análise das alterações normativas implementadas durante a pandemia revelou não apenas uma resposta emergencial à crise sanitária, mas também a materialização de um padrão estrutural de submissão regulatória, no qual o direito interno é tensionado e reconfigurado para atender às demandas do mercado global de imunizantes. A excepcionalidade jurídica, apresentada como necessária à proteção da saúde pública, funcionou, em diversos momentos, como mecanismo de legitimação da transferência de riscos ao Estado brasileiro e da mitigação de responsabilidades das indústrias farmacêuticas, reforçando a posição periférica do país nas cadeias globais de valor da saúde.

Paralelamente, examinará o processo de subalternização da ciência brasileira, historicamente reconhecida por sua capacidade técnica e institucional, mas progressivamente marginalizada no desenho das estratégias de enfrentamento da pandemia. Instituições nacionais de pesquisa e produção de imunobiológicos, embora fundamentais para a consolidação do Sistema Único de Saúde, foram frequentemente relegadas a um papel secundário, seja pela

dependência de insumos estrangeiros, seja pela centralidade atribuída às soluções tecnológicas importadas, em detrimento do fortalecimento da soberania científica e tecnológica nacional.

Ao articular a posição periférica do Brasil com as dinâmicas normativas, contratuais e científicas que atravessaram a aquisição de vacinas contra a COVID-19, este capítulo buscará demonstrar que a crise sanitária operou como um campo privilegiado de atualização da colonialidade. A análise proposta pretende evidenciar que as escolhas jurídicas e políticas realizadas não podem ser compreendidas isoladamente, mas devem ser situadas no interior de um sistema global que produz, reproduz e naturaliza relações de dependência, subordinação e assimetria, com impactos diretos sobre o direito à saúde, a autonomia estatal e a valorização da ciência produzida no Sul Global.

5.1 O processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19 no Brasil

A vacina destacou-se como o principal e mais eficaz instrumento para a contenção da COVID-19. Todavia, sua aquisição pelo Estado brasileiro revelou-se um processo complexo, permeado por negociações multilaterais, contratos de natureza excepcional, alterações normativas aprovadas pelo Congresso Nacional e intensa atuação de múltiplos atores institucionais, entre os quais se destacaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Instituto Butantan e indústrias farmacêuticas internacionais.

O primeiro anúncio oficial do Governo Federal acerca da aquisição de imunizantes ocorreu em 27 de julho de 2020, quando a população foi informada, por intermédio do Ministério da Saúde, sobre a parceria estabelecida entre a Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, com vistas à transferência de tecnologia para a produção da vacina contra a COVID-19 no Brasil (Fundação Oswaldo Cruz, 2021). Tal iniciativa foi apresentada como um marco inicial na estratégia nacional de enfrentamento da pandemia, especialmente no que concerne à internalização de capacidades produtivas.

A FIOCRUZ desempenhou papel estratégico e fundamental na resposta brasileira à crise sanitária, particularmente na produção e na distribuição de vacinas. Ainda em junho de 2020, a instituição firmou um Memorando de Entendimento que culminou, em 8 de setembro de 2020, na assinatura do contrato de Encomenda Tecnológica (Etec) com a AstraZeneca. Esse instrumento previa, inicialmente, a transferência da tecnologia de processamento final do imunizante e, posteriormente, a transferência do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), com o

objetivo de viabilizar uma produção integralmente nacional da vacina (Fundação Osvaldo Cruz, 2021).

No mesmo período, o Governo Federal editou a Medida Provisória n.º 1.003/2020, posteriormente convertida na Lei n.º 14.121, de 1º de março de 2021, com a finalidade de viabilizar a adesão do Brasil ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas contra a COVID-19 (Covax Facility), mecanismo coordenado pela Aliança Gavi (Brasil, 2021c). Por meio dessa iniciativa, o país buscou assegurar o acesso a doses adicionais de imunizantes, tendo recebido as primeiras remessas oriundas do consórcio em 21 de março de 2021 (Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2021).

Paralelamente, em 7 de janeiro de 2021, o Governo Federal firmou contrato com o Instituto Butantan para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, desenvolvida em parceria com a empresa Sinovac. Esse acordo foi decisivo para o início da campanha de vacinação no Brasil, que teve início em 17 de janeiro de 2021, após a Anvisa conceder autorização de uso emergencial tanto para a CoronaVac quanto para o imunizante da AstraZeneca (Brasil, 2021b).

A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan passou a ser administrada à população brasileira após a comprovação de sua eficácia e segurança, com base em estudos clínicos iniciados em julho de 2020 em sete unidades da federação, envolvendo 13.060 voluntários, majoritariamente profissionais da saúde expostos cotidianamente ao vírus, conforme critérios científicos rigorosamente avaliados pela Anvisa (Instituto Butantan, 2022).

Em 29 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde confirmou a aquisição de mais 54 milhões de doses da CoronaVac junto à Fundação Butantan, totalizando 100 milhões de doses destinadas ao atendimento do Plano Nacional de Imunizações (PNI) (Brasil, 2021f). Posteriormente, em 18 de março de 2021, foram concluídas as tratativas contratuais para a aquisição de vacinas junto às empresas Pfizer Inc. e Janssen-Cilag Farmacêutica (CNN Brasil, 2021b).

Ocorre que, não obstante a relevância das iniciativas empreendidas pelo Estado brasileiro, tais medidas foram amplamente consideradas tardias, sobretudo diante da velocidade de propagação do vírus SARS-CoV-2 e da urgência imposta pelo cenário sanitário. A demora na adoção de mecanismos eficazes de coordenação nacional, bem como na implementação de estratégias céleres para a aquisição e a distribuição de vacinas, produziu consequências devastadoras, entre as quais se destaca a morte de milhares de pessoas, agravando de forma exponencial a crise humanitária vivenciada no país.

Esse contexto de ineficiência institucional, associado a suspeitas quanto à lisura dos processos administrativos relacionados às contratações públicas, culminou na instauração, pelo Senado Federal, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia). A referida Comissão teve por finalidade investigar eventuais irregularidades nos procedimentos de aquisição de imunizantes, bem como apurar a responsabilidade administrativa, política e jurídica dos gestores públicos envolvidos na condução da resposta governamental à crise sanitária.

Além disso, a CPI buscou esclarecer a ocorrência de possíveis omissões, negligências ou práticas incompatíveis com os princípios constitucionais que regem a administração pública, as quais poderiam ter influenciado negativamente o enfrentamento da pandemia. Ao longo de seus trabalhos, a Comissão adquiriu ampla visibilidade pública, revelando falhas estruturais na governança da saúde, disputas políticas internas e pressões econômicas que, em última instância, comprometeram a efetividade das políticas emergenciais destinadas à proteção da vida e da saúde coletiva (Brasil, 2021h).

Encerrados os trabalhos da CPI em 7 de novembro de 2021, o relatório final apresentou conclusões contundentes. As apurações indicaram que, foram realizadas ofertas iniciais para a aquisição de vacinas, com destaque para o imunizante CoronaVac, desenvolvido pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, bem como para a vacina produzida pela Pfizer. Todavia, as tratativas e a conclusão das negociações por parte do governo federal sofreram atrasos injustificáveis e intencionais, impactando diretamente tanto a efetivação das compras quanto o cronograma de imunização da população brasileira (Brasil, 2021h).

Dessa forma, a ausência de planejamento estratégico adequado para a aquisição de vacinas, conforme constatado pela CPI, retardou o início da imunização em massa e produziu efeitos duradouros sobre a saúde da população. As investigações destacaram, ainda, a omissão deliberada do governo federal no ano de 2020, período em que propostas apresentadas pela farmacêutica Pfizer foram reiteradamente ignoradas. Tais condutas foram interpretadas por especialistas e parlamentares como manifestações de negligência administrativa, resultando em recomendações de indiciamento de autoridades públicas por crimes de responsabilidade e prevaricação.

A instauração da CPI, portanto, não apenas evidenciou a gravidade das consequências decorrentes de uma atuação estatal tardia e descoordenada, como também revelou a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de transparência, controle e responsabilização no âmbito das políticas públicas de saúde, especialmente em contextos de crise sanitária global.

No plano jurídico, o Brasil evidenciou profundas tensões entre a garantia constitucional do direito humano à saúde e as dinâmicas contratuais que estruturam o mercado farmacêutico global, caracterizado por monopólios tecnológicos, assimetrias econômicas e regimes de propriedade intelectual que favorecem atores privados transnacionais. Tais circunstâncias expuseram limites estruturais do Estado nacional frente à lógica do capital farmacêutico globalizado.

Esses acontecimentos revelaram, de modo contundente, a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de governança pública, a transparência decisória e a responsabilização política no campo da saúde coletiva. Evidenciaram, igualmente, a urgência de repensar criticamente as estruturas de poder que regulam o acesso global às tecnologias em saúde, sobretudo diante da prevalência de interesses econômicos que frequentemente se sobrepõem às obrigações internacionais de proteção da vida e da dignidade humana.

Nesse cenário, torna-se indispensável a inserção ativa do Brasil no debate contemporâneo sobre justiça global em saúde e sobre a descolonização das políticas farmacêuticas, temática que vem ganhando centralidade em organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A participação qualificada nesses espaços permite questionar modelos hegemônicos de produção, distribuição e apropriação de tecnologias médicas, bem como propor alternativas normativas orientadas à promoção de maior equidade e solidariedade internacional.

5.2 As alterações normativas brasileiras e a reprodução da colonialidade no enfrentamento a COVID-19

Durante o período de vigência do estado de calamidade pública em saúde no Brasil, instaurado em razão da pandemia de COVID-19, o ordenamento jurídico nacional foi submetido a profundas e aceleradas transformações normativas. O enfrentamento da crise sanitária deu ensejo à aprovação de um conjunto expressivo e heterogêneo de atos normativos, incluindo leis ordinárias e complementares, emendas constitucionais, medidas provisórias, decretos, portarias e resoluções emanadas, sobretudo, do Poder Executivo federal. Tal cenário configurou um ambiente jurídico excepcional, frequentemente descrito pela doutrina como um verdadeiro estado de exceção sanitária, no qual procedimentos ordinários foram flexibilizados

ou temporariamente afastados sob a justificativa da urgência e da necessidade de resposta imediata à emergência em saúde pública.

No decorrer da pesquisa, todos os atos normativos editados durante o período pandêmico foram sistematicamente catalogados e analisados. Contudo, em razão do recorte temático da tese, centrado na aquisição de vacinas e insumos estratégicos no período de emergência em saúde pública nacional, foram selecionadas, para análise aprofundada, as seguintes leis federais ordinárias diretamente relacionadas à contratação e aquisição de medicamentos, insumos e imunizantes destinados à contenção da COVID-19: (a) Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; (b) Lei n.º 14.006, de 28 de maio de 2020; (c) Lei n.º 14.124, de 10 de março de 2021; e (d) Lei n.º 14.125, de 10 de março de 2021.

As legislações aprovadas no contexto da emergência sanitária buscaram conferir suporte jurídico à atuação do Estado brasileiro diante da crise epidemiológica, sobretudo por meio da flexibilização de procedimentos administrativos e contratuais relativos à aquisição de medicamentos, insumos estratégicos e vacinas. O objetivo declarado dessas medidas consistia em conferir maior celeridade, eficiência e adaptabilidade à resposta estatal, diante de um cenário de escassez global, competição internacional e elevada incerteza científica.

Entretanto, a análise crítica dessas normas revelou que, para além de sua função instrumental de enfrentamento da crise, elas acabaram por atender, de forma direta ou indireta, aos interesses das grandes corporações farmacêuticas transnacionais. Tal fenômeno manifestase, especialmente, na preservação de monopólios tecnológicos, na aceitação de cláusulas contratuais assimétricas, na ampliação das margens de proteção jurídica às empresas fornecedoras e na transferência desproporcional de riscos ao Estado brasileiro, inclusive no que se refere à responsabilização por eventuais efeitos adversos decorrentes do uso dos imunizantes.

A aprovação desse conjunto normativo foi acompanhada por intensos debates políticos, jurídicos e institucionais, notadamente em razão das circunstâncias excepcionais que marcaram sua elaboração. Entre as principais controvérsias suscitadas, destacam-se: (i) a insuficiência de transparência quanto aos processos decisórios e à publicidade dos atos normativos e dos contratos firmados; (ii) a relativização da soberania nacional, evidenciada pela aceitação de exigências contratuais impostas por empresas estrangeiras; (iii) a previsão de responsabilidade integral e exclusiva do Estado brasileiro por eventuais danos decorrentes dos imunizantes; e (iv) as “pressões” exercidas sobre a autonomia técnico-regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cuja independência constitui elemento central da proteção da saúde pública e da segurança sanitária.

A análise documental foi conduzida segundo o método de Análise de Conteúdo proposto por Laurence Bardin (2020), tomando como ponto de partida a identificação de unidades de registro e de significado presentes nos diplomas legais. Essas unidades foram posteriormente organizadas em categorias e subcategorias analíticas, permitindo a sistematização e a interpretação rigorosa dos dados qualitativos. O procedimento possibilitou a transformação de informações normativas dispersas em elementos analíticos capazes de subsidiar inferências críticas, comparações e reflexões teóricas consistentes.

Cumprido ressaltar que todo o processo interpretativo foi orientado pela teoria da colonialidade, formulada por Aníbal Quijano, perspectiva que se mostrou fundamental para compreender de que modo as legislações emergenciais brasileiras não apenas refletiram, mas também reproduziram dinâmicas históricas de subordinação tecnológica, econômica e epistêmica. A partir desse marco teórico, o capítulo buscou demonstrar que o contexto pandêmico expôs fragilidades estruturais da governança sanitária nacional e evidenciou a permanência de relações coloniais no campo das políticas farmacêuticas e da saúde global, especialmente no que se refere à dependência tecnológica e à assimetria nas relações contratuais internacionais.

5.2.1 A colonialidade do poder: submissão do Brasil na compra do imunizante

No que se refere à aquisição de vacinas para o enfrentamento da COVID-19, a Lei federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, constituiu um dos primeiros diplomas normativos sancionados e publicados pelo governo federal brasileiro no contexto da emergência sanitária. Tal legislação assumiu papel central na estruturação jurídica das medidas de resposta à pandemia, funcionando como marco regulatório inicial para a implementação de ações estatais coordenadas, cuja eficácia estava condicionada à duração da situação de emergência em saúde pública de relevância nacional.

A referida lei disciplinou um amplo conjunto de medidas sanitárias excepcionais, incluindo regras de isolamento e quarentena, restrições à circulação de pessoas e mercadorias, fechamento de portos, aeroportos e rodovias, bem como a realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outros procedimentos profiláticos e terapêuticos específicos (Brasil, 2020a).

Autorizou a requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas e previu, de forma excepcional, a possibilidade de importação de produtos sujeitos à vigilância

sanitária sem registro prévio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que tais produtos estivessem registrados por autoridade sanitária estrangeira.

As disposições introduzidas pela Lei n.º 13.979/2020 suscitaram intensa controvérsia tanto na esfera pública quanto no meio acadêmico, sobretudo no que concerne à influência exercida por grandes corporações farmacêuticas transnacionais, majoritariamente sediadas na Europa e nos Estados Unidos, sobre os processos decisórios relacionados à aquisição de insumos e imunobiológicos por países periféricos. As críticas concentraram-se, em especial, na autorização excepcional para importação de produtos destinados ao enfrentamento da COVID-19 ainda desprovidos de registro sanitário nacional, desde que previamente aprovados por autoridades estrangeiras consideradas de “reconhecida credibilidade”.

Com o propósito de examinar de forma rigorosa os sentidos explícitos e implícitos presentes no texto normativo, aplicou-se à Lei n.º 13.979/2020 o método de Análise de Conteúdo. A abordagem metodológica possibilitou a identificação de estruturas de significado manifestas e latentes, a partir da construção de categorias, subcategorias e códigos analíticos, extraídos das unidades de registro identificadas no corpo da norma. A aplicação desse procedimento revelou dois códigos centrais — “sem registro na Anvisa” e “autoridade sanitária estrangeira” — os quais evidenciaram tensões estruturais relevantes no arranjo regulatório estabelecido pela legislação emergencial.

Para a adequada compreensão dessas tensões, é imprescindível resgatar o papel institucional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Criada pela Lei federal n.º 9.782/1999, a Anvisa foi concebida como autarquia sob regime especial, dotada de autonomia administrativa e técnica, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, especialmente por meio das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados (Brasil, 1999). Sua finalidade primordial consiste na promoção e proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da produção e do consumo de produtos e serviços, incluindo insumos, tecnologias e processos relacionados à saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2024).

O controle rigoroso da entrada de produtos sujeitos à vigilância sanitária no território nacional encontra respaldo histórico nas Leis federais n.º 6.360/1976 e n.º 9.782/1999, que estabeleceram a obrigatoriedade de registro sanitário como condição para a fabricação, importação, comercialização e consumo de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos correlatos.

Conforme dispõe expressamente a Lei n.º 6.360/1976, nenhum produto abrangido por seu escopo pode ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo sem o prévio

registro no Ministério da Saúde, justamente como forma de assegurar eficácia, qualidade e segurança sanitária (Brasil, 1976).

A partir da identificação dos códigos “sem registro na Anvisa” e “autoridade sanitária estrangeira”, a análise de conteúdo evidenciou que a Lei n.º 13.979/2020 produziu um deslocamento significativo no equilíbrio das competências regulatórias do Estado brasileiro. Esse deslocamento traduziu-se na relativização da centralidade decisória da Anvisa e na abertura de um precedente de deslegitimação do saber técnico-científico nacional, ao atribuir primazia às avaliações realizadas por autoridades sanitárias estrangeiras, reduzindo o órgão regulador brasileiro a uma instância com funções predominantemente homologatórias.

A reconfiguração normativa expressa uma dinâmica típica da colonialidade do poder, segundo o qual as relações coloniais persistem para além do colonialismo formal, estruturando-se por meio da hierarquização global do trabalho, do conhecimento e das instituições. Ao subordinar a autoridade regulatória nacional aos parâmetros definidos por países centrais, a legislação emergencial reproduziu padrões históricos de subalternização institucional e epistemológica, nos quais o saber produzido nos centros hegemônicos é naturalizado como superior, universal e neutro.

Embora seja inegável que autoridades sanitárias locais possuem maior capacidade de interpretar indicadores epidemiológicos à luz das especificidades territoriais, sociais e culturais, a secundarização de suas recomendações implicou a perda de oportunidades para a adoção de medidas mais adequadas à realidade brasileira. Em nome da urgência e da celeridade administrativa, optou-se por um modelo regulatório que fragilizou a autonomia decisória nacional e aprofundou a dependência em relação a instâncias externas de validação científica e tecnológica.

Em princípio, os dispositivos da Lei n.º 13.979/2020 buscaram conferir eficiência ao processo de aquisição de vacinas em um cenário marcado pela escassez global de imunizantes e pela intensa disputa internacional. Todavia, a análise crítica de sua aplicação revela que a execução da norma foi permeada por desigualdades estruturais, tanto na capacidade de negociação do Estado brasileiro frente às grandes indústrias farmacêuticas quanto no acesso assimétrico à informação, à tecnologia e ao conhecimento científico, elementos centrais da economia política da saúde global.

Nesse sentido, Walter Mignolo (2020) destaca que a colonialidade opera como mecanismo persistente de dominação na produção e validação do conhecimento, reafirmando hierarquias epistêmicas mesmo após o fim formal do colonialismo.

Isso é, em suma, o que para Quijano constitui a colonialidade do poder através do qual o planeta inteiro, incluindo sua divisão continental (África, América e Europa) se articula para a produção de conhecimento e seu aparato classificatório. O eurocentrismo torna-se, portanto, uma metáfora para descrever a colonialidade do poder, na perspectiva da subalternidade. Da perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais europeias foram vistos como projetos globais, desde o um *Orbis universalis christianus* até a crença em Hegel em uma história universal, narrada de uma perspectiva que situa a Europa como ponto de referência e de chegada. A história universal contada por Hegel é uma história universal na qual a maioria dos atores não teve a oportunidade de ser também narradores. A semiose colonial visa identificar momentos precisos de tensão no conflito entre duas histórias e saberes locais, uma reagindo no sentido de avançar para um projeto global planejado para se impor, e outros visando às histórias e saberes locais, forçados a se acomodar a essas novas realidades. (Mignolo, 2020, p.41)

Para o autor, o eurocentrismo constitui uma expressão da colonialidade do poder, na medida em que transforma histórias e saberes locais europeus em projetos globais, silenciando outras epistemologias e experiências históricas. Essa dinâmica também se manifesta no campo jurídico, onde normas nacionais passam a ser estruturadas a partir de centros de referência externos.

A colonialidade, portanto, não se restringe às dimensões econômica ou científica, mas permeia igualmente a produção jurídica. Como observa Boaventura de Sousa Santos (2022), o direito moderno integra a racionalidade colonial ao reproduzir categorias de regulação fundadas na suposta superioridade do modelo jurídico ocidental. No caso da Lei n.º 13.979/2020, a incorporação acrítica de parâmetros internacionais e a dependência de validação por autoridades sanitárias estrangeiras evidenciaram a forma como a normatividade brasileira se articulou a partir de centros hegemônicos de poder e conhecimento.

Nesse cenário, a autorização para a importação de produtos sem registro na Anvisa não apenas implicou riscos potenciais à segurança sanitária da população, como também refletiu a transferência de poder regulatório para as grandes multinacionais farmacêuticas, detentoras dos insumos, das patentes e das tecnologias necessárias ao enfrentamento da pandemia. A legislação emergencial resultou, assim, no enfraquecimento da autonomia regulatória da Anvisa e, por conseguinte, da soberania sanitária do Estado brasileiro, evidenciando a manifestação concreta da colonialidade do poder no campo das políticas de saúde.

Preservar a autonomia da Anvisa constitui, portanto, uma estratégia essencial para a proteção da soberania nacional, da autonomia sanitária e dos direitos fundamentais, em especial o direito humano à saúde. A necessidade de respostas rápidas diante de uma crise sanitária não pode justificar a ruptura do equilíbrio entre celeridade e segurança, nem legitimar a desqualificação das instituições nacionais em favor de instâncias estrangeiras, sobretudo aquelas vinculadas a países centrais historicamente associados a processos coloniais.

Ao analisar o conjunto das legislações aplicáveis ao processo de aquisição de insumos e imunizantes destinados ao enfrentamento da COVID-19, a pesquisa abrangeu também a Lei Federal n.º 14.006, de 28 de maio de 2020, responsável por promover alterações substanciais na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Tal diploma normativo consolidou e aprofundou a flexibilização regulatória inaugurada no início da emergência sanitária, ampliando os mecanismos excepcionais de importação e incorporação de tecnologias em saúde no ordenamento jurídico brasileiro (Brasil, 2020b).

A Lei n.º 14.006/2020 conferiu respaldo legal às autoridades sanitárias brasileiras para a importação e a distribuição de medicamentos, equipamentos e insumos sujeitos à vigilância sanitária, ainda que desprovidos de registro prévio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que tais produtos estivessem registrados por ao menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras expressamente elencadas no texto legal: a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos; a European Medicines Agency (EMA), da União Europeia; a Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), do Japão; e a National Medical Products Administration (NMPA), da China (2020b).

A aplicação do método de Análise de Conteúdo proposto por Laurence Bardin permitiu identificar que as unidades de significado extraídas da Lei n.º 14.006/2020 concentrava-se, essencialmente, em dois eixos semânticos centrais: “medicamentos com registros de agências estrangeiras” e “autorização em 72 horas”. Esses códigos revelaram o núcleo das flexibilizações introduzidas pela norma, especialmente no que diz respeito à incorporação acelerada de tecnologias em saúde em um contexto de emergência sanitária, com impactos diretos sobre a autonomia regulatória nacional.

Ao autorizar o Poder Executivo a importar e distribuir quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos sujeitos à vigilância sanitária, desde que previamente registrados por determinadas autoridades estrangeiras, a legislação ampliou significativamente a margem de atuação governamental, ao mesmo tempo em que reduziu a centralidade decisória da Anvisa. A referida reconfiguração normativa deslocou o eixo de validação técnico-científica do plano nacional para instâncias externas, fragilizando o papel da agência reguladora brasileira enquanto autoridade sanitária soberana.

Cumpram-se destacar que a aprovação de determinado produto por uma autoridade sanitária estrangeira não assegura, de forma automática, sua adequação ao contexto brasileiro. Cada país apresenta especificidades epidemiológicas, sociais, territoriais e demográficas próprias, que podem influenciar diretamente a eficácia, a segurança e a equidade das políticas públicas de

saúde. A avaliação regulatória, portanto, não pode prescindir da consideração dessas particularidades locais.

É certo que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em situações de emergência sanitária, adota o Procedimento de Listagem para Uso Emergencial (Emergency Use Listing – EUL), mecanismo baseado na avaliação de riscos, destinado a acelerar a disponibilização de vacinas, medicamentos e diagnósticos ainda não licenciados (Organização Mundial da Saúde, 2023a). Contudo, a própria OMS ressalta que o EUL não substitui os processos formais de pré-qualificação nem os procedimentos regulatórios exigidos pelas autoridades sanitárias nacionais, reafirmando a soberania dos Estados-Membros para decidir sobre a autorização de uso emergencial de produtos médicos em seus territórios (Organização Mundial da Saúde, 2023a).

Apesar disso, ao delegar a legitimidade da aprovação de vacinas e medicamentos a autoridades sanitárias estrangeiras — notadamente a FDA, a EMA e a PMDA — o Estado brasileiro reafirmou uma dependência epistemológica e normativa em relação ao Norte Global. Tal opção legislativa, ainda que justificada pelo argumento da urgência sanitária, evidencia a permanência da colonialidade do saber e do poder, na medida em que reconhece a superioridade técnica e científica de instituições estrangeiras em detrimento das capacidades regulatórias nacionais.

Nesse contexto, a autorização legal para a comercialização de insumos e imunizantes previamente registrados por autoridades estrangeiras implicou restrição direta à autonomia decisória da Anvisa, fragilizando seu papel técnico-normativo enquanto instância reguladora independente, orientada pelas especificidades do contexto sanitário brasileiro e pela proteção da saúde pública. Deslegitimar ou subtrair as funções da Anvisa enfraquece o controle sobre a qualidade, a eficácia e a segurança dos produtos disponibilizados à população, além de expor tensões entre conhecimento científico, dependência externa e a imposição de interesses das indústrias farmacêuticas transnacionais, à luz da teoria da colonialidade do poder.

Ao privilegiar sistemas regulatórios estrangeiros — especialmente norte-americanos e europeus — em detrimento da autoridade sanitária nacional, a legislação analisada institucionalizou um padrão de colonialidade, ao reforçar a confiança em sistemas científicos externos e marginalizar iniciativas regulatórias locais ou regionais. Observa-se que a Lei n.º 14.006/2020 conferiu centralidade decisória a quatro autoridades sanitárias estrangeiras, sendo três vinculadas ao Norte Global e uma à China, potência emergente no campo tecnológico e industrial, evidenciando a concentração do poder decisório sobre tecnologias sanitárias em centros hegemônicos.

Essa dependência de certificações estrangeiras implicou a aceitação de condições impostas pelas indústrias farmacêuticas transnacionais, resultando na transferência de poder decisório e normativo para atores privados globais, cuja atuação é orientada prioritariamente por interesses mercadológicos. Nesse sentido, a Lei n.º 14.006/2020, embora concebida como resposta emergencial à crise sanitária, acabou por reforçar a inserção periférica do Brasil na economia política global da saúde, expondo as assimetrias estruturais do sistema internacional de governança sanitária.

A opção pela Lei Federal nº 14.006/2020 por parte das quatro autoridades sanitárias estrangeiras revelou-se particularmente elucidativa quando analisada sob a ótica da colonialidade do poder, conforme conceituada por Aníbal Quijano (2005). Tal noção designa uma matriz de dominação que, embora desvinculada do colonialismo formal, permanece operante na organização das relações globais, estruturando hierarquias epistêmicas, econômicas e institucionais que definem quais saberes são reconhecidos como legítimos e quais instâncias detêm autoridade para decidir.

Nesse sentido, a adoção de parâmetros normativos externos expressa a reprodução dessa lógica colonial, ao subordinar o conhecimento técnico e a capacidade regulatória dos países em desenvolvimento a centros hegemônicos de validação. A colonialidade do poder manifesta-se, assim, na sistemática deslegitimação da autonomia institucional desses Estados, mesmo quando dispõem de arcabouço jurídico e expertise regulatória suficientes para a formulação e a implementação de suas próprias políticas sanitárias.

Nesse ponto, articula-se a crítica de Chimamanda Ngozi Adichie (2019) acerca do “perigo da história única”. A imposição de narrativas hegemônicas como verdades universais reduz a pluralidade de experiências e saberes, reforçando estereótipos e hierarquias simbólicas que legitimam a dominação epistêmica descrita por Quijano. No campo da saúde global, essa dinâmica se traduz na naturalização da superioridade dos sistemas regulatórios dos países centrais.

A subordinação regulatória da Anvisa em relação às autoridades estrangeiras elencadas na Lei n.º 14.006/2020 revelou a persistência de estruturas coloniais na governança sanitária brasileira, frequentemente disfarçadas sob o argumento da eficiência administrativa. Essa marca da colonialidade tornou-se particularmente visível nos códigos presentes no texto legal, como “prazo de 72 horas”, “dispensada autorização de outro órgão” e “autorização concedida automaticamente”.

Ao estabelecer que a Anvisa deveria emitir autorização em até 72 horas — sob pena de deferimento automático — a lei vinculou a decisão regulatória nacional à prévia aprovação

estrangeira, esvaziando o conteúdo técnico da análise sanitária. O mecanismo evidencia, de forma explícita, a permanência de lógicas coloniais que estruturam o campo global do saber e do poder, reforçando a hierarquização epistêmica que historicamente posiciona o Sul Global em condição de dependência.

Posteriormente, a publicação da Lei n.º 14.124, de 10 de março de 2021, aprofundou esse cenário. A análise de conteúdo desse diploma identificou codificações como “aquisição de vacina antes do registro sanitário”, “contratos com cláusulas especiais”, “pagamento antecipado”, “perda do valor antecipado”, “não imposição de penalidades à contratada” e “cláusulas de confidencialidade”. Tais codificações evidenciam a ampliação das prerrogativas das corporações farmacêuticas multinacionais e a flexibilização das salvaguardas jurídicas tradicionalmente associadas ao Direito Administrativo Contratual.

Em um contexto no qual o Brasil não detinha autonomia plena na produção de imunizantes, especialmente nos primeiros meses da pandemia, essas disposições reforçaram a dependência histórica em relação aos centros tecnológicos e biomédicos dos países desenvolvidos, reproduzindo assimetrias estruturais típicas do sistema-mundo moderno/colonial. A urgência sanitária e a escassez global de vacinas intensificaram essa dinâmica, deslocando o poder de negociação em favor do capital internacional.

A codificação “contratos com cláusulas especiais”, identificada na Lei n.º 14.124/2021, evidenciou um deslocamento substancial do poder negocial em favor das empresas fornecedoras, comprometendo princípios estruturantes do Direito Administrativo brasileiro, como a legalidade, a isonomia e a supremacia do interesse público. Tal assimetria contratual revelou a vulnerabilidade estrutural do Estado brasileiro diante das corporações transnacionais, vulnerabilidade agravada pela dependência tecnológica e pela excepcionalidade do contexto pandêmico.

Dessa forma, constatou-se que o marco normativo instituído durante a pandemia da COVID-19, ao flexibilizar garantias jurídicas essenciais, contribuiu para a reprodução de relações de subordinação típicas da colonialidade, especialmente no plano econômico-contratual. Sob essa perspectiva, o projeto de descolonização permanece inacabado, conforme aponta Grosfoguel (2008), na medida em que a descolonização política não foi acompanhada por uma efetiva descolonização epistemológica, econômica, social e institucional.

A reflexão de Grosfoguel (2008), ancorada na formulação de Aníbal Quijano acerca da colonialidade do poder, evidenciou que o colonialismo não se encerrou com os processos formais de independência política dos Estados periféricos, mas persiste como uma matriz estrutural que organiza as relações econômicas, políticas, jurídicas e epistêmicas no sistema-

mundo contemporâneo. Ao afirmar que ainda vivemos em um “mundo colonial”, o autor aponta para a permanência de hierarquias globais que continuam a definir quais sujeitos, saberes e instituições são reconhecidos como legítimos, universais e autorizados a produzir normas, conhecimento e verdade.

Nesse sentido, a colonialidade do poder opera como um padrão de dominação que ultrapassa o domínio territorial e se manifesta na naturalização da superioridade do Norte Global, bem como na subalternização estrutural dos países do Sul Global. Tal lógica não apenas condiciona as relações internacionais, mas também molda as instituições internas dos Estados periféricos, influenciando a produção do direito, a formulação de políticas públicas e os processos decisórios estratégicos, como se observa no campo da saúde global.

No que se refere ao código “pagamento antecipado”, identificado a partir da aplicação da Análise de Conteúdo de Bardin à Lei n.º 14.124/2021, observa-se que tal dispositivo constituiu um dos eixos centrais da excepcionalidade normativa instituída durante a pandemia. Ao autorizar desembolsos financeiros prévios sem a correspondente entrega do objeto contratual, o legislador criou um regime jurídico extraordinário que deslocou de forma expressiva o risco contratual para a esfera pública. A opção normativa vulnerabilizou o Estado brasileiro e contrariou princípios estruturantes do Direito Administrativo e Constitucional, notadamente o princípio da indisponibilidade do interesse público e o regime de responsabilização do fornecedor pelos riscos inerentes à atividade econômica que desenvolve (Bandeira de Mello, 2023).

Essa dinâmica revelou que as formas contemporâneas de dependência não se manifestam apenas por mecanismos econômicos diretos, mas também por meio de arranjos jurídicos, contratuais e institucionais que reproduzem padrões históricos de subordinação entre os países centrais, localizados majoritariamente na Europa e na América do Norte, e a periferia global, composta por nações latino-americanas, africanas e asiáticas. Conforme sustenta Quijano (2005), o fim do colonialismo formal não implicou a superação da matriz colonial que organiza as hierarquias globais de poder, mas apenas sua reconfiguração em novas bases institucionais.

À luz dessa matriz interpretativa, a aceitação de condições contratuais desfavoráveis pelo Estado brasileiro não pode ser compreendida como mero reflexo da urgência sanitária, mas como expressão de relações assimétricas historicamente sedimentadas no campo da saúde global. Segundo Quijano (2005), a colonialidade do poder estrutura o sistema-mundo moderno ao articular hierarquias econômicas, políticas e epistêmicas que mantêm os países periféricos em posição estrutural de dependência, inclusive no acesso a tecnologias estratégicas.

Nesse sentido, a previsão legal de que os valores pagos antecipadamente não seriam recuperados em caso de descumprimento contratual — desde que tal condição estivesse expressamente pactuada, representa verdadeira renúncia prévia aos mecanismos de responsabilização administrativa. Do ponto de vista jurídico, trata-se de cláusula que tensiona o regime constitucional de proteção do erário e se afasta das garantias previstas na Lei federal n.º 8.666/1993, vigente na época (Brasil, 1993).

A renúncia antecipada a esses instrumentos implica, em última instância, a submissão do Estado às exigências impostas por corporações farmacêuticas transnacionais, cuja posição privilegiada decorre do monopólio temporário assegurado pelos direitos de propriedade intelectual e da concentração da capacidade tecnológica global. Essa lógica reforça a assimetria estrutural denunciada por Grosfoguel (2008), ao afirmar que o colonialismo não desapareceu, mas foi reorganizado e naturalizado nas estruturas globais do capitalismo contemporâneo.

Na mesma direção, a codificação “não imposição de penalidades à contratada”, extraída da Lei n.º 14.124/2021, consolidou uma inversão estrutural das prerrogativas administrativas. Ao afastar a aplicação de sanções às empresas fornecedoras, a legislação suprimiu instrumentos elementares de coerção e fiscalização estatal, rompendo com a lógica assimétrica — porém protetiva — que caracteriza o regime dos contratos administrativos (Bandeira de Mello, 2023). O resultado foi a transferência integral do risco jurídico e econômico ao ente público, tornando-o dependente das condições unilaterais determinadas por agentes privados transnacionais.

Tal fenômeno confirma a leitura de Grosfoguel (2008), segundo a qual a colonialidade do poder constitui elemento estruturante do sistema-mundo moderno/colonial, organizando não apenas relações econômicas, mas também os marcos jurídicos e institucionais que regulam a vida social.

Outro elemento revelador da colonialidade que esteve presente na Lei n.º 14.124/2021 diz respeito à autorização de cláusulas de confidencialidade nos contratos de aquisição de vacinas. Ao admitir a celebração de contratos sigilosos, o ordenamento jurídico nacional relativizou princípios constitucionais fundamentais, como o da publicidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), fragilizando mecanismos de controle social e institucional indispensáveis à democracia e à transparência (Canotilho, 2018).

A confidencialidade, tal como estruturada, incorporou ao direito interno a lógica contratual hegemônica do Norte Global, na qual a assimetria informacional opera como instrumento de blindagem corporativa e de preservação da superioridade técnica e econômica das grandes indústrias farmacêuticas. Tratou-se, portanto, de um caso paradigmático de internalização normativa de padrões globais produzidos externamente, evidenciando que a

legislação nacional se torna flexível diante da força econômica de atores hegemônicos do sistema internacional da saúde.

Nesse contexto, as medidas jurídicas adotadas durante a pandemia, especialmente aquelas previstas na Lei n.º 14.124/2021, não se limitaram a regulamentar a aquisição de vacinas, mas institucionalizaram, em um contexto de crise, práticas que reforçam padrões globais de dependência. A emergência sanitária funcionou como justificativa política para a incorporação de mecanismos de exceção que, embora formalmente transitórios, reproduzem padrões estruturais de dominação (Agamben, 2004).

Dessa forma, a análise das legislações emergenciais revelou que a resposta jurídica brasileira à pandemia não pode ser compreendida apenas como estratégia de gestão de crise, mas como expressão concreta da colonialidade no campo da governança sanitária global. Ao flexibilizar salvaguardas essenciais do direito administrativo e deslocar riscos da esfera privada para a pública, tais normas evidenciaram que o sistema internacional de saúde operava segundo lógicas que subordinam países do Sul Global aos interesses de corporações transnacionais.

Para Mignolo (2008), a superação das condições de subalternidade exige o rompimento com referenciais eurocêntricos na produção do conhecimento, do direito e das políticas públicas. A ruptura, conforme também sustenta Grosfoguel (2016), somente se concretiza quando os países do Sul Global passarem a produzir teorias e normatividades a partir de suas próprias experiências históricas e sociais.

Por fim, a Lei Federal nº 14.125, de 10 de março de 2021 (Brasil, 2021d), introduziu alterações relevantes no regime jurídico da responsabilidade civil do Estado, ao autorizar que a União assumisse a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da administração de vacinas utilizadas em caráter emergencial no enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Brasil, 2021d). A opção legislativa produziu tensão com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na medida em que deslocou para o Estado um ônus que, em condições ordinárias, recairia sobre os fabricantes dos imunizantes (Brasil, 1988).

Importante destacar que a Lei nº 14.125/2021 teve origem em proposta apresentada pelo então Presidente do Senado Federal da época, consubstanciada no Projeto de Lei nº 534/2021, em um contexto no qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não havia concedido registro sanitário definitivo a nenhuma vacina contra a COVID-19. O diploma normativo autorizou, ainda, os entes federativos a constituírem garantias ou a contratassem seguros privados, nacionais ou internacionais, com a finalidade de cobrir riscos associados à imunização, em atendimento a exigências formuladas, sobretudo, por fabricantes como Pfizer e Janssen, conforme matéria veiculada no site oficial do Senado.

A Lei 14.125 teve origem em uma proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O [PL 534/2021](#) foi apresentado em um período em que a Anvisa ainda não havia aprovado registro definitivo de vacinas. A lei permitiu que entes federados constituíssem garantias ou contratassem seguro privado, nacional ou internacional, para a cobertura dos riscos relativos à imunização, uma exigência de fabricantes da Pfizer e Janssen. (Brasil, 2022b)

Assim, à luz da colonialidade do poder, conforme formulada por Aníbal Quijano e desenvolvida no campo crítico latino-americano, o conteúdo dessa matéria revelou dinâmicas estruturais que extrapolam a conjuntura emergencial da pandemia e evidenciaram assimetrias históricas no sistema-mundo moderno.

A lei nº 14.125/2021, ao autorizar que entes federativos brasileiros constituíssem garantias ou contratassem seguros — inclusive internacionais — para cobrir riscos decorrentes da imunização, expressa um deslocamento do centro decisório normativo do Estado nacional para atores econômicos transnacionais. Tal exigência, imposta por fabricantes como Pfizer e Janssen, ilustrou a permanência de uma lógica colonial na qual países periféricos assumem ônus jurídicos, financeiros e políticos para acessar bens essenciais produzidos no Norte global.

Sob a ótica da colonialidade do poder, observa-se que a hierarquia global do conhecimento, da economia e do direito condiciona a capacidade dos Estados periféricos de exercerem plenamente sua soberania regulatória. A flexibilização do regime jurídico nacional — antes mesmo da aprovação definitiva das vacinas pela Anvisa — evidenciou que o poder normativo do Estado brasileiro tornou-se funcional às exigências do capital farmacêutico internacional, reproduzindo a subordinação estrutural característica das economias dependentes.

Nesse sentido, a internalização legislativa das cláusulas de risco exigidas pelas farmacêuticas não pode ser compreendida apenas como uma solução pragmática diante da emergência sanitária. Tratou-se de um processo de adaptação assimétrica, no qual o direito nacional se molda aos interesses de atores hegemônicos globais, reafirmando o padrão colonial de distribuição do poder decisório: o Norte Global define as condições, enquanto a periferia assume os custos.

Portanto, a lei n. 14.125/2021 materializou uma forma contemporânea de colonialidade do poder no campo da saúde global, na medida em que evidenciou como, mesmo em contextos de crise humanitária, a lógica do sistema-mundo capitalista impõe limites concretos à autonomia normativa dos Estados do Sul Global, convertendo o direito interno em instrumento de viabilização de relações econômicas estruturalmente desiguais.

A possibilidade de que empresas farmacêuticas estrangeiras condicionarem a celebração de contratos públicos à aprovação prévia de alterações legislativas internas revelou um

enfraquecimento significativo da soberania regulatória do Estado brasileiro. Ao admitir garantias jurídicas e econômicas excepcionalmente gravosas — raramente observadas em outras contratações públicas — o ordenamento jurídico nacional incorporou exigências oriundas de atores privados transnacionais, reproduzindo uma racionalidade típica da modernidade colonial, na qual interesses econômicos externos se sobrepõem à autonomia normativa dos Estados periféricos.

Ao atender às exigências das corporações farmacêuticas multinacionais, o Brasil transferiu ao Estado e, por conseguinte, à coletividade os riscos jurídicos, econômicos e sanitários inerentes à aquisição emergencial de imunizantes, ao mesmo tempo em que assegurou a proteção dos interesses privados das indústrias globais. Reproduz-se, assim, a lógica segundo a qual os centros hegemônicos acumulam lucros extraordinários, enquanto os riscos são deslocados para os países periféricos, dinâmica estruturante do sistema-mundo moderno (Wallerstein, 2011).

Para compreender essa estrutura de dominação, Aníbal Quijano formulou o conceito de Matriz Colonial do Poder, posteriormente desenvolvido por Walter D. Mignolo como uma estrutura complexa e interligada de controles sobre a economia, a autoridade, o conhecimento e a subjetividade. Trata-se de uma rede de racionalidades que orienta ações institucionais e distribui benefícios de forma desigual, impondo consequências adversas às populações historicamente subalternizadas (Mignolo, 2017).

Na sua formulação original por Quijano, o “*patrón colonial de poder*” (matriz colonial de poder) foi descrito como quatro domínios inter-relacionados: controle da economia, da autoridade, do gênero e da sexualidade, e do conhecimento e da subjetividade. Os eventos se desdobraram em duas direções paralelas. Uma foi a luta entre Estados imperiais europeus, e a outra foi entre esses Estados e os seus sujeitos coloniais africanos e indígenas, que foram escravizados e explorados. (Mignolo, 2017, p.5)

Conforme Mignolo, na formulação original de Quijano, o *patrón colonial de poder* emergiu a partir da articulação entre a expansão do capitalismo europeu, a racialização da população mundial e a imposição de uma epistemologia eurocêntrica como referência universal. Esse processo estruturou-se a partir da exploração de povos africanos e indígenas, submetidos à escravização, à expropriação econômica e à negação de sua humanidade, estabelecendo hierarquias que permanecem operantes na contemporaneidade.

Sob essa perspectiva, a imposição de condicionantes normativas por multinacionais farmacêuticas ao Estado brasileiro evidencia como o colonialismo permanece entranhado nas instituições, nos discursos e nas práticas jurídicas modernas. A produção normativa nacional

passa a ser orientada por parâmetros externos, reafirmando a dependência histórico-estrutural da América Latina no sistema internacional.

Quijano apresenta o seguinte argumento: “Colonialidade do poder” e “dependência histórico-estrutural” são duas expressões-chave inter-relacionadas, que percorrem a história local e particular da América Latina, não tanto como uma entidade existente onde eventos “ocorreram” e “ocorrem”, não como uma série de eventos particulares cuja localização na colonialidade do poder e na dependência histórico-estrutural fez da América Latina o que ela foi no passado e é hoje, do período colonial no Peru a Fujimori, como a articulação paradigmática do neoliberalismo. A colonialidade do poder sublinha a organização geoeconômica do planeta, a qual articula o sistema mundial colonial/moderno e gerencia a diferença colonial. Essa distinção permite a Quijano ligar o capitalismo, através da colonialidade, ao trabalho e à raça (e não apenas à classe). (Mignolo, 2020, p.83)

Diante desse quadro, a conversão da saúde em mercadoria não pode ser compreendida como mero desvio administrativo ou contingência excepcional da pandemia. Trata-se da atualização de lógicas históricas que subordinam formas não hegemônicas de organização da vida aos interesses dos centros globais de poder, esvaziando o conteúdo emancipatório do direito humano à saúde.

Constatou-se que o direito a saúde, através da vacinação, deixou de ser um direito fundamental e passou a ser regido pelos interesses das multinacionais farmacêuticas que priorizaram a rentabilidade e a expansão de cadeias corporativas transnacionais, revelando que à saúde na pandemia da COVID-19 foi marcada pela colonialidade na medida em que “a ideia de que o dinheiro e o lucro se tornaram mediadores das relações de cuidado em saúde, a ponto de o setor saúde virar nicho de mercado” (Bezerra; Cavalcanti; Moura, 2023).

A Lei n.º 14.125/2021 revelou, ainda, por meio da codificação “os entes federados podem constituir garantias ou contratar seguro privado”, a introdução de um elemento juridicamente disruptivo no ordenamento brasileiro. Historicamente, a Administração Pública nacional sempre tratou a contratação de seguros privados com cautela, restringindo-a a hipóteses legalmente previstas, especialmente no âmbito das obras públicas.

A antiga lei de licitação e contratos n.º 8.666/1993 autorizava a exigência de seguro-garantia como mecanismo excepcional de proteção do interesse público (art. 56, § 1º, II), previsão que foi mantida e significativamente ampliada pela Lei n.º 14.133/2021, especialmente em seu art. 96. Com exceção dessas situações específicas — geralmente associadas a empreendimentos de grande vulto, contratos complexos ou atividades que envolvem riscos extraordinários —, a utilização de seguros privados pelo Poder Público sempre se caracterizou como exceção no direito administrativo brasileiro (Brasil, 1993; Brasil, 2021e).

A abertura normativa promovida pela Lei n.º 14.125/2021, representa, portanto, uma inflexão relevante nesse paradigma, ao autorizar o Estado a assumir um papel ampliado de

garantidor em benefício direto de corporações farmacêuticas transnacionais, deslocando para o poder público riscos que, em condições ordinárias, seriam suportados pelo fornecedor.

A autorização para a contratação de seguros privados como condição para a celebração de contratos de aquisição de imunizantes implicou a transferência do ônus jurídico e financeiro decorrente de eventuais danos, controvérsias contratuais ou responsabilidades relacionadas à segurança e aos efeitos adversos dos produtos. Em contrapartida, as grandes corporações farmacêuticas — majoritariamente sediadas no Norte Global — preservaram integralmente seus lucros, pois se viram desoneradas de responsabilidades.

Esse arranjo normativo operou, portanto, como um mecanismo contemporâneo de reprodução da colonialidade do poder, compreendida como a persistência de assimetrias estruturais que organizam as relações entre centros hegemônicos e periferias globais. O Estado brasileiro, inserido nesse tabuleiro geopolítico como ator periférico, passa a atuar como instância de legitimação e proteção jurídica de agentes privados internacionais, assumindo riscos que, em um cenário de maior simetria entre as partes contratantes, seriam compartilhados ou mesmo suportados pelas próprias corporações produtoras de tecnologias em saúde.

O dispositivo legal em análise reforça, assim, a lógica segundo a qual países periféricos permanecem posicionados como consumidores passivos de bens e tecnologias de alto valor agregado desenvolvidos nos países centrais, enquanto seguem estruturalmente excluídos das etapas estratégicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A dependência tecnológica, intensificada em contextos de emergência sanitária, como o da pandemia da COVID-19, ampliou a vulnerabilidade dos Estados do Sul Global e aprofundou o fosso epistêmico que limita o acesso equitativo à produção de conhecimento científico e tecnológico.

5.2.2 A colonialidade do saber na regulação e contratação de vacinas contra a COVID-19 no Brasil

Conforme analisado em capítulo 2 desta tese, a colonialidade do saber constitui um dos eixos centrais da matriz decolonial latino-americana e diz respeito aos processos históricos e estruturais por meio dos quais o conhecimento moderno, científico e institucionalizado foi constituído a partir de hierarquias epistêmicas forjadas no contexto da expansão colonial europeia.

Embora a colonização territorial tenha sido formalmente superada em grande parte do mundo, seus efeitos persistem de maneira profunda e difusa por meio de dispositivos

contemporâneos de produção, validação e circulação do conhecimento, tais como os sistemas internacionais de publicação científica, os critérios de avaliação acadêmica, as agências de fomento e os rankings globais de pesquisa. Esses mecanismos tendem a privilegiar epistemologias produzidas no Norte Global, marginalizando saberes locais, povos originários, afro-diaspóricos, comunitários e periféricos, que não se enquadram plenamente nos cânones metodológicos e linguísticos hegemônicos.

Nesse contexto, a colonialidade do saber evidencia a continuidade da dominação colonial no plano epistemológico, mesmo após os processos formais de independência política. A imposição de determinados paradigmas científicos e modos de pensar opera como forma de subalternização intelectual, condicionando os países periféricos a ocuparem posições subordinadas na divisão internacional do trabalho científico. No caso brasileiro, essa dinâmica manifesta-se na dependência de agendas de pesquisa exógenas, na valorização acrítica de referenciais teóricos estrangeiros e na constante necessidade de legitimação do conhecimento produzido internamente a partir de centros acadêmicos situados no Norte Global.

Desse modo, a pretensa universalidade do conhecimento científico hegemônico revela-se profundamente situada e atravessada por relações de poder. Ao se apresentar como neutro e superior, o saber produzido no Norte Global nem sempre se mostra adequado para a compreensão e a resolução de problemas complexos e específicos do Sul Global. A crítica decolonial, ao desnaturalizar tais hierarquias epistêmicas, propõe a valorização de uma ecologia de saberes (Santos, 2007), capaz de reconhecer a pluralidade epistemológica e de enfrentar os efeitos persistentes da colonialidade na produção científica brasileira.

Com base no método análise de conteúdo, foram extraídas, a partir das unidades de registro da Lei Federal n.º 14.006, de 28 de maio de 2020, categorias analíticas capazes de revelar elementos estruturantes do discurso normativo adotado pelo Estado brasileiro no contexto da pandemia de COVID-19.

Através dessas categorias, destacou-se a codificação “autoridades sanitárias estrangeiras”, expressão que sintetiza, de forma paradigmática, a lógica de dependência regulatória e epistêmica inscrita na legislação emergencial analisada.

A referida norma conferiu respaldo legal para que as autoridades sanitárias brasileiras autorizassem a importação, a distribuição e o uso de medicamentos, equipamentos e insumos sujeitos à vigilância sanitária sem registro prévio na ANVISA, desde que aprovados por determinadas autoridades regulatórias estrangeiras, quais sejam: a *Food and Drug Administration* (FDA), dos Estados Unidos; a *European Medicines Agency* (EMA), da União Europeia; a *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA), do Japão; e a *National*

Medical Products Administration (NMPA), da China. Tratou-se, portanto, de um mecanismo jurídico que instituiu o reconhecimento de decisões regulatórias externas como parâmetro suficiente para a circulação de tecnologias em saúde no território nacional.

Observa-se que, das quatro autoridades sanitárias elencadas pela legislação, três pertencem a países historicamente associados ao Norte Global, responsáveis pela consolidação e difusão dos padrões epistêmicos eurocêntricos que estruturam o sistema científico internacional. A exceção é a autoridade chinesa, cuja inserção geopolítica contemporânea desafia, ainda que parcialmente, a arquitetura hegemônica tradicional do poder global. Essa seleção normativa não é neutra, mas reflete uma hierarquia implícita de saberes, na qual determinados centros regulatórios são concebidos como referências universais de cientificidade e segurança.

A partir da publicação da Lei n.º 14.006/2020, o Brasil foi conduzido a reconhecer, validar e depender de estruturas científicas e regulatórias externas, o que evidencia não apenas uma estratégia técnica de celeridade administrativa, mas também uma expressão concreta da subalternização epistêmica da ciência nacional. A capacidade institucional da ANVISA, órgão constitucionalmente competente para a avaliação de medicamentos e insumos, foi relativizada, reforçando um imaginário de inferioridade técnica que ecoa padrões coloniais de desvalorização do conhecimento produzido no Sul Global.

Ainda que a pandemia tenha imposto desafios inéditos e exigido respostas rápidas, o contexto emergencial exacerbou uma dependência estrutural preexistente, conforme apontado por Grosfoguel (2020), segundo o qual a produção de conhecimento considerado “legítimo” permanece concentrada em centros geopolíticos dotados de poder econômico, científico e tecnológico. Assim, a urgência sanitária não apenas revelou, mas aprofundou a vulnerabilidade tecnológica e científica brasileira, sobretudo no que se refere à produção, validação e circulação de vacinas e insumos biomédicos, reforçando um imaginário de inferioridade técnica que ecoa o padrão colonial de desvalorização das produções científicas latino-americanas.

Ao reconhecer registros estrangeiros como equivalentes ou superiores aos nacionais, a legislação brasileira reproduziu a lógica da geopolítica do conhecimento, descrita por Walter Mignolo (2017), segundo a qual o saber científico produzido nos polos euro-norte-americanos é tratado como parâmetro universal, enquanto as capacidades institucionais e epistemológicas do Sul Global são invisibilizadas, subordinadas ou consideradas insuficientes. Tal hierarquização traduz o que Catherine Walsh (2009) denomina subalternização epistêmica, processo pelo qual Estados periféricos são compelidos a aceitar padrões externos como condição para acessar tecnologias estratégicas, especialmente em contextos de crise.

Embora a Lei n.º 14.006/2020 tenha sido apresentada como instrumento de proteção ao direito fundamental à saúde, previsto na Constituição de 1988 e em tratados internacionais de direitos humanos, sua operacionalização revela tensões relevantes. Ao desconsiderar o conhecimento científico local e condicionar a validação de medicamentos e insumos à aprovação prévia de autoridades do Norte Global, a norma compromete os princípios da igualdade, da autonomia científica e da autodeterminação, pilares essenciais da ordem democrática e dos direitos humanos.

Nesse cenário, a colonialidade do saber pode ser compreendida como uma forma de epistemicídio institucionalizado, especialmente quando se desacredita a ciência nacional e se ignoram as recomendações de especialistas locais. Conforme assevera Boaventura de Sousa Santos (2007), o epistemicídio consiste no processo político-cultural por meio do qual se destrói o conhecimento produzido por grupos subordinados, historicamente associado à própria lógica do genocídio, como ocorreu na destruição sistemática dos saberes indígenas durante a expansão colonial europeia.

A priorização acrítica das decisões regulatórias estrangeiras, portanto, não se limita a um expediente técnico de emergência, mas revela uma prática histórica de desvalorização do saber científico nacional, reforçando a colonialidade do saber nas políticas públicas de saúde. Trata-se de um fenômeno que se insere em um modelo de racionalidade científica positivista, que deslegitima outras formas de conhecimento e subordina instituições periféricas a centros hegemônicos.

Como advertem Bezerra, Cavalcanti e Mora (2023), esse “colonialismo no cuidado” prescreve unilateralmente padrões de saúde e doença, reprimindo subjetividades e ignorando as heterogeneidades dos corpos e dos contextos sociais.

Esse colonialismo no cuidado amálgama um padrão estético, massifica o consumo, descreve e prescreve o que é saúde e doença, interfere nos modos de cuidado por intermédio de modelos. Sob a égide de que fora do indivíduo há um conjunto de outros operadores do cuidado que são capazes de saber o que o outro necessita, delineiam e prescrevem unilateralmente o que o outro deve ou não fazer. Desse modo, as subjetividades são reprimidas e as heterogeneidades das condições dos corpos são desconsideradas. (Bezerra, Cavalcanti, Mora, 2023)

Para os autores, o colonialismo no cuidado representa uma forma contemporânea de dominação que opera não apenas no plano econômico ou político, mas sobretudo no campo simbólico, epistêmico e biopolítico. Esse colonialismo constrói e impõe um padrão estético normativo, ao mesmo tempo em que massifica práticas de consumo e estabelece definições hegemônicas sobre o que deve ser compreendido como saúde e doença. Trata-se, portanto, de

um processo que descreve e prescreve corpos, comportamentos e modos de viver, naturalizando modelos universais de cuidado.

A lógica colonial manifesta-se, ainda, na suposição de que o saber legítimo sobre o cuidado não reside no próprio sujeito, mas em instâncias externas — profissionais, instituições, protocolos e indústrias — que se arrogam a capacidade de determinar, de forma unilateral, aquilo que o outro necessita. Essa dinâmica produz uma expropriação da autonomia dos sujeitos, convertendo o cuidado em um ato técnico e normativo, dissociado das experiências concretas e singulares dos indivíduos.

Como consequência, o texto evidencia que tal racionalidade colonial reprime as subjetividades e aplanas as diferenças corporais, sociais e culturais, ignorando a diversidade das condições dos corpos e dos contextos de vida. Ao desconsiderar as heterogeneidades, o colonialismo no cuidado reforça hierarquias de saber e poder, perpetuando práticas que subordinam conhecimentos locais, experiências vividas e formas plurais de cuidado a modelos hegemônicos e universalizantes.

De modo semelhante, Chimamanda Ngozi Adichie alerta para os riscos da “história única”, que, ao se impor como narrativa dominante, produz apagamentos, hierarquias e desigualdades simbólicas. Não se trata de questionar os inúmeros avanços que levaram as melhores condições de vida; mas de duvidar quando esse conhecimento científico parece se tornar o único saber legítimo, e uma “história única” (Adichie, 2019) pode ser muito danosa para uma sociedade, uma vez que toda narrativa é fruto de relações de poder, e que a produção e circulação das histórias seguem lógicas de hierarquização cultural.

Ao se entrelaçarem, as análises de Quijano (2005; 2009) e Adichie (2019) evidenciam que a colonialidade não se manifesta apenas nas estruturas econômicas e políticas, mas também nas narrativas que moldam percepções e orientam práticas. As representações produzidas por histórias únicas não apenas constroem imaginários sociais, mas influenciam nas políticas públicas, relações internacionais, programas de cooperação e ajuda humanitária, além de repercutirem nas interações cotidianas. Nesse sentido, ambas as perspectivas demonstram que o combate à colonialidade exige a pluralização das vozes e dos saberes, rompendo com narrativas únicas que sustentam desigualdades históricas.

Conforme aponta Boaventura (2020), a resposta global à pandemia foi marcada pela centralidade das instituições e centros de pesquisa do norte global, relegando a segundo plano conhecimentos locais e saberes comunitários que poderiam contribuir para estratégias de prevenção e cuidado adaptadas a diferentes realidades sociais.

Em escala mundial, a hierarquia epistemológica também se refletiu na distribuição desigual das vacinas. Países com maior capacidade de produção e influência no mercado farmacêutico, situados majoritariamente no norte global, monopolizaram doses, enquanto nações do sul global enfrentaram longos atrasos.

Para Marilena Chauí a ecologia de saberes proposta por Boaventura “assenta o reconhecimento da pluralidade de saberes heterogêneos, da autonomia de cada um deles e da articulação sistêmica, dinâmica e horizontal entre eles” (Chauí; Santos, 2013, p.33).

Por fim, como observa Dayse Ventura (2013), o enfrentamento jurídico adequado de emergências sanitárias exige a elaboração de uma legislação específica e estruturada sobre vigilância epidemiológica, capaz de garantir tanto a atuação eficaz do Estado quanto a preservação dos direitos e liberdades fundamentais. Sem esse cuidado, normas emergenciais tendem a reproduzir assimetrias epistemológicas e a reforçar a colonialidade do saber, mesmo quando orientadas por finalidades aparentemente protetivas.

5.3 Uma análise da narrativa midiática sobre os contratos para aquisição de vacinas e a reprodução da colonialidade do poder no discurso público

A análise dos contratos celebrados entre a União (governo federal brasileiro) e as empresas farmacêuticas internacionais responsáveis pelo fornecimento de imunizantes contra a COVID-19 exige, como pressuposto metodológico inicial, o reconhecimento de um obstáculo de natureza estrutural: a indisponibilidade pública desses instrumentos contratuais. Os referidos contratos não foram amplamente divulgados, permanecendo resguardados por cláusulas de confidencialidade, impostas unilateralmente ou pactuadas segundo exigências formuladas pelas corporações transnacionais fornecedoras.

A circunstância, além de atípica em contratações de elevado impacto coletivo e sanitário, tensionou de modo significativo os princípios estruturantes da Administração Pública brasileira notadamente os da publicidade, da transparência e do controle social, ao mesmo tempo em que instituiu um cenário de acentuada assimetria informacional entre o Estado brasileiro, a sociedade civil e agentes privados dotados de expressiva capacidade econômica, tecnológica e geopolítica.

A impossibilidade de acesso direto aos contratos, respectivos aditivos e anexos inviabilizou o escrutínio documental integral e limitou a análise formal de seus termos jurídicos. Não obstante, embora constitua uma limitação, tal obstáculo não comprometeu a viabilidade da

investigação científica. A pesquisa valeu-se, de forma sistemática e criteriosa, de fontes secundárias qualificadas, organizadas e trianguladas, em consonância com os pressupostos da análise documental conforme análise de conteúdo delineados por Bardin (2020).

Nesse sentido, foram examinadas reportagens investigativas produzidas por veículos de comunicação nacionais e internacionais de reconhecida credibilidade, bem como entrevistas concedidas por autoridades públicas que ocuparam cargos de direção e chefia no período pandêmico. Ademais, foram analisadas declarações oficiais emanadas de órgãos governamentais e depoimentos prestados perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da COVID-19), cuja relevância decorre tanto da amplitude de seu escopo investigativo quanto da diversidade institucional e política dos agentes convocados a depor.

Também integraram o corpus analítico discursos técnicos e posicionamentos institucionais da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Instituto Butantan e de institutos de pesquisa vinculados ao Ministério da Saúde, além de manifestações de parlamentares e especialistas que acompanharam, de modo direto, os processos de negociação e aquisição dos imunizantes.

O conjunto dessas fontes permitiu a reconstrução indireta, porém consistente, de elementos centrais do contexto negocial que envolveu empresas como Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan, entre outras fornecedoras internacionais, possibilitando a identificação de padrões decisórios, condicionantes contratuais e assimetrias estruturais subjacentes às tratativas.

Cumprе salientar que o recurso a tais fontes não implica flexibilização indevida do rigor metodológico. Ao contrário, sua utilização foi orientada por procedimentos estritos de validação, triangulação e crítica interna e externa das evidências, com vistas à mitigação de vieses e ao fortalecimento da consistência interpretativa. Trata-se de prática amplamente reconhecida e legitimada no âmbito da pesquisa qualitativa contemporânea e dos estudos críticos de políticas públicas. Embora não substituam os documentos contratuais originais, esses materiais ofereceram dados empíricos relevantes para a compreensão das dinâmicas de poder, negociação e dependência tecnológica instauradas no contexto da emergência sanitária global.

A indisponibilidade dos contratos, contudo, não deve ser interpretada exclusivamente como limitação técnica ou contingencial, mas também como indicador da inserção subordinada do Brasil na hierarquia internacional da indústria farmacêutica. A opacidade contratual reproduz e atualiza padrões históricos de assimetria entre países centrais, considerados detentores de propriedade intelectual, domínio tecnológico e capacidade industrial, e países periféricos, estruturalmente dependentes de transferência tecnológica e particularmente vulneráveis a

regimes de condicionalidades contratuais impostos por agentes econômicos transnacionais. Nesse sentido, o sigilo exigido pelas farmacêuticas ultrapassa a esfera administrativa e projeta-se como manifestação contemporânea da lógica da colonialidade.

A análise das ações governamentais relacionadas à aquisição de vacinas, portanto, não pode ser dissociada dos marcos teóricos da colonialidade, sobretudo no que concerne à dependência tecnológica, à subordinação jurídica e à fragilidade do poder regulatório dos Estados periféricos diante das corporações transnacionais, em especial o Brasil. A imposição de cláusulas de confidencialidade, associada à exigência de garantias financeiras e à transferência de riscos aos entes públicos, evidenciou uma forma de contratualização que reforçou a desigualdade estrutural entre o Norte Global produtor, detentor de patentes e controlador das cadeias de valor, e o Sul Global, consumidor, dependente e exposto a mecanismos coercitivos de mercado.

Dessa forma, a ausência de transparência não se apresenta apenas como entrave documental, mas como elemento constitutivo da própria lógica contemporânea de governança global da saúde, atravessada por interesses corporativos, disputas geopolíticas e racionalidades econômicas que frequentemente se sobrepõem às exigências de soberania sanitária, equidade distributiva e justiça global. Trata-se, assim, de um campo analítico privilegiado para o exame da intersecção entre direito, economia política internacional e teoria decolonial, sobretudo porque a pandemia de COVID-19 tornou explícito que a produção, a circulação e a distribuição de tecnologias em saúde não se realizam em um ambiente neutro, mas em sistemas profundamente marcados por desigualdades históricas e estruturais.

À luz dessas considerações, e como etapa conclusiva do percurso investigativo, impõe-se o aprofundamento da análise crítica da colonialidade e de sua incidência direta sobre os processos de contratualização de imunizantes destinados ao enfrentamento da COVID-19 no Brasil. O capítulo que se segue tem por objetivo evidenciar como a lógica colonial, em suas dimensões econômica, jurídica e epistêmica, conformou o processo decisório estatal, delimitou as margens de atuação governamental e condicionou o acesso do país a tecnologias estratégicas de saúde no contexto da mais grave emergência sanitária do século XXI.

5.3.1 A colonialidade do poder e sua influência quando da contratualização de imunizantes para o combate a COVID-19 no Brasil

No contexto brasileiro, o crescimento exponencial dos óbitos decorrentes da COVID-19 conferiu à imunização caráter estratégico, prioritário e inadiável, convertendo a vacina no principal instrumento de contenção da disseminação viral e de mitigação dos impactos sanitários, sociais e econômicos da pandemia. A configuração desse cenário crítico impulsionou a celebração de contratos administrativos destinados à aquisição de imunobiológicos junto a corporações farmacêuticas transnacionais, em um ambiente profundamente marcado por assimetrias informacionais, pressões políticas internas e externas e elevado grau de incerteza científica.

Cumprе salientar que tais instrumentos contratuais, ainda na fase preliminar de negociação, passaram a ocupar posição central no debate público nacional, sendo amplamente noticiados por veículos de imprensa em razão das exigências formuladas pelas empresas detentoras da tecnologia vacinal. Essas corporações condicionaram o fornecimento dos imunizantes à aceitação de cláusulas contratuais de elevada rigidez, muitas das quais foram qualificadas por analistas jurídicos e especialistas em direito público como potencialmente abusivas ou lesivas ao interesse público, especialmente no que se refere à alocação assimétrica de riscos, à exigência de garantias soberanas e à ampliação das responsabilidades atribuídas ao Estado contratante.

Tal conjuntura revelou, de forma particularmente eloquente, o profundo desequilíbrio de poder que estrutura as negociações entre países em desenvolvimento e grandes conglomerados farmacêuticos globais, desequilíbrio que se acentuou em razão do caráter emergencial da crise sanitária. A urgência por soluções imediatas, associada à escassez global de vacinas e à elevada concentração da capacidade tecnológica e produtiva em um número restrito de agentes privados, restringiu significativamente o poder de barganha estatal, reduzindo as possibilidades de negociação em bases equitativas e fragilizando princípios basilares da Administração Pública, tais como a supremacia do interesse público, a legalidade estrita e a proporcionalidade na assunção de encargos e riscos.

Nesse horizonte analítico, Deisy Ventura (2013) assinala que a saúde global é atravessada por dinâmicas de poder que reiteradamente posicionam Estados periféricos em condições de dependência estrutural em relação a agentes privados transnacionais. Para a autora, a forma como se constituem as relações contratuais em contextos de emergência

sanitária explicita um dos desafios centrais da contemporaneidade: a necessidade de compatibilizar a urgência do acesso a tecnologias essenciais à proteção da vida com a preservação da soberania estatal, da transparência decisória e da equidade nas relações internacionais em saúde.

A pandemia de COVID-19, portanto, não apenas intensificou tais tensões preexistentes, como também tornou visível a colonialidade inscrita nos fluxos globais de produção científica, desenvolvimento tecnológico e fabricação de imunobiológicos. Essa lógica manifestou-se, de modo concreto, na imposição de condições contratuais desvantajosas aos países historicamente situados na periferia do sistema internacional, evidenciando que o acesso a tecnologias estratégicas de saúde permanece condicionado por hierarquias estruturais que reproduzem desigualdades históricas no âmbito da governança global da saúde.

Logo, a transformação da saúde em direito ainda enfrenta imensos desafios, com destaque para três aspectos de vasta repercussão, tanto no direito como nas relações internacionais, que serão tratados a seguir: a sujeição do Estado a cláusulas leoninas, a mutação do mercado da saúde e a emergência do ser vulnerável em detrimento do cidadão. (Ventura, 2013, p. 28)

Ventura afirma que, embora a saúde tenha sido juridicamente reconhecida como um direito, sua efetiva concretização permanece atravessada por obstáculos estruturais profundos. A autora indica que esse processo não se esgota na positivação normativa, pois é condicionado por dinâmicas políticas, econômicas e internacionais que limitam a capacidade dos Estados de garantir tal direito.

O primeiro desafio mencionado — a sujeição do Estado a cláusulas leoninas — aponta para a perda de autonomia estatal diante de acordos, contratos e compromissos internacionais ou privados que impõem obrigações desproporcionais, frequentemente favoráveis a atores econômicos transnacionais. Nessa lógica, o Estado passa a operar sob constrangimentos jurídicos que fragilizam sua função de garantidor do direito à saúde.

O segundo aspecto — a mutação do mercado da saúde — evidencia a transformação progressiva da saúde em mercadoria, submetida às racionalidades do mercado, da eficiência econômica e do lucro. Tal mutação desloca a saúde do campo dos direitos sociais para o campo do consumo, o que aprofunda desigualdades de acesso e tensiona os princípios de universalidade e equidade.

Por fim, ao mencionar a emergência do ser vulnerável em detrimento do cidadão, Ventura critica a substituição da figura do cidadão titular de direitos pela do indivíduo vulnerável, destinatário de políticas compensatórias ou assistenciais. Esse deslocamento enfraquece a noção de cidadania plena e transforma o direito à saúde em objeto de tutela

seletiva, dependente de critérios de risco, emergência ou fragilidade, e não de um reconhecimento universal.

Assim, a autora revela que a transformação da saúde em direito ocorre em um contexto marcado pela erosão da soberania estatal, pela mercantilização da vida e pela reconfiguração da cidadania, fatores que comprometem a efetividade do direito à saúde e produzem impactos relevantes tanto no plano jurídico quanto nas relações internacionais.

A análise proposta por Ventura (2013) dialoga de modo direto com a perspectiva crítica da colonialidade do poder, conforme formulada por Aníbal Quijano (2005) ao evidenciar que a transformação da saúde em direito ocorre sob condições estruturais herdadas da modernidade colonial.

A sujeição do Estado a cláusulas leoninas revela que, no plano internacional, a soberania estatal permanece hierarquizada, especialmente nos países periféricos, que se veem constrangidos por regimes jurídicos, econômicos e sanitários globais moldados a partir de interesses hegemônicos. Nesse sentido, a saúde, embora formalmente reconhecida como direito humano, é regulada por uma racionalidade colonial que subordina a vida às exigências do capital e da governança global, o que se evidenciou na dinâmica de aquisição das vacinas contra a COVID-19 pelo Brasil, que revelou, de forma inequívoca, a dependência estrutural do Estado brasileiro em relação às grandes corporações farmacêuticas transnacionais, inseridas nas cadeias globais de produção e distribuição de tecnologias em saúde.

No curso das negociações contratuais, tais empresas passaram a impor condições significativamente restritivas, marcadas por acentuada assimetria de poder, as quais incluíam: renúncia à jurisdição nacional, mitigação da soberania estatal, limitação ou exclusão da responsabilidade civil dos fornecedores, cláusulas extensas de confidencialidade e mecanismos de garantia financeira em favor das empresas contratadas, dispositivos usualmente classificados pela doutrina jurídica como cláusulas leoninas (Brasil, 2021a).

Esses elementos foram amplamente noticiados pela imprensa nacional e internacional e, posteriormente, reconhecidos pelo próprio Governo Federal, por meio de manifestações institucionais do Ministério da Saúde, que admitiu expressamente a excepcionalidade dos termos exigidos pelas fornecedoras internacionais e a posição de vulnerabilidade do Brasil nas negociações. Em pronunciamento oficial, o Ministério da Saúde destacou que, para além da frustração quanto à oferta inicialmente anunciada, as cláusulas apresentadas pela empresa Pfizer constituíam obstáculos relevantes à formalização dos contratos, dada sua incompatibilidade com princípios estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro.

Entretanto, não somente a frustração que a empresa Pfizer causaria aos brasileiros, as cláusulas leoninas e abusivas que foram estabelecidas pelo laboratório criam uma barreira de negociação e compra. Como exemplo, citamos cinco trechos das cláusulas do pré-contrato, que já foram amplamente divulgadas pela imprensa:

- 1) Que o Brasil renuncie à soberania de seus ativos no exterior em benefício da Pfizer como garantia de pagamento, bem como constitua um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior;
- 2) O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras com a instituição de convenção de arbitragem sob a égide das leis de Nova York, nos Estados Unidos;
- 3) Que o primeiro e segundo lotes de vacinas seja de 500 mil doses e o terceiro de um milhão, totalizando 2 milhões no primeiro trimestre, com possibilidade de atraso na entrega (número considerado insuficiente pelo Brasil);
- 4) que havendo atraso na entrega, não haja penalização; e
- 5) Que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil por efeitos colaterais graves decorrentes do uso da vacina, indefinidamente. (Brasil, 2021a)

Portanto, o Governo Federal tornou público cinco dispositivos constantes do pré-contrato proposto pela Pfizer, amplamente divulgados pelos meios de comunicação, a saber: (i) a exigência de renúncia à soberania sobre ativos estatais localizados no exterior, a serem utilizados como garantia de pagamento, bem como a constituição de fundo garantidor em conta bancária internacional; (ii) o afastamento da jurisdição brasileira, com a adoção de convenção de arbitragem regida pelas leis do Estado de Nova York, nos Estados Unidos; (iii) a previsão de fornecimento inicial considerado insuficiente pelo Estado brasileiro, correspondente a 500 mil doses no primeiro e no segundo lotes e um milhão no terceiro, totalizando dois milhões de doses no primeiro trimestre, com possibilidade de atrasos; (iv) a ausência de qualquer penalidade em caso de descumprimento dos prazos de entrega; e (v) a imposição de termo de responsabilidade pelo qual o Estado brasileiro assumiria integralmente os riscos por eventuais efeitos adversos graves, isentando o laboratório, de forma ampla e por prazo indeterminado, de responsabilidade civil decorrente do uso do imunizante (Brasil, 2021a).

As exigências suscitaram relevantes questionamentos acerca da soberania nacional, da dependência tecnológica e da justiça global, elementos que continuam a estruturar e tensionar as relações internacionais contemporâneas, especialmente no campo da saúde pública. Tais disposições evidenciaram, de modo contundente, a persistente subordinação dos países periféricos aos interesses das corporações transnacionais, comprometendo o exercício da autodeterminação tecnológica e científica e reafirmando as assimetrias históricas que caracterizam a inserção do Sul Global no sistema mundial.

Assim, com o objetivo de viabilizar a aquisição dos imunizantes, o Governo Federal, além de promover a aprovação das legislações emergenciais analisadas no capítulo precedente, celebrou posteriormente contratos com as multinacionais farmacêuticas Pfizer/BioNTech e

Janssen (Johnson & Johnson). Essas contratações, contudo, rapidamente ganharam destaque no debate público em razão do caráter excepcional e controverso de suas cláusulas, cuja existência foi expressamente admitida pelo próprio Estado brasileiro (CNNBrasil, 2021a).

É inegável que o contexto de emergência sanitária demandava uma atuação estatal célere e eficaz, voltada à proteção da vida e da saúde da população. Todavia, a excepcionalidade de uma crise não pode servir de fundamento para a relativização irrestrita de princípios constitucionais estruturantes, notadamente aqueles que resguardam a soberania nacional, a legalidade administrativa, a transparência e a indisponibilidade do interesse público.

Antes de analisar cada codificação da fonte acima citada, é imprescindível, neste contexto, apreciar a cláusula de confidencialidade que ainda persiste nos contratos firmados com as transnacionais para aquisição de vacina contra a COVID-19.

A repercussão do tema pela imprensa nacional e internacional foi ampla e consistente, contribuindo para a publicização das condições excepcionais que marcaram os contratos celebrados pelo Estado brasileiro. O portal Brasil247 (2021) noticiou que os instrumentos contratuais firmados com as indústrias farmacêuticas continham cláusulas expressas de confidencialidade, impondo ao Poder Público a obrigação de manter determinadas informações sob sigilo pelo prazo de até dez anos.

No mesmo sentido, o portal Brasil247 (2021) reportou que o site O Antagonista confirmou a existência desse prazo decenal de restrição, informando que, ao solicitar acesso aos documentos junto ao Ministério da Saúde, recebeu como resposta que os contratos se encontram com restrição de acesso, em razão das obrigações assumidas contratualmente com a farmacêutica.

A condição excepcional de sigilo aplicada aos contratos administrativos foi expressamente confirmada pelo próprio Ministério da Saúde, cujo portal oficial informa que:

“Conforme termos e condições contratuais, os contratos nº 51/2021, 52/2021, 116/2021 e 117/2021 são confidenciais e, neste momento, não podem ser disponibilizados para visualização externa” (Brasil, 2025).

Os contratos mencionados correspondem às aquisições de vacinas contra a COVID-19 celebradas entre a União e as empresas Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer Export BV, Pfizer Overseas LLC e Pfizer Export Manufacturing, o que evidenciou a manutenção de um regime de confidencialidade mesmo após o decurso de anos desde a formalização das contratações, acentuando a excepcionalidade jurídica dessas avenças no âmbito do direito administrativo brasileiro (Brasil, 2025).

A vinculação direta desses instrumentos contratuais à aquisição de imunizantes contra a COVID-19 é corroborada, ainda, através da ficha de tramitação da proposição RIC 1031/2021 que foi apresentada por Deputados Federais no exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo (Brasil, 2023). Conforme consta no referido documento, os contratos são identificados da seguinte forma:

a) Processo SEI nº 25000.175285/2020-14 — Contrato nº 51/2021, celebrado com a Janssen Pharmaceutica NV;

b) Processo SEI nº 25000.171832/2020-92 — Contrato nº 52/2021, celebrado com a Pfizer Export BV;

c) Processo SEI nº 25000.048532/2021-91 — Contrato nº 116/2021, celebrado com a Pfizer Overseas LLC;

d) Processo SEI nº 25000.062483/2021-08 — Contrato nº 117/2021, celebrado com a Pfizer Export BV.

Esses elementos documentais comprovam de forma objetiva, que os contratos submetidos ao regime de confidencialidade dizem respeito exclusivamente à aquisição de vacinas contra a COVID-19, afastando qualquer dúvida quanto à sua finalidade e reforçando o caráter excepcional do tratamento jurídico conferido a tais contratações.

Contudo, o princípio da publicidade consagrado no art. 37, *caput*, da Constituição da República de 1988, constitui um dos pilares normativos do Estado Democrático de Direito e da própria estrutura republicana brasileira. Tal princípio orienta a atuação administrativa pela transparência, pelo controle social e pela responsabilização governamental, não se limitando à mera divulgação formal dos atos administrativos (Brasil, 1988).

A publicidade desempenha função estruturante na democracia contemporânea, na medida em que viabiliza a participação cidadã, o controle dos atos estatais e a legitimação das políticas públicas. Nesse sentido, Di Pietro (2021) sustenta que a transparência constitui condição indispensável ao exercício das liberdades civis e ao fortalecimento das instituições democráticas, permitindo ao cidadão conhecer, avaliar e contestar decisões estatais que impactam o interesse coletivo.

Para além da norma constitucional, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o direito fundamental de acesso às informações públicas (Brasil, 2011). A edição da LAI representou marco normativo fundamental na consolidação de uma cultura de governo aberto no Brasil, ao institucionalizar a transparência ativa, consistente na obrigação estatal de divulgar

espontaneamente informações de interesse coletivo, e a transparência passiva, que assegura ao cidadão o direito de solicitar dados não previamente disponibilizados.

Assim, no caso específico dos contratos celebrados entre a União e as transnacionais farmacêuticas para a aquisição de vacinas contra a COVID-19, a imposição de cláusulas de confidencialidade que impediram a divulgação integral dos instrumentos contratuais à sociedade, à imprensa e até mesmo ao Congresso Nacional, configura afronta direta aos princípios constitucionais da publicidade e da legalidade, bem como ao regime jurídico instituído pela Lei de Acesso à Informação. Tal prática esvazia os mecanismos de controle democrático e fragiliza o sistema de freios e contrapesos, ao limitar o escrutínio público sobre decisões de elevado impacto social, econômico e sanitário.

A adoção desse procedimento excepcional colocou o Estado brasileiro em posição evidente de assimetria e vulnerabilidade nas negociações internacionais, submetendo-o a condições impostas por corporações privadas transnacionais dotadas de significativo poder econômico, tecnológico e político. Trata-se de situação que extrapola o plano jurídico-administrativo e demanda uma leitura crítica a partir das estruturas históricas que conformam as relações internacionais contemporâneas.

Nesse sentido, a literatura decolonial oferece um arcabouço teórico particularmente fecundo para a compreensão desse fenômeno. Quijano (2005) conceitua a colonialidade do poder como a persistência de hierarquias produzidas no período colonial, que continuam a estruturar as relações econômicas, políticas e epistêmicas no mundo moderno. Segundo o autor, essa lógica manifesta-se, entre outros aspectos, pela concentração do conhecimento científico, da capacidade tecnológica e dos centros decisórios nos países centrais, relegando os países periféricos à condição de dependência estrutural.

Autores como Grosfoguel (2016), Maldonado-Torres (2007) e Lugones (2008) aprofundam essa análise ao demonstrar que a colonialidade opera como uma matriz de poder que naturaliza desigualdades globais, invisibiliza saberes locais e legitima a imposição de padrões hegemônicos nas relações internacionais. No campo da saúde global, essa lógica se materializou na dependência farmacêutica dos países latino-americanos, os quais, diante da ausência de autonomia científica e industrial, foram compelidos a aceitar cláusulas contratuais unilaterais e desfavoráveis impostas por conglomerados transnacionais.

Aplicada ao contexto brasileiro, a colonialidade do poder manifesta-se na forma do controle do conhecimento científico, da produção tecnológica e dos insumos estratégicos que permanecem concentrado nos países desenvolvidos, enquanto nações em desenvolvimento assumem os riscos sociais, sanitários e econômicos das decisões tomadas por grandes

corporações. A dependência do Brasil em relação à indústria farmacêutica internacional, responsável pela comercialização das vacinas contra a COVID-19, reforçou padrões históricos de subordinação e expôs, de maneira contundente, a insuficiência de investimentos estatais sustentados em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor da saúde.

A imposição de cláusulas pelas indústrias farmacêuticas ao Estado brasileiro, praticamente “ditando” os termos contratuais, resultou na restrição do acesso público aos contratos celebrados, afastando não apenas a sociedade civil e a imprensa, mas também órgãos de controle e fiscalização, configurando grave violação grave ao princípio constitucionais da publicidade e ao direito fundamental à informação, comprometendo a integridade do regime jurídico-administrativo e a própria legitimidade das decisões governamentais.

A pandemia de COVID-19, para além de revelar a vulnerabilidade estrutural dos países periféricos no campo da saúde pública, evidenciou a permanência de estruturas coloniais de poder que continuam a reproduzir mecanismos históricos de dominação. Nesse contexto, a ausência de publicidade, imposta pelas contratadas nos contratos de aquisição de vacinas, representou uma forma de submissão do Governo Federal aos interesses das grandes corporações farmacêuticas. A realidade serve de alerta para os riscos concretos da influência da colonialidade do poder no Estado brasileiro, capaz de fragilizá-lo frente ao poder econômico global e de comprometer a efetividade dos direitos fundamentais em contextos de crise.

Ultrapassada a questão relaciona a confidencialidade, evidenciou-se a existência de outras exigências contratuais relevantes, as quais foram devidamente codificadas no âmbito da presente pesquisa, qual seja: “ausência de responsabilidade civil”.

A referida exigência contratual revelou-se particularmente significativa, na medida em que previa a exclusão da responsabilidade civil da contratada por eventuais efeitos adversos decorrentes da utilização dos imunizantes, deslocando os riscos inerentes à vacinação para o Poder Público e para os próprios destinatários da política sanitária.

A exigência, imposta pelas transnacionais farmacêuticas, de cláusula contratual que isentavam integralmente tais corporações de qualquer responsabilização civil por eventuais danos causados pelas vacinas contra a COVID-19 somente se tornou juridicamente viável após a aprovação da Lei Federal n.º 14.125, de 10 de março de 2021 (Brasil, 2021d), que foi aprovada mediante uma exigência da empresa Pfizer e Janssen (Brasil, 2022b).

Assim, conforme demonstrado no capítulo precedente, o referido diploma normativo autorizou a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adquirirem imunizantes e, simultaneamente, assumirem integralmente os riscos associados à responsabilidade civil por

efeitos indesejáveis, ainda que inexistente comprovação definitiva de nexo causal entre o produto e o dano alegado.

A alocação excepcional de riscos representou uma ruptura substantiva com a lógica tradicional dos contratos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, historicamente estruturados sobre os princípios do equilíbrio econômico-financeiro, da supremacia do interesse público e da repartição proporcional de encargos entre as partes contratantes. Em lugar desse modelo, instituiu-se uma arquitetura contratual assimétrica e acentuadamente desfavorável ao Estado, no qual a responsabilidade civil passou a assumir contornos objetivos, exclusivos e potencialmente ilimitados.

À luz de obras clássica da responsabilidade civil (Gonçalves, 2021) e do regime de tutela do consumidor, especialmente o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990) tal configuração extrapola os parâmetros ordinários de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que considerada a excepcionalidade do contexto pandêmico.

Sob uma perspectiva crítica, essa dinâmica contratual revelou-se expressão concreta da colonialidade do poder, materializada na subordinação jurídica, tecnológica e econômica dos países periféricos aos interesses das corporações transnacionais sediadas no Norte Global. A imposição de cláusulas leoninas pelas indústrias farmacêuticas evidenciaram o exercício de um poder estruturalmente assimétrico, capaz de deslocar para os Estados periféricos a totalidade dos riscos sanitários, financeiros e jurídicos inerentes à produção, à distribuição e à utilização dos imunizantes.

A aceitação dessas condições pelo Estado brasileiro evidenciou, ainda, a dimensão jurídico-política da dependência, conforme formulada pela tradição crítica latino-americana, em especial nos estudos de Theotônio dos Santos (2018). Para o autor, as relações de dominação econômica, tecnológica e política entre países centrais e periféricos são historicamente produzidas e continuamente reproduzidas, de modo que o subdesenvolvimento não deve ser compreendido como um estágio transitório, mas como uma condição estrutural do capitalismo mundial. Nesse sistema, a acumulação nos países centrais ocorre por meio da transferência sistemática de excedentes da periferia, revelando que a desigualdade global constitui elemento funcional do sistema, e não uma disfunção eventual.

Nesse contexto, a obra de Theotônio dos Santos dialoga diretamente com as reflexões de Milton Santos (2022), ao evidenciar como as grandes corporações, sob o discurso da modernização, da eficiência e da geração de empregos, constroem uma narrativa de indispensabilidade que legitima sua capacidade de pressionar e subordinar o poder público. Segundo Milton Santos, essas empresas são frequentemente apresentadas como “salvadoras”

dos territórios em que se instalam, sendo reconhecidas como credoras de gratidão institucional em razão dos supostos benefícios econômicos que aportariam.

O referido discurso produz a crença na indispensabilidade das grandes empresas, convertendo-se em elemento central da chamada “guerra entre lugares” e, em muitos casos, sustentando práticas de chantagem institucional diante do poder público, mediante a ameaça de retirada de investimentos quando suas demandas não são atendidas. Nessas circunstâncias, o Estado passa a atuar de forma subordinada, compelido e arrastado pelas exigências do capital transnacional. À medida que esse nexo de dependência se impõe, instala-se, conforme alerta Milton Santos, a semente da ingovernabilidade, já fortemente presente no contexto brasileiro, ainda que suas múltiplas dimensões não tenham sido plenamente avaliadas (Santos, 2022).

Todavia mediante o discurso oficial, tais empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são apontadas como credores de reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí a crença de sua indispensabilidade, fator da presente guerra entre lugares e, em muitos casos, de sua atitude de chantagem diante do poder público, ameaçando ir embora quando não atendidas em seus reclamos. Assim, o poder público passa a ser subordinado, compelido, arrastado. A medida que se impõe esse nexo das grandes empresas, instala-se a semente da ingovernabilidade, já fortemente implantada no Brasil, ainda que sua dimensão não tenha sido adequadamente avaliada. (Santos, 2022, p.79)

A dependência tecnológica e científica dos países periféricos, especialmente nos setores farmacêutico e biotecnológico, limitou de forma significativa sua capacidade de negociação internacional e comprometeu sua autonomia contratual. Nesse contexto, a alegada “livre pactuação” entre o Estado e as corporações transnacionais não se configurou como expressão de igualdade entre as partes, mas como uma negociação marcada por coerção estrutural, na qual a urgência sanitária e o monopólio tecnológico atuaram como vetores determinantes de pressão. A assimetria de poder impediu a formação de um consentimento verdadeiramente livre, convertendo a necessidade de proteção da vida em instrumento de subordinação jurídica e política.

Para Julián-Campuzano (2009), a intensificação dos fluxos comerciais globais, associada à crescente dependência dos Estados em relação às corporações transnacionais e às forças que operam no mercado internacional, produz impactos diretos sobre a capacidade estatal de controle, sobre a formulação de políticas públicas e sobre a própria soberania decisória dos governos. Segundo o autor, a erosão progressiva da autonomia estatal decorre não apenas de fatores econômicos, mas da consolidação de estruturas de poder transnacional que condicionam as escolhas políticas internas, especialmente em contextos de crise.

A responsabilidade civil transferida ao Estado brasileiro pelas multinacionais farmacêuticas durante a pandemia de COVID-19 tornou patente uma relação contratual

profundamente assimétrica, marcada por desequilíbrios jurídicos e políticos. Essa condição foi publicamente reconhecida pelo Ministro da Saúde, que, em pronunciamento realizado em 11 de janeiro de 2021, afirmou que as condições impostas pelos fabricantes para a aquisição das vacinas não eram vantajosas para o Governo Federal, em razão, sobretudo, das cláusulas exigidas pela Pfizer, que previam isenção integral de responsabilidade por eventuais efeitos adversos, bem como a disponibilidade de ativos brasileiros no exterior como garantia, com depósitos indefinidos para eventuais ações judiciais fora do território nacional (Poder360, 2021).

Embora as vacinas tenham desempenhado papel essencial na contenção da pandemia e na redução da mortalidade, os termos sob os quais foram adquiridas expuseram fragilidades estruturais do sistema normativo brasileiro, assim como a vulnerabilidade do país frente ao poder econômico, tecnológico e jurídico das grandes corporações transnacionais. Essas fragilidades, longe de constituírem exceções conjunturais, encontram-se encobertas e, ao mesmo tempo, legitimadas pela lógica da colonialidade do poder, que naturaliza relações de subordinação e dependência no plano global.

Conforme assinala Quijano (2005), toda forma de dominação pressupõe força e violência, ainda que, na modernidade, essas não se exerçam de modo explícito, contínuo ou diretamente coercitivo. Ao contrário, operam de forma velada, mediadas por estruturas institucionalizadas de autoridade coletiva ou pública, que se apresentam como legítimas por meio de ideologias constitutivas das relações intersubjetivas entre os diversos setores sociais. O Estado, nesse sentido, constitui uma dessas estruturas centrais de legitimação. Para o autor, é precisamente a colonialidade do poder que funciona como a “argamassa” profunda dessa legitimação, exigindo uma análise crítica das relações entre o padrão de exploração capitalista, o Estado e os mecanismos coloniais de dominação que persistem no mundo contemporâneo.

Ao “ditar” unilateralmente os termos contratuais ao governo brasileiro, aproveitando-se da desigualdade de acesso às tecnologias em saúde e da dependência dos países em desenvolvimento em relação à aquisição de imunizantes, as corporações farmacêuticas escancararam a fragilidade estrutural do Estado frente à arquitetura do poder global que protege interesses privados transnacionais.

Trata-se de um poder que, conforme analisa Dowbor (2017), decorre do controle estruturado e hierárquico das cadeias produtivas globais, gerando não apenas enorme poder econômico — frequentemente superior ao Produto Interno Bruto de numerosos Estados —, mas também poder político, pela apropriação de parcelas significativas dos aparelhos estatais, e

poder cultural, pela influência exercida por meio da mídia de massa e da produção de padrões de consumo e comportamento funcionalmente alinhados aos interesses corporativos.

Controlar de forma estruturada e hierárquica uma cadeia produtiva gera naturalmente um grande poder econômico, político e cultural. Econômico, pelo do imenso fluxo de recursos, maior do que o PIB de numerosos países. Político, pelo da apropriação de grande parte dos aparelhos de Estado. E cultural, pelo fato da mídia de massa mundial criar, com pesadíssimas campanhas publicitárias, uma cultura de consumo e dinamismo comportamentais que lhes interessa, gerando boa parte dos problemas globais que enfrentamos. (Dowbor, 2017, p.39)

Dessa forma, o caso da aquisição de vacinas contra a COVID-19 no Brasil evidenciou como a colonialidade do poder continua a operar como uma estrutura das relações internacionais contemporâneas, condicionando decisões estatais, fragilizando a soberania jurídica e limitando a capacidade dos países periféricos de proteger seus próprios interesses públicos em contextos de emergência global.

As cláusulas leoninas que foram impostas refletiram a sedimentação da colonialidade do poder, que nos dizeres de Quijano (2009) as relações de dominação contemporâneas — nos Estados, nas instituições, nos saberes e nas hierarquias sociais — continuam sendo moldadas por lógicas coloniais, como a classificação racial, a desigualdade entre centros e periferias e a subordinação de determinados povos e conhecimentos. A colonialidade, portanto, atravessa todos os espaços concretos de poder, reproduzindo desigualdades mesmo após o fim jurídico do colonialismo.

Foram também extraídas como codificação na pesquisa desenvolvida, “afastamento da jurisdição e das leis brasileiras” e “submissão à égide das leis do Estado de Nova York”, nos Estados Unidos. As referidas codificações evidenciaram a imposição de um regime jurídico estrangeiro aos contratos celebrados pelo Estado brasileiro no contexto da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido, em 4 de março de 2021, a CNN Brasil noticiou que a empresa farmacêutica Pfizer estabeleceu, como condição contratual para o fornecimento de vacinas contra a COVID-19, cláusula segundo a qual quaisquer controvérsias oriundas do ajuste deveriam ser dirimidas exclusivamente por tribunais sediados em Nova York. Configurando, na prática, a renúncia à jurisdição nacional e o afastamento da aplicação do ordenamento jurídico brasileiro, com relevantes implicações para a soberania estatal e para o regime jurídico-administrativo dos contratos públicos (CNN Brasil, 2021a).

Ao aceitar a imposição, o Brasil abdicou de uma de suas prerrogativas soberanas mais fundamentais: o direito de solucionar litígios envolvendo o interesse público por meio de seu próprio sistema jurídico. Essa renúncia, ainda que não expressa, relativizou o poder soberano

do Estado brasileiro, cuja competência jurisdicional encontra fundamento no Código de Processo Civil e na própria Constituição de 1988.

No direito brasileiro, a jurisdição corresponde ao poder-dever estatal de solucionar conflitos de maneira imparcial e vinculada ao ordenamento jurídico, é a atividade estatal destinada à aplicação do direito objetivo ao caso concreto, com vistas à pacificação social, (Souza *et al*, 2024). Afastar essa competência em favor de um tribunal estrangeiro – especialmente em contratos administrativos que envolvem bens essenciais à sobrevivência da população – revela uma distorção profunda no equilíbrio contratual.

A exigência de submissão às leis e aos tribunais de Nova York revelou uma assimetria contratual estrutural, na qual os interesses das grandes indústrias farmacêuticas se impuseram sobre a soberania dos Estados e sobre o direito à saúde pública. Ao definir foro estrangeiro, as empresas deslocaram o controle judicial para outra jurisdição, retirando do Brasil a possibilidade de submeter divergências contratuais à apreciação de seus próprios tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, responsável pela guarda da Constituição e pela análise de eventuais inconstitucionalidades decorrentes da execução do contrato.

A disposição contratual expôs o país a riscos jurídicos expressivos, já que decisões proferidas por tribunais estrangeiros podem contrariar princípios constitucionais, ferir a ordem pública interna e limitar a atuação regulatória do Estado brasileiro, aprofundando sua vulnerabilidade. Embora a eleição de foro estrangeiro seja admitida no âmbito de contratos internacionais privados, a prática exige fundamentação técnica, equilíbrio negocial e proteção ao interesse público – condições completamente ausentes no processo de contratação emergencial das vacinas.

Dessa forma, a imposição da renúncia à jurisdição brasileira não apenas impede o Estado de julgar eventuais descumprimentos contratuais ou abusos por parte das empresas farmacêuticas, como também compromete a autonomia institucional e a soberania jurídica do país, submetendo o interesse público à lógica mercantil transnacional. Trata-se, portanto, de um caso paradigmático de enfraquecimento do Estado na arena global, em que cláusulas contratuais operam como instrumentos de deslocamento do poder decisório e de limitação da capacidade estatal de exercer plenamente sua função constitucional.

Portanto, a jurisdição é a expressão direta da soberania, sendo o mecanismo pelo qual o Estado soluciona conflitos conforme suas próprias leis. A inclusão da cláusula de eleição de foro estrangeiro no contrato celebrado entre o Brasil (contratante) e as indústrias farmacêuticas (contratadas) representou uma grave renúncia à jurisdição nacional e consequentemente um

comprometimento da soberania do Estado, pois a soberania garante a autonomia do Estado frente a pressões estrangeiras e o legitima como entidade jurídica e política no cenário.

Do ponto de vista do Direito Internacional, a soberania, como pilar da igualdade entre os Estados, é um princípio fundamental do Estado-nação, significando, em essência, a autoridade suprema que um Estado exerce sobre seu território, população e ordenamento jurídico, sem submissão a qualquer poder externo.

Segundo José Luiz Quadros de Magalhães (2002), a soberania pode ser entendida em duas vertentes, quais sejam, externa e interna. A soberania interna é sinônimo de poder supremo (coerção) dentro das fronteiras do Estado, uma vez que não existe nenhum poder paralelo ou acima daquele poder do Estado e a soberania externa significa independência.

A Carta das Nações Unidas (1945) no artigo 2º, I, descreve: “A Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros” (Organização das Nações Unidas, 1945). Esse princípio reconhece que todos os Estados, independentemente de seu poderio econômico ou militar, possuem o mesmo direito à autodeterminação e à não interferência.

Portanto, o deslocamento do foro de resolução de conflitos para jurisdições estrangeiras pode ser interpretado como afronta aos princípios da soberania nacional e do interesse público, uma vez que as decisões judiciais podem afetar diretamente o Erário público e os direitos dos cidadãos brasileiros. Essa cláusula refletiu a internalização de uma estrutura de poder global em que países periféricos se veem compelidos a aceitar condições impostas por entes privados hegemônicos, sob o risco de exclusão do acesso a bens essenciais, como vacinas.

A colonialidade do poder, nesse sentido, manifestou-se na naturalidade das corporações transnacionais, que através de seus representantes legais fazem exigências na crença de que jurisdições de países desenvolvidos são as únicas competentes e legítimas para tratar de litígios decorrente de descumprimento contratual.

Nesse sentido, a teoria da colonialidade do poder passou a ser uma ferramenta essencial para compreender como o Brasil se submeteu aos ditames das transnacionais farmacêuticas, obedecendo um sistema global que o oprime, devido a dependência tecnológica, científica e econômica do país.

Mignolo (2017) defende que a ferramenta teórica para compreender como as estruturas de dominação, exploração e hierarquização criadas durante o período colonial europeu continuam a operar no mundo contemporâneo, mesmo após o fim formal das colônias é entender a matriz colonial do poder. Conforme o autor, a matriz colonial do poder é sustentada por quatro eixos principais interligados, quais sejam: controle da economia, da autoridade, da

natureza e dos recursos naturais, gênero e sexualidade e controle da subjetividade e do conhecimento.

O controle da economia está ligado a um sistema econômico mundial capitalista, no qual a Europa Ocidental e os Estados Unidos posicionam-se no centro, enquanto as demais regiões do mundo são empurradas para a periferia e se consolida com mercado dependente. Segundo Quijano (2005), a constituição do capitalismo como economia mundial moderna foi simultânea à colonização da América e ainda se perpetua.

Podemos concluir que as multinacionais estrangeiras ao “ditar” cláusulas para elaboração de contrato público, revelou que a colonialidade do poder ainda está presente e se concretiza quando o país se curva diante das imposições das grandes indústrias europeias e norte americana, como ocorreu no Brasil durante a pandemia.

Além das imposições já mencionadas, foi codificada a expressão “fundo garantidor”, ou seja, a constituição de um fundo garantidor formado por valores depositados em conta estrangeira, destinado a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil.

A condição implicava que, em eventual descumprimento das cláusulas contratuais por parte do Governo Federal, a empresa contratada poderia reivindicar bens pertencentes ao Estado brasileiro situados fora do território nacional. Em outras palavras, além de ver reduzida sua proteção jurídica sob o ordenamento normativo interno, o Brasil sujeitava seus ativos soberanos no exterior à possibilidade de constrição para fins de garantia contratual, caso houvesse inadimplemento.

A exigência recebeu críticas contundentes da imprensa nacional e internacional. O The Bureau of Investigative Journalism, organização de notícias sem fins lucrativos com sede em Londres, noticiou que a Pfizer estava sendo acusada de exercer pressão excessiva e, por vezes, coercitiva sobre governos latino-americanos durante as negociações para aquisição da vacina contra a Covid-19. Segundo a investigação, a empresa teria solicitado que países como Brasil e Argentina fornecessem ativos soberanos — incluindo edifícios de embaixadas e instalações militares — como garantia para custear eventuais litígios futuros (The Bureau of Investigative Journalism, 2021)

O portal Poder360 corroborando com tais informações, divulgou no dia 08 de maio de 2021, que reportagens produzidas pelo Bureau of Investigative Journalism em parceria com as agências Stat e Ojo Público revelaram que os contratos firmados pela Pfizer com países como Brasil, Argentina e África do Sul continham exigências relativas à oferta de bens estatais — a exemplo de prédios de representações diplomáticas e bases militares — como garantias para a

compra das vacinas contra a COVID-19. Ressaltou, ainda, que tais exigências não foram aplicadas ao contrato firmado com os Estados Unidos (Poder360, 2021).

O conjunto dessas imposições evidenciou, mais uma vez, a assimetria estrutural que caracterizou as relações entre grandes corporações farmacêuticas e países em desenvolvimento, particularmente o Brasil quando da aquisição de imunizantes. A dinâmica reproduziu padrões históricos de subordinação econômica e política, representando um resquício explícito das lógicas coloniais que ainda permeiam o sistema internacional contemporâneo.

Nesse sentido, a crítica de Aimé Césaire permanece atual ao afirmar que:

Indo além, não faço segredo de que, para mim, a barbárie da Europa Ocidental é hoje incrivelmente grande, superada, e muito, apenas por uma: a norte-americana.

E não estou falando de Hitler, do carcereiro ou do aventureiro, mas do ‘homem de bem’, do vizinho; nem da SS, nem do gangster, mas do honesto burguês. (Césaire, 2020, p.33)

O autor sustenta que a barbárie contemporânea não deve ser compreendida como um fenômeno excepcional, restrito a regimes totalitários, figuras monstruosas ou episódios históricos extremos, mas como um elemento constitutivo da própria ordem social do Ocidente. Ao afirmar que a barbárie da Europa Ocidental é imensa e que apenas a norte-americana a supera, ele confronta diretamente a narrativa civilizatória que associa essas sociedades ao progresso moral, aos direitos humanos e à racionalidade moderna.

O alvo de sua crítica é o “homem de bem”, o vizinho, o honesto burguês, isto é, o sujeito comum que, ao se perceber como moralmente correto, participa, consente ou se beneficia de sistemas profundamente violentos, como o colonialismo, o racismo estrutural, o imperialismo e a exploração capitalista.

A barbárie, portanto, não aparece como negação da civilização ocidental, mas como sua expressão mais acabada: uma violência que se exerce sob a aparência de legalidade, normalidade e virtude, tornando-a ainda mais profunda e eficaz justamente por não ser reconhecida como tal, o que permite uma leitura diretamente articulável à noção de colonialidade do poder, tal como formulada por Aníbal Quijano (2005), podendo, inclusive afirmar que a colonialidade não se limita ao período histórico do colonialismo, mas persiste como padrão estrutural de dominação que organiza a economia, o conhecimento, a política e as hierarquias globais.

Nesse sentido, a barbárie denunciada por Aimé Césaire, não se expressa prioritariamente pela violência aberta, mas pela naturalização de relações assimétricas que produzem morte, escassez e subordinação sob a aparência de legalidade, racionalidade econômica e responsabilidade institucional. É justamente nesse ponto que a aquisição de vacinas pelo Brasil

durante a pandemia de COVID-19 revelou sua dimensão colonial: as exigências impostas por multinacionais farmacêuticas.

Embora formalmente soberano, o país se vê constrangido a aceitar condições ditadas por corporações sediadas no Norte Global, cujos interesses econômicos prevalecem sobre o direito à saúde e à vida. Tal dinâmica não decorre de agentes abertamente violentos ou autoritários, mas de decisões tomadas por gestores, executivos e instituições que se apresentam como técnicas, neutras e responsáveis — os equivalentes contemporâneos do “honesto burguês”. A colonialidade do poder opera, assim, ao transformar a desigualdade global em um dado natural do mercado, ocultando o caráter político e histórico dessas relações.

A barbárie, nesse contexto, não é o colapso da ordem, mas o seu funcionamento regular: vidas no Sul Global tornam-se negociáveis, adiáveis ou descartáveis em nome da segurança jurídica das empresas, da proteção da propriedade intelectual e da lógica do lucro. A comparação revela que a violência colonial não desapareceu, apenas mudou de forma, passando a agir por meio de contratos, patentes e discursos de racionalidade econômica, reafirmando a crítica de que a modernidade ocidental produz, simultaneamente, civilização para alguns e barbárie estrutural para muitos outros.

Dessa forma, o estudo das relações comerciais envolvendo a aquisição de vacinas contra a COVID-19 não pode ser dissociado de uma análise crítica das estruturas globais de poder que condicionaram tais negociações. A pandemia explicitou a assimetria entre os países do Sul Global, os Estados centrais e as corporações farmacêuticas, evidenciando que, no campo da saúde global, a lógica da colonialidade permanece operante, influenciando decisões, definindo prioridades e determinando quem tem acesso — e em que condições — aos bens científicos e tecnológicos indispensáveis à preservação da vida.

Por fim, além das codificações anteriormente identificadas, emergiu das unidades de registro a codificação analítica denominada “falta de penalidades”, a qual se refere à inexistência de sanções aplicáveis às empresas transnacionais contratadas em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, notadamente quanto aos prazos de entrega dos imunizantes.

Em termos objetivos, as empresas contratadas impuseram a exclusão expressa de qualquer penalidade pelo inadimplemento temporal, estabelecendo um regime contratual excepcional que se afasta de maneira significativa da lógica estruturante dos contratos administrativos. A referida circunstância revela uma inversão do princípio da responsabilidade contratual, na medida em que a negociação se orientou pela neutralização de consequências jurídicas ao particular e pela transferência integral dos riscos ao poder público.

A previsão de cláusulas sancionatórias em hipóteses de inadimplemento, especialmente nos casos de atraso na execução, constitui elemento essencial para assegurar a eficiência, a continuidade e a previsibilidade da atuação administrativa. Em um contexto de emergência sanitária sem precedentes, no qual o Estado brasileiro dependia do estrito cumprimento dos cronogramas de entrega para a implementação efetiva do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, a ausência de multas e de mecanismos coercitivos comprometeu de forma sensível a gestão pública e a proteção da saúde coletiva.

Nos contratos administrativos, as penalidades por atraso desempenham função instrumental relevante, pois visam prevenir danos à Administração Pública e garantir a observância integral das obrigações assumidas. No caso específico da aquisição de vacinas contra a COVID-19, o descumprimento dos prazos contratualmente previstos configurava risco elevado à política pública de imunização, com impactos diretos sobre a redução da morbimortalidade e sobre a preservação da vida humana. A manutenção de cláusulas sancionatórias, portanto, mostrava-se medida indispensável para reforçar a observância dos cronogramas e assegurar o funcionamento coordenado das políticas públicas em curso.

A supressão dessa cláusula configura grave ruptura com a lógica jurídico-contratual tradicional, fundada no equilíbrio entre as partes, na boa-fé objetiva e na existência de consequências jurídicas proporcionais em caso de violação das obrigações pactuadas (Justen Filho, 2025). Tal fenômeno não pode ser compreendido como episódio isolado ou como mero desvio técnico, tratou-se de uma manifestação concreta da colonialidade do poder, na qual grandes corporações sediadas no Norte Global operam com autoridade quase soberana, impondo unilateralmente condições contratuais a países tecnologicamente dependentes, sobretudo em contextos críticos como o da pandemia de COVID-19.

O enfrentamento sanitário pelos países periféricos não se pautou pela solidariedade internacional, mas pela reprodução de hierarquias globais assimétricas, que relativizaram a soberania estatal e subordinaram o interesse público a uma lógica privatista, autoritária e profundamente desigual. No caso brasileiro, o processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19 evidenciou de forma exemplar a persistência da colonialidade do poder, na medida em que decisões centrais para a proteção da vida foram condicionadas por estruturas econômicas e jurídicas impostas a partir do Norte Global.

As negociações com grandes conglomerados farmacêuticos revelaram um cenário em que o Estado, embora formalmente soberano, atuou em posição de subordinação, compelido a aceitar cláusulas contratuais assimétricas, como a limitação ou exclusão de penalidades por

atraso, a imposição de confidencialidade e a mitigação de mecanismos tradicionais de controle administrativo.

Essa dinâmica expôs a continuidade de um padrão colonial que transforma países periféricos em espaços de experimentação jurídica e flexibilização normativa, onde princípios constitucionais como a legalidade, a publicidade e a supremacia do interesse público tornam-se relativizados em nome da urgência e da escassez artificialmente produzida. A colonialidade do poder manifesta-se, assim, não apenas no plano econômico, mas também no jurídico-institucional, ao reconfigurar o contrato administrativo como instrumento de submissão, e não de equilíbrio, deslocando o centro decisório do Estado para atores privados transnacionais.

Portanto, diante de toda esta assimetria, a aquisição de vacinas durante a pandemia de COVID-19 evidenciou de forma inequívoca a profunda desigualdade entre países ricos e pobres no sistema internacional. Enquanto as nações centrais mobilizaram poder econômico, capacidade tecnológica e influência política para garantir contratos antecipados, volumes excedentes de doses e maior previsibilidade nas entregas, os países periféricos enfrentaram escassez, atrasos e condições contratuais restritivas impostas por grandes conglomerados farmacêuticos. Essa desigualdade não se explica apenas por diferenças orçamentárias, mas pela inserção subordinada dos países pobres nas cadeias globais de produção e distribuição de insumos estratégicos, que lhes impôs dependência tecnológica, menor poder de barganha e vulnerabilidade jurídica.

Como resultado, o acesso às vacinas tornou-se um marcador de hierarquia global, no qual a proteção da vida nos países ricos foi priorizada, enquanto, nos países pobres, a imunização foi postergada, reafirmando desigualdades históricas e estruturais no direito à saúde.

Corroborando com esta afirmação, em coletiva de imprensa realizada em 8 de setembro de 2021, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que mais de 50 mil pessoas continuavam a morrer semanalmente em decorrência da COVID-19, número que se aproximava de 70 mil óbitos por semana no período imediatamente anterior. Apesar da existência de soluções técnicas para conter a transmissão e salvar vidas, a distribuição desigual de ferramentas vitais — como diagnósticos, oxigênio, equipamentos de proteção individual e vacinas — impulsionava o que denominou de “pandemia de duas vias”. Segundo o pronunciamento, embora mais de 5,5 bilhões de doses já tivessem sido administradas globalmente, cerca de 80% concentraram-se em países de alta e média-alta renda, ao passo que menos de 15% das doses prometidas aos países de baixa renda havia sido efetivamente entregues (Organização Mundial da Saúde, 2021c).

As declarações do Diretor-Geral da OMS evidenciaram, de forma contundente, as desigualdades estruturais que marcaram a governança global da crise sanitária. Mais do que revelar a dimensão da tragédia humanitária, o pronunciamento expõe a permanência de um sistema internacional profundamente atravessado pela lógica da colonialidade do poder, conforme formulada por Quijano (2005), que designa a continuidade das estruturas de dominação colonial para além do colonialismo formal.

A distribuição desigual de vacinas e insumos durante a pandemia não configurou, portanto, mera falha ética ou humanitária, mas expressão concreta da colonialidade do poder no campo da saúde global. Grandes corporações farmacêuticas, respaldadas pelo poder econômico, político e tecnológico das nações centrais, monopolizaram a oferta de imunizantes e impuseram cláusulas contratuais assimétricas aos países periféricos, em consonância com o diagnóstico de Maldonado-Torres (2007) acerca da persistência da colonialidade da vida e da desumanização sistemática de populações historicamente subalternizadas, o que vem sendo corroborado por Boaventura (2020).

Para Boaventura de Souza Santos, na obra “A cruel pedagogia do vírus” (2020), a pandemia não apenas produziu sofrimento, mas também revelou estruturalmente as fragilidades do modelo civilizatório contemporâneo, em especial do capitalismo neoliberal.

As pandemias mostram de maneira cruel como o capitalismo neoliberal incapacitou o Estado para responder às emergências. As respostas que os Estados estão a dar à crise variam de Estado para Estado, mas nenhum pode disfarçar a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em relação a emergências que têm vindo a ser anunciadas como de ocorrência próxima e muito provável. Estou certo de que nos próximos tempos esta pandemia nos dará mais lições e de que o fará sempre de forma cruel. Se seremos capazes de aprender é por agora uma questão em aberto. (Santos, 2020, p. 28)

Ao afirmar que as pandemias expõem de maneira cruel a incapacitação do Estado, o autor desloca o debate da contingência sanitária para o plano político, econômico e epistêmico, denunciando que a crise não é um acidente histórico, mas o resultado previsível de escolhas estruturais reiteradas ao longo das últimas décadas.

Nesse sentido, a incapacidade estatal de responder adequadamente às emergências sanitárias não decorre da excepcionalidade da pandemia, mas da desmontagem sistemática das funções públicas do Estado, promovida pelo neoliberalismo. A lógica de austeridade fiscal, privatização de serviços essenciais e subordinação das políticas públicas à racionalidade do mercado comprometeu a capacidade de planejamento, prevenção e resposta a crises que, como enfatiza Boaventura, já vinham sendo anunciadas como prováveis e iminentes. O vírus, portanto, não cria a crise; ele torna visível e incontornável uma crise pré-existente.

A diversidade de respostas estatais mencionada pelo autor não contradiz essa análise, mas a reforça. Ainda que os Estados tenham adotado estratégias distintas, nenhum conseguiu ocultar sua falta de previsibilidade estrutural, evidenciando que o problema não reside apenas na gestão pontual da crise, mas na própria arquitetura política e econômica que orienta a ação estatal. Assim, a pandemia atua como um dispositivo pedagógico cruel, pois ensina por meio da dor, da morte e da ampliação das desigualdades sociais, revelando quem pode ser protegido e quem é sistematicamente exposto ao risco.

Ao afirmar que a pandemia continuará a produzir lições cruéis, Boaventura sugere que o aprendizado não é automático nem garantido. A pedagogia do vírus não conduz, por si só, à transformação social; ela apenas escancara os limites do paradigma dominante. A possibilidade de aprendizagem depende da disposição coletiva de questionar as bases do capitalismo neoliberal, de reconstruir o papel do Estado e de reconhecer saberes e práticas historicamente subalternizados. Caso contrário, a crueldade da lição se repetirá, convertendo a exceção pandêmica em normalidade permanente de crise.

Paulo Marchiori Buss (2007), afirma que os países em desenvolvimento permanecem submetidos à intensa pressão do comércio internacional de insumos em saúde, em especial em razão de um sistema global de proteção patentária orientado prioritariamente pelos interesses das grandes corporações privadas. O elevado custo de medicamentos e tecnologias, segundo o autor, constitui obstáculo central ao acesso universal à saúde, afetando tanto países de baixa renda quanto parcelas vulneráveis de países de renda média.

Os sistemas de saúde dos países em desenvolvimento são submetidos à forte pressão do comércio internacional de insumos para a saúde (medicamentos, kits e reativos para diagnóstico, equipamentos e outros insumos). O alto preço dos medicamentos, em grande parte decorrentes de um sistema de proteção patentária que enxerga apenas os interesses das grandes empresas privadas, é um impedimento importante ao acesso dos países pobres e das populações mais pobres dos países de renda média a medicamentos e insumos essenciais para a saúde. Enquanto os interesses do comércio e do lucro sobrepujarem os interesses da saúde dos mais pobres e a ‘governança global’ e os Estados nacionais não encontrarem soluções para a questão do acesso a tais insumos, posso afirmar que vivemos em tempos de barbárie global. (Buss, 2007. p.1582/1583)

Ao afirmar que vivemos em “tempos de barbárie global”, Buss denuncia a subordinação da saúde pública aos imperativos do lucro e do comércio internacional, agravada pela incapacidade da governança global e dos Estados nacionais de construírem soluções efetivas para o acesso equitativo a insumos essenciais.

Trata-se de uma barbárie que se manifesta na naturalização da morte evitável e na hierarquização das vidas segundo critérios econômicos e geopolíticos, corroborando, assim, com as manifestações de Boaventura (2020) ao relatar que a pandemia coloca a humanidade

diante de uma encruzilhada histórica, ou se rompe com a lógica que produz vulnerabilidade, desigualdade e morte em larga escala, ou se aceita a pedagogia do vírus como um ensinamento ignorado, condenado a reaparecer sob novas formas. A crueldade, nesse caso, não estaria apenas no vírus, mas na recusa em transformar as estruturas que o tornaram tão devastador.

Na pandemia de COVID-19, todas essas dinâmicas se tornaram ainda mais evidente: a retenção de tecnologias pelos países centrais, o monopólio exercido pelas grandes farmacêuticas e a imposição de cláusulas contratuais restritivas aos países do Sul Global reafirmaram a primazia dos interesses comerciais sobre o direito humano à saúde, em diálogo direto com a perspectiva da colonialidade do poder.

Conforme José Luiz Quadros de Magalhães e Jorge Fulgêncio Chaves (2023), embora os processos formais de independência tenham encerrado o colonialismo clássico, a colonialidade permaneceu operando de maneira profunda nas estruturas econômicas, jurídicas, políticas e simbólicas. A superação desse legado exige a construção de projetos soberanos efetivos, bem como uma ruptura subjetiva com mentalidades colonizadas, internalizadas ao longo de séculos.

Assim, a pandemia da Covid-19 evidenciou, de forma inequívoca, a persistência da colonialidade do poder nas relações internacionais contemporâneas. As desigualdades no acesso a vacinas e tecnologias em saúde revelaram a necessidade urgente de revisão crítica dos modelos de cooperação internacional, transferência tecnológica e governança da saúde global, orientando-os por princípios de equidade, solidariedade e justiça global.

Em síntese, as cláusulas contratuais exigidas pelas transnacionais farmacêuticas durante a pandemia, não apenas contrariaram princípios estruturantes da racionalidade jurídico-administrativa brasileira, como também expuseram, de modo emblemático, o funcionamento da colonialidade do poder na saúde global. Nessa configuração, países periféricos assumiram riscos, custos e prejuízos, enquanto corporações transnacionais preservaram sua lucratividade, autonomia decisória e, em certos casos, imunidade jurídica. Tratou-se de uma demonstração clara de como a pandemia intensificou desigualdades históricas, reforçou estruturas de dependência e consolidou a hegemonia do capital farmacêutico no cenário mundial contemporâneo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese demonstrou que a pandemia da Covid-19, embora configurada como uma emergência sanitária global, constituiu-se também como um evento político, jurídico e econômico profundamente marcado pela persistência de estruturas coloniais que organizam as relações internacionais contemporâneas. Longe de representar um fenômeno exclusivamente técnico-sanitário, a crise pandêmica revelou e intensificou assimetrias históricas de poder e saber especialmente no campo da saúde global.

Antes de responder diretamente ao problema central da pesquisa, é necessário retomar os objetivos específicos que orientaram o percurso metodológico da investigação, os quais foram desenvolvidos ao longo dos capítulos da tese em consonância com o rigor científico adotado.

O primeiro objetivo específico — compreender e sistematizar os fundamentos teóricos do pensamento decolonial, com ênfase na colonialidade do poder, do saber e do ser, analisando sua constituição histórica no âmbito do projeto da modernidade e sua permanência nas estruturas sociais, políticas, jurídicas e econômicas contemporâneas — foi desenvolvido no Capítulo 2. Nesse capítulo, procedeu-se a uma análise teórico-crítica da formação histórica dessas categorias no interior do projeto moderno-colonial, evidenciando sua continuidade enquanto padrão estrutural de dominação.

A validação desse objetivo ocorreu por meio de uma fundamentação teórica aprofundada, ancorada em autores centrais do pensamento decolonial latino-americano, como Aníbal Quijano, Walter Dignolo, Enrique Dussel, Nelson Maldonado-Torres, dentre outros. Essa sistematização permitiu identificar a persistência das estruturas de colonialidade nas esferas sociais, políticas, jurídicas e econômicas contemporâneas, fornecendo o arcabouço conceitual que orientou as análises subsequentes da tese e assegurou coerência epistemológica à interpretação dos dados empíricos e normativos examinados nos capítulos posteriores.

O segundo objetivo específico — analisar o direito humano à saúde a partir de uma perspectiva crítica decolonial, problematizando as noções de universalidade e neutralidade do discurso dos direitos humanos, a fim de evidenciar as vulnerabilidades estruturais produzidas pela colonialidade e discutir a necessidade de descolonização do campo jurídico dos direitos humanos — foi desenvolvido no Capítulo 3, intitulado: O direito humano à saúde sob o olhar crítico decolonial. A validação desse objetivo deu-se mediante pesquisa bibliográfica sistemática de autores críticos dos direitos humanos e do pensamento decolonial, aliada à

análise teórico-jurídica dos fundamentos normativos que estruturam o direito à saúde nos planos internacional e nacional.

Essa abordagem possibilitou evidenciar as vulnerabilidades estruturais produzidas pela colonialidade, especialmente nos contextos periféricos, sustentando a discussão acerca da necessidade de descolonização do campo jurídico dos direitos humanos. Assim, contribuiu para uma compreensão plural e crítica da efetivação do direito humano à saúde.

O terceiro objetivo específico — investigar como a pandemia da COVID-19, no contexto brasileiro, evidenciou relações hierárquicas entre países do Norte e do Sul Global, particularmente no que se refere à produção, distribuição e acesso às vacinas, revelando a reprodução de estruturas de colonialidade no enfrentamento a emergência sanitária — foi desenvolvido no Capítulo 4, intitulado: A pandemia da COVID-19 e a aquisição de vacinas para assegurar o direito humano à saúde: reflexos da colonialidade.

A validação desse objetivo ocorreu por meio da análise crítica de dados normativos, institucionais e documentais relativos à política de imunização adotada no Brasil, bem como da contextualização do país no cenário internacional de produção e fornecimento de imunizantes. Em diálogo com a literatura decolonial e com estudos críticos sobre desigualdades globais em saúde, foi possível evidenciar a reprodução de estruturas de colonialidade no enfrentamento da emergência sanitária, manifestadas na dependência tecnológica, na concentração da produção de vacinas em países centrais e na assimetria de poder que marcou as negociações e o acesso aos imunizantes durante a pandemia.

Por fim, o quarto objetivo específico — analisar criticamente as alterações normativas brasileiras e a imposição de cláusulas contratuais para aquisição de vacinas contra a COVID-19, identificando em ambos a incidência da colonialidade do poder e do saber, bem como seus impactos sobre a autonomia estatal e a efetivação dos direitos humanos à saúde — foi desenvolvido no Capítulo 5, intitulado: A posição periférica do Brasil e as dinâmicas normativas e contratuais na aquisição de vacinas contra a COVID-19. A validação desse objetivo ocorreu mediante o método denominado análise de conteúdo, desenvolvido por Laurence Bardin, através das legislações excepcionais editadas durante a pandemia, bem como de reportagens, relatórios de organizações internacionais e depoimentos de autoridades, à luz da teoria da colonialidade.

Esse procedimento permitiu identificar a incidência da colonialidade do poder e do saber tanto no processo decisório estatal quanto na estruturação das cláusulas contratuais, evidenciando mecanismos de subordinação jurídica, limitação da autonomia estatal e seus

reflexos diretos sobre a efetivação do direito humano à saúde no contexto da emergência sanitária.

No que se refere ao alcance dos objetivos específicos, a pesquisa demonstrou que a colonialidade permanece operante nas relações econômicas entre Estados periféricos e corporações transnacionais, especialmente no campo da saúde global. Evidenciou-se que a concentração da capacidade produtiva, do domínio tecnológico e da propriedade intelectual em poucos países centrais e em grandes conglomerados farmacêuticos constitui um mecanismo contemporâneo de reprodução da dependência, limitando a autonomia decisória dos Estados periféricos em contextos de crise sanitária. Tal estrutura hierárquica condicionou não apenas o acesso material às vacinas, mas também os termos jurídicos e políticos sob os quais esse acesso se concretizou.

O problema central da pesquisa consistiu em investigar como as relações de aquisição imunizantes entre o Estado brasileiro e as indústrias farmacêuticas transnacionais, reproduziram estruturas de colonialidade, tensionando a efetividade dos direitos humanos à saúde.

A análise das legislações federais editadas no Brasil para o enfrentamento da pandemia revelou que parte significativa das normas relativas à aquisição de imunizantes foi elaborada sob intensa pressão do mercado farmacêutico global, incorporando dispositivos excepcionais que flexibilizaram garantias jurídicas, ampliaram a margem de atuação das empresas fornecedoras e relativizaram princípios estruturantes do direito público, como a supremacia do interesse público, a soberania jurisdicional e a transparência administrativa.

Ocorre que tais normas não podem ser compreendidas apenas como respostas técnicas à emergência sanitária, mas como produtos de um contexto de assimetria estrutural, no qual o Estado brasileiro atuou de forma reativa e subordinada às exigências das indústrias detentoras da tecnologia vacinal.

Restou evidenciado, portanto, que as legislações emergenciais editadas durante a pandemia, sob o argumento da celeridade e da excepcionalidade, contribuíram para a consolidação de práticas jurídicas assimétricas, nas quais o Estado brasileiro relativizou mecanismos essenciais típicos de estado democrático de direito, como a soberania, controle e transparência. Essas normas operaram como dispositivos de internalização de regimes normativos globais, reforçando a dependência científica, tecnológica e jurídica do país.

A tese também evidenciou a atuação da colonialidade na desvalorização da ciência produzida no âmbito nacional. Apesar da existência de instituições científicas consolidadas, como a Fiocruz, o Instituto Butantan e a Anvisa, observou-se a priorização de decisões de autoridades regulatórias estrangeiras, sob o discurso da eficiência técnica. A escolha revelou

uma epistemologia excludente, que marginaliza o conhecimento produzido no Sul Global e reafirma a posição periférica do Brasil no sistema internacional, comprometendo sua autonomia científica e sua capacidade soberana de resposta a crises sanitárias.

A indisponibilidade dos contratos firmados entre a União e as multinacionais farmacêuticas constituiu um desafio relevante para a pesquisa, mas não inviabilizou a produção do conhecimento. A utilização de fontes alternativas — como entrevistas, reportagens investigativas, documentos públicos e pronunciamentos oficiais — analisadas à luz da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin permitiu reconstruir o contexto das negociações e identificar, de forma consistente, os traços de subordinação e assimetria presentes nas relações contratuais.

As unidades de registro extraídas evidenciaram a imposição de cláusulas unilaterais, sem margem real de negociação, revelando a imposição de interesses mercadológicos em detrimento da equidade sanitária e do direito à saúde, característica da colonialidade do poder.

Nesse contexto, a tese contribuiu para o aprofundamento crítico do debate jurídico sobre saúde global ao evidenciar como a colonialidade do poder e do saber se manifestou concretamente na aquisição de imunizante contra a COVID-19 pelo Brasil. Ao articular teoria decolonial, direito humano à saúde e análise empírica das práticas normativas e contratuais, o estudo ofereceu subsídios teóricos e analíticos para repensar o papel do Estado brasileiro em contextos de crise.

Somente a partir de uma ruptura consciente com os padrões coloniais de poder será possível avançar na construção de uma soberania sanitária efetiva, capaz de garantir o direito à saúde em condições de igualdade e dignidade para toda a população. Essa ruptura exige o fortalecimento da autonomia científica, tecnológica e normativa do Estado, a valorização dos saberes produzidos no Sul Global e a reorientação das políticas públicas de saúde a partir de critérios de justiça social, solidariedade internacional e centralidade da vida humana. Nesse sentido, a descolonização do campo jurídico e da governança da saúde global apresenta-se não apenas como um imperativo ético, mas como condição estrutural para a consolidação do Estado Democrático de Direito, apto a responder a crises sanitárias presentes e futuras sem reproduzir hierarquias históricas de subordinação, exclusão e vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo da história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. São Paulo: Boitempo, 2004.

AGÊNCIA BRASIL. **OMS monitora nova variante que combina Ômicron e Delta**. 9 mar. 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-03/oms-monitora-nova-variante-que-combina-omicron-e-delta>. Acesso em: 23 mar. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Institucional: quem somos**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/institucional>. Acesso em: 25 ago. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO). **Dossiê Pandemia de COVID-19: versão final**. Rio de Janeiro, nov. 2022. Disponível em: https://abrasco.org.br/wp-content/uploads/2023/11/20231116_Abrasco_Dossie_Pademia_de_Covid-19_versao-final.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.

BALLESTRIN, Luciana Maria de Aragão. América Latina e o giro decolonial. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Brasília, n. 11, p. 89-117, maio/ago. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/DxkN3kQ3XdYYPbwwXH55jhv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 mar. 2023.

BANCO MUNDIAL. COVID-19 in Brazil: Impacts and Policy Responses. Washington, D.C.: **World Bank**, 2020. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/106541594362022984/pdf/COVID-19-in-Brazil-Impacts-and-Policy-Responses.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2023.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de direito administrativo**. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2023.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. **Teoria geral do Estado**. Belo Horizonte: Del Rey, 1988.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2020.

BARRUCHO, Luis. Brasil: o novo epicentro da pandemia de coronavírus? **BBC News Brasil**, Londres, 20 maio 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52732620>. Acesso em: 27 jan. 2024.

BEZERRA, Patricia Araújo; CAVALCANTI, Pauline; MOURA, Leides Barroso de Azevedo. *Colonialidade e saúde: olhares cruzados entre os diferentes campos*. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 33, 15 maio 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/Rw4fbt4QXGdWFnJhgTrwG5z/?lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2024. Acesso em: 13 mai. 2024.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **Estado, governo, sociedade**. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2017.

BODIN, Jean. **Os seis livros da República**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BORGES, Leonardo Estrela. **O Direito Internacional Humanitário**. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Ficha de tramitação da proposição RIC 1031/2021**, 2003a. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2294273>. Acesso em: 22 jan. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. Governo do Brasil confirma que recebeu carta do CEO da Pfizer. **Ministério da Saúde** – Notícias, 23 jan. 2021a. Atualizado em 3 mar. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/nota-1>. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Governo Federal assina contrato que permite a aquisição de mais 100 milhões de doses de vacina contra a COVID-19**. Brasília, 27 jan. 2021b. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/01/governo-assina-contrato-que-permite-a-aquisicao-de-mais-100-milhoes-de-doses-de-vacina-contr-a-covid-19>. Acesso em: 24 jan. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 29 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020**. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 fev. 2020a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm. Acesso em: 27 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.006, de 28 de maio de 2020**. Dispõe sobre a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais em razão da COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 maio 2020b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm. Acesso em: 27 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021**. Dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e responsabilidade civil por efeitos adversos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2021c. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021**. Dispõe sobre a responsabilidade civil da União, estados e municípios por eventos adversos pós-vacinação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2021d. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14125.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º abr. 2021e. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976**. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 set. 1976. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999**. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 27 jan. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm. Acesso em: 06 Jan. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões de doses CoronaVac**. Brasília, 29 jan. 2021f. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/ministerio-da-saude-confirma-compra-de-mais-54-milhoes-de-doses-coronavac>. Acesso em: 24 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel Coronavírus – COVID-19**. Brasília, DF, 2020–2021g. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em: 27 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020**. Declara emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 4 fev. 2020d. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-244024407>. Acesso em: 02 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 454, de 20 de março de 2020**. Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Diário

Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar. 2020e. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm. Acesso em: 02 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022**. Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da COVID-19. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 22 abr. 2022a. Disponível em: <https://www.in.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Contratos Coronavírus**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/coronavirus>. Último acesso em: 25 mar. 2025. Atualizado em: 2025.

BRASIL. Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. **Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia da Covid-19**. Brasília: Senado Federal, 2021h. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/607974>. Acesso em: 13 jun 2024.

BRASIL. Senado Federal. Medida provisória revoga lei que abriu caminho para compra de vacinas. **Senado Notícias**, Brasília, DF, 20 jun. 2022b. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/20/medida-provisoria-revoga-lei-que-abriu-caminho-para-compra-de-vacinas>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 534, de 2021**. Autoriza entes federativos a assumirem responsabilidades civis relativas a eventos adversos pós-vacinação contra a COVID-19. Brasília, DF: Senado Federal, 2021i. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147641>. Acesso em: 29 dez. 2024.

BRASIL. Senado Notícias. Anvisa aprova uso emergencial das primeiras vacinas contra coronavírus no Brasil. Brasília: **Senado Federal**, 18 jan. 2021j. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/01/anvisa-aprova-uso-emergencial-das-primeiras-vacinas-contracoronavirus-no-brasil>. Acesso em: 02 ago. 2023.

BRASIL247. **Ministério da Saúde impõe sigilo de 10 anos sobre segundo contrato com a Pfizer**. Brasil247, 4 jun. 2021. Disponível em: <https://www.brasil247.com/coronavirus/ministerio-da-saude-impoe-sigilo-de-10-anos-sobre-segundo-contrato-com-a-pfizer-que-e-mais-carro-do-que-o-primeiro>. Acesso em: 29 dez. 2024.

BRAUDEL, Fernand. **Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV–XVIII**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

BUSS, Paulo Marchiori. Globalização, pobreza e saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 12, n. 6, p. 1575–1589, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/VLr6csVhCdhmLyh5tqwQnkn/?lang=pt>. Acesso em: 22 out. 2024.

CAMPUZANO, Afonso Júlios. **Constitucionalismo em tempos de globalização**. Tradução de José Luís Bolzan de Moraes e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2018.

CASSESE, Antônio. **International Law**. Oxford: Oxford University Press, 2005.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro”. In: LANDER, Edgardo (org.) **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais — perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624102434/9_CastroGomez.pdf. Acesso em: 07 fev. 2024.

CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o colonialismo**. Tradução de Claudio Willer. São Paulo: Veneta, 2020.

CHAUÍ, Marilena; SANTOS, Boaventura de Souza. **Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento**. São Paulo: Cortez, 2013.

CHAVES, Jorge Fulgêncio da Silva; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. **As corporações supranacionais e os direitos essenciais**. São Paulo: Dialética, 2023.

CNN BRASIL. **Governo cede e aceita cláusulas “abusivas” da Pfizer**. CNN Brasil – Saúde, 4 mar. 2021a. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/governo-cede-e-aceita-clausulas-abusivas-da-pfizer/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

CNN BRASIL. **Governo federal assina contratos com Pfizer e Janssen para vacinas**. São Paulo, 19 mar. 2021b. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/governo-federal-assina-contratos-com-pfizer-e-janssen-para-vacinas/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

CNN BRASIL. **Países ricos estão estocando vacinas e deixando o restante do mundo para trás**. CNN Brasil, 9 dez. 2020a. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/paises-ricos-estao-estocando-vacinas-e-deixando-o-restante-do-mundo-para-tras/>. Acesso em: 22 mai. 2024.

CNN BRASIL. **Primeira pessoa é vacinada contra Covid-19 no Brasil**. CNN Brasil, 17 jan. 2021c. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/primeira-pessoa-e-vacinada-contracovid-19-no-brasil/>. Acesso em: 21 mai. 2024.

CNN BRASIL. **Quais os países que já começaram a vacinação contra a Covid-19?** CNN Brasil, 18 dez. 2020b. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/quais-os-paises-que-ja-comecaram-a-vacinacao-contracovid-19/>. Acesso em: 22 mai 2024.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Pandemia aumenta em 45% número de leitos de UTI, mas distribuição ainda é marcada pela desigualdade**. Portal Médico, 03 ago. 2020. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/pandemia-aumenta-em-45-numero-de-leitos-de-uti-mas-distribuicao-ainda-e-marcada-pela-desigualdade-2>. Acesso em: 18 mai 2024.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Contra impunidade da pandemia, conselhos de Saúde e de Direitos Humanos atuam para preservar direito sanitário e resposta a emergências**. Brasília, 19 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/contra-impunidade-da-pandemia-conselhos-de>

[saude-e-de-direitos-humanos-atuam-para-preservar-direito-sanitario-e-resposta-a-emergencias](#). Acesso em: 22 out. 2024.

DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. **Rev. Saúde pública**, São Paulo, 22:327-34, 1988. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/5y9xHbXS96M9BhMWWgrRWgd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 13 de janeiro de 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

DOWBOR, Ladislau. **A era do capital improdutivo**. 2. ed. São Paulo: Autonomia Literária, 2017.

DUSSEL, Enrique. **1492: o encobrimento do outro a origem do mito da modernidade**. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993.

DUSSEL, Enrique. **Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão**. Tradução de Epharaim Ferreira Alves e Faime A. Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2023.

EL PAÍS Brasil. **Reino Unido aprova vacina da Pfizer e prevê começar a aplicar doses na semana que vem**, 02 dez. 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-02/reino-unido-aprova-vacina-da-pfizer-e-preve-comecar-a-aplicar-doses-na-semana-que-vem.html>. Acesso em: 25 jan. 2026.

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG. H1N1: fatos e fakes. Brasília: **Universidade Federal de Minas Gerais** – Faculdade de Medicina, 30 mar. 2020. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/h1n1-fatos-e-fakes/>. Acesso em: 02 jan. 2024.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. São Paulo: Edusp, 1996. Disponível em: https://antigo.ibict.br/images/conteudo/12.Hist%C3%B3ria_do_Brasil_-_Boris_Fausto_Col%C3%B4nia.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.

FRANCO JÚNIOR, Hilário. **A Idade Média: nascimento do Ocidente**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Fiocruz assina contrato de transferência de tecnologia da vacina COVID-19**. Brasília, 2 jun. 2021. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/fiocruz-assina-contrato-de-transferencia-de-tecnologia-da-vacina-covid-19/>. Acesso em: 27 mar. 2024.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. **Brasil receberá as primeiras vacinas contra COVID-19 por meio do Mecanismo COVAX neste domingo**. Brasília, 21 mar. 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/brasil-recebera-primeiras-vacinas-contr-covid-19-por-meio-do-mecanismo-covax-neste-domingo>. Acesso em: 17 out. 2023.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. **Pobreza multidimensional na infância e adolescência no Brasil: 2017 a 2023**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/32121/file/relatorio-pobreza-multidimensional-infantil-final.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2025.

GALEANO, Eduardo. **O livro dos abraços**. 1. ed. Porto Alegre: L&PM, 2005.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. **Sociedade e Estado**, Brasília, v. 31, n. 1, p. 25–49, jan./abr. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/xpNFtGdzw4F3dpF6yZVVGgt/?lang=pt>. Acesso em: 22 mar. 2024.

GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global [tradução de Inês Martins Ferreira]. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, n. 80, p. 115-147, 2008. Disponível em: <https://journals.openedition.org/rccs/697>. Acesso em: 28 jan. 2025.

GUERRA, Sidney. **Curso de Direitos Humanos**. 8.ed. São Paulo: Saraivajur, 2023.

HERRERA FLORES, Joaquín. **Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como produtos culturais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

HOBBSBAWM, Eric. **A era das revoluções: 1789–1848**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Caminhos e fronteiras**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
<https://journals.openedition.org/rccs/695>. Acesso em: 23 fev. 2024.

HUNT, Lynn. **A invenção dos direitos humanos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Desemprego atinge 14 milhões de pessoas na quarta semana de setembro. **Agência de Notícias IBGE**, Rio de Janeiro, 16 out. 2020. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29181-desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-na-quarta-semana-de-setembro>. Acesso em: 27 dez. 2024.

INSTITUTO BUTANTAN. **CoronaVac provou sua eficácia contra COVID-19 no estudo clínico mais criterioso**. São Paulo, 20 abr. 2022. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/coronavac-provou-sua-eficacia-contr-covid-19-no-estudo-clinico-mais-criterioso-feito-com-profissionais-de-saude-durante-pico-de-casos>. Acesso em: 24 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar da Educação Básica 2022: resumo técnico. Brasília, DF: **Inep**, 2023a. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_escolar_2022.pdf. Acesso em: 30 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Resposta educacional à pandemia de COVID-19 no Brasil – Educação Superior: relatório de pesquisa (referente ao ano de 2020). Brasília, DF: **Inep**, 2023b.

Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/relatorio_d_e_pesquisa_resposta_educacional_a_Covid_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2024.

JONES, Jeremy C.; BARANOVICH, Tatiana; MARATHE, Bindumadhav M.; DANNER, Angela F.; SEILER, Jon P.; FRANKS, John; GOVORKOVA, Elena A.; KRAUSS, Scott; WEBSTER, Robert G. Risk assessment of H2N2 influenza viruses from the avian reservoir. **Journal of Virology**, v. 88, n. 2, p. 1175-1188, 2014. DOI: 10.1128/JVI.02526-13. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3911670/>. Acesso em: 22 dez. 2023.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025.

LAMOUNIER, Gabriela Maciel; MAGALHÃES José Luiz Quadros de. **Entendendo os Direitos Humanos**. Belo Horizonte: Expert Editora, 2021.

LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624092356/4_Lander.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026. Acesso em: 26 out. 2023.

LANDIM, Raquel. Países doam menos de 20% das doses que prometeram à OMS. **CNN Brasil**, São Paulo, 2 jan. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/paises-doam-menos-de-20-das-doses-que-prometeram-a-oms/>. Acesso em: 12 fev. 2024.

LEÓN-PORTILLA, Miguel. **A visão dos vencidos**: a tragédia da conquista narrada pelos astecas. Tradução de Carlos Urbin; Jacques Wainberg. Porto Alegre: L&PM, 1987. (Coleção L&PM História. Série Visão dos Vencidos, v. 2).

LUGONES, María. Colonialidad y género. **Tabula Rasa**, Bogotá, n. 9, p. 73–101, jul./dez. 2008. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200006. Acesso em: 22 mar. 2024.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Desocultamento, modernidade e estado. In: **1375 – Ensaios**. Blog José Luiz Quadros de Magalhães, 16 nov. 2013. Disponível em: <https://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com/2013/11/1375-ensaios-jose-luiz-quadros.html>. Acesso em: 28 mar. 2024.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. **O Estado plurinacional**. Curitiba: Juruá, 2012.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; ROBERT, Cinthia. **Teoria do Estado, democracia e poder local**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

MALDONADO-TORRES, Nelson. A topologia do Ser e a geopolítica do conhecimento: modernidade, império e colonialidade. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, n. 80, 2008. Publicado online em 01 out. 2012. DOI: 10.4000/rccs.695. Disponível em: <http://journals.openedition.org/rccs/695>. Acesso em: 27 dez. 2024.

MALDONADO-TORRES, Nelson. **On the coloniality of Being**: contributions to the development of a concept. *Cultural Studies*, v. 21, n. 2-3, p. 240-270, 2007a. DOI: 10.1080/09502380601162548. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/5800/MALDONADO_Torres_ON_THE_COLONIALITY_OF_BEING_1550515847301_5800.pdf. Acesso em: 23 fev. 2024.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGOUEL, Ramón (orgs.). **El giro decolonial**: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central-IESCO; Instituto Pensar, 2007b. p. 127-167. Disponível em: <https://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17-maldonado-colonialidad%20del%20ser.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2024.

MALUF, Sahid. **Teoria geral do Estado**. 36. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

MAQUIAVEL, Nicolau. **O Príncipe**. Tradução de Maria Júlia Goldwasser. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

MATHIEU, Edouard; RITCHIE, Hannah; RODÉS-GUIRAO, Lucas. Coronavirus Pandemic (COVID-19). **Our World in Data**, 2022. Disponível em: <https://ourworldindata.org/coronavirus>. Acesso em: 27 dez. 2023.

MBEMBE, Achille. **Crítica da razão negra**. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: n-1 edições, 2014.

MEDICI, Alejandro. **Direitos humanos e soberania dos povos do Sul**: testes críticos. Mauritius: ScienceScript, 2020.

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 94, p. 1–18, jun. 2017. DOI: 10.17666/329402/2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/nKwQNPx5Zr3yrMjh7tCZVv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 fev. 2024.

MIGNOLO, Walter D. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Tradução de Ângela Lopes Norte. **Cadernos de Letras da UFF**, Niterói, n. 34, p. 287-324, 2008. Disponível em: <https://www.poscritica.uneb.br/wp-content/uploads/2021/01/1-Desobedi%C3%Aancia-epist%C3%AAmica-A-op%C3%A7%C3%A3o-descolonial-e-o-significado-de-identidade-em-pol%C3%ADtica.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025.

MIGNOLO, Walter D. **Histórias locais / projetos globais**: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. 1. ed. rev. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2020.

O GLOBO. Com necrotério lotado, caminhões transportam caixões de Bergamo para crematórios de outras cidades. **O Globo**, 18 mar. 2020. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/coronavirus/com-necroterio-lotado-caminhoes-transportam-caixoes-de-bergamo-para-crematorios-de-outras-cidades-24314132>. Acesso em: 23 jan. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Carta das Nações Unidas**. São Francisco, 26 jun. 1945. Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 19.841, de 22 out. 1945. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em: 29 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 (Resolução 217 A (III)). Tradução oficial publicada pela United Nations High Commissioner for Human Rights (em português). Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1948%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Universal%20dos%20Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Diretor-geral da OMS alerta para fracasso moral na distribuição de vacinas contra a COVID-19**. 28 jan. 2021a. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739022>. Acesso em: 27 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais**. Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 dez. 1966. Promulgado no Brasil pelo Decreto nº 591, de 6 jul. 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 12 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **An appeal to G20 leaders to make vaccines accessible to people on the move**. 29 out. 2021b. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/29-10-2021-an-appeal-to-g20-leaders-to-make-vaccines-accessible-to-people-on-the-move>. Acesso em: 22 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **COVAX. Working for global equitable access to COVID-19 vaccines**. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>. Acesso em: 27 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Eighth Meeting of the Multilateral Leaders Task Force on COVID-19**, 1 March 2022a: “Third Consultation with the CEOs of leading vaccine manufacturers”. Geneva, 7 mar. 2022. WHO. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/07-03-2022-eighth-meeting-of-the-multilateral-leaders-task-force-on-covid-19-1-march-2022-third-consultation-with-the-ceos-of-leading-vaccine-manufacturers>. Acesso em: 27 fev. 2024

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Emergency Use Listing Procedure**. Prequalification of Medical Products. [S.l.], 2023a. Disponível em: <https://extranet.who.int/prequal/vaccines/emergency-use-listing-procedure>. Acesso em: 27 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)**. 16–24 February 2020a. Geneva: World Health Organization, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>. Acesso em: 28 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Sobre a OMS / About WHO**. Genebra: World Health Organization, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/pt/about>. Acesso em: 05 jan. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Statement on the second meeting of the International Health Regulations** (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Genebra, 30 jan. 2020b. Disponível em: [https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)). Acesso em: 25 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Vaccine Equity. Genebra: **World Health Organization**, 2022b. Disponível em: <https://www.who.int/campaigns/vaccine-equity>. Acesso em: 27 nov. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part. Genebra: **WHO**, 2021c. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part>. Acesso em: 25 jan. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard**. [S.l], 2023b. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 27 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 8 September 2021. Genebra: **OMS**, 8 set. 2021c. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---8-september-2021>. Acesso em: 27 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). **Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados Primários de Saúde**. Alma-Ata (URSS), 12 set. 1978. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_alma_ata.pdf. Acesso em: 15 nov. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL; WORLD BANK GROUP; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Joint statement by the heads of WHO, IMF, World Bank Group and WTO on COVID-19 vaccines**. Genebra, 1 mar. 2022c. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/07-03-2022-eighth-meeting-of-the-multilateral-leaders-task-force-on-covid-19-1-march-2022-third-consultation-with-the-ceos-of-leading-vaccine-manufacturers>. Acesso em: 22 fev. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Brasil confirma primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus**. Brasília: **OPAS/OMS**, 26 fev. 2020a. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/node/69303>. Acesso em: 27 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Histórico da emergência internacional de COVID-19. Brasília: **OPAS/OMS**, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/historico-da-emergencia-internacional-covid-19?> Acesso em: 4 set. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia.** 11 mar. 2020b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 25 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS emite primeira validação de uso emergencial para uma vacina contra COVID-19.** 31 dez. 2020c. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/31-12-2020-oms-emite-primeira-validacao-uso-emergencia-para-uma-vacina-contra-covid-19-e>. Acesso em: 27 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS pré-qualifica primeiro anticorpo monoclonal para tratar COVID-19 grave.** 11 fev. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/11-2-2022-oms-pre-qualifica-primeiro-anticorpo-monoclonal-para-tratar-covid-19-grave>. Acesso em: 29 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE; BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA; COMISSÃO EUROPEIA. Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better. Paris: **OECD Publishing**, 2020. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/publications/latin-american-economic-outlook-2020_e6e864fb-en.html>. Acesso em: 27 dez. 2024.

PACHO, Lorena. Itália detectou há um mês o primeiro contágio local da COVID-19. Agora vive a pior crise desde 1945. **El País Brasil**, 23 mar. 2020c. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-23/italia-detectou-ha-um-mes-o-primeiro-contagio-local-da-covid-19-agora-vive-a-pior-crise-desde-1945.html>. Acesso em: 13 ago. 2023.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

PODER360. Pazuello critica Pfizer e Moderna e defende produção nacional de vacina. **Poder360**, 11 jan. 2021. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/pazuello-critica-pfizer-e-moderna-e-defende-producao-nacional-de-vacina/>. Acesso em: 29 mar. 2024.

PODER360. Pfizer exigiu de países pobres garantias que não pediu dos EUA, diz reportagem. **Poder360**, 8 maio 2021. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-exigiu-de-paises-pobres-garantias-que-nao-pediu-dos-eua-diz-reportagem/>. Acesso em: 29 mar. 2024.

POGGE, Thomas. **World poverty and human rights: cosmopolitan responsibilities and reforms**. Cambridge: Polity Press, 2008.

PRADO JÚNIOR, Caio. **Formação do Brasil contemporâneo: colônia**. 23. ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório de Desenvolvimento Humano 2021-22. Brasília; Genebra: **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**, 29 maio 2023. Disponível em:

<https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/publications/relatorio-de-desenvolvimento-humano-2021-22>. Acesso em: 25 mar. 2024.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.) **Epistemologias do Sul**. Coimbra: Edições Almedina, 2009. p. 73–118. Disponível em: <https://ayalaboratorio.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/quijano-anibal-colonialidade-do-poder-e-classificac3a7c3a3o-social.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2023.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.) **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 116-142. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 18 dez. 2023.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade, poder, globalização e democracia**. Novos Rumos, Marília, ano 17, n. 37, p. 4-28, 2002. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/novosrumos/article/view/2192>. Acesso em: 18 dez. 2023.

QUINTANA, Hélio. **História dos direitos humanos: origens e desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2008.

RAMOS, André de carvalho. **Curso de direitos humanos**. 5. ed. São Paulo: Saraiva educação, 2018.

RAMOS, João Gualberto Garcez; ESQUIVEL, Carla Liliane Waldow. *O direito à saúde como direito humano fundamental: breves considerações a respeito do seu formato legal à sua eficácia social*. **Ciências Sociais Aplicadas em Revista**, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, v. 15, n. 28, p. 9–40, 2015. Disponível em: <<https://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/15308/10385>>. Acesso em: 27 mar. 2024.

ROSTWOROWSKI, María. **Tahuantinsuyu: historia del Imperio inca**. 2. ed. Punto de Vista Editores, 2023.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A cruel pedagogia do vírus**. Coimbra: Edições Almedina, 2020. Disponível em: https://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2020/04/Livro_Boaventura.pdf. Acesso em: 27 jan. 2024.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.). **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes**. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 79, p. 71-94, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/ytPjkXXYbTRxnJ7THFDBrgc/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 05 jan. 2024.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**. 34. ed. Rio de Janeiro: Record, 2022.

SANTOS, Theotônio dos. **A Teoria da Dependência: balanço e perspectivas**. Vol. 1. São Paulo: Insular, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. **A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

SEGATO, RITA. **Crítica da colonialidade em oito ensaios e uma antropologia por demanda**. Tradução Danielli Jatobá, Danú Gontijo. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

SHARER, Robert J.; TRAXLER, Loa P. **Os antigos maias**. 6. ed. Stanford: Stanford University Press, 2006.

SOARES, Mário Lúcio Quintão. **Direitos Fundamentais e Direito Comunitário: por uma metódica de direitos fundamentais aplicada às normas comunitárias**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

SOARES, Mário Lúcio Quintão. **Teoria do Estado: Novos paradigmas em face da globalização**. 3. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2008.

SOUZA, André Pagani de; CARACIOLA, Andrea Boari; ASSIS, Carlos Augusto de; FERNANDES, Luís Eduardo Simardi; DELLORE, Luiz. **Teoria geral do processo contemporâneo**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

SOUZA, Marina de Mello e. **África e Brasil africano**. 3. ed. São Paulo: Ática, 2012.

SOUZA, Neusa Santos. **Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social**. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

THE BUREAU OF INVESTIGATIVE JOURNALISM. **Held to ransom: Pfizer demands governments gamble with state assets to secure vaccine deal**. 23 fev. 2021. Disponível em: <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-23/held-to-ransom-pfizer-demands-governments-gamble-with-state-assets-to-secure-vaccine-deal>. Acesso em: 29 abr. 2024.

TODOROV, Tzvetan. **A conquista da América: a questão do outro**. 2. ed. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

UNAIDS Brasil. **Estatísticas**. UNAIDS Brasil, 2025. Disponível em: <https://unaids.org.br/estatisticas/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS. **COVID-19: informações técnicas e educacionais**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/487>. Acesso em: 22 out. 2023.

UOL Notícias. **Pandemia de covid: Brasil teve 10% das mortes oficiais pela doença no mundo; entenda**. São Paulo, 5 maio 2023. Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2023/05/05/pandemia-de-covid-brasil-teve-10-das-mortes-oficiais-pela-doenca-no-mundo-entenda.htm>. Acesso em: 12 out. 2023.

VENTURA, Deisy. **Direito e saúde global: o caso da pandemia de gripe A (H1N1)**. São Paulo: Dobra, 2013.

VILLEY, Michel. **O direito e os direitos humanos**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. **The modern world-system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century**. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2011.

WALSH, Catherine. Interculturalidad, colonialidad y educación. **Revista Educación y Pedagogía**, Medellín, v. 19, n. 48, p. 25-35, 2009. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6652>. Acesso em: 02 jan. 2024.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19 vaccination dataset. **Our World in Data**, 2021. Disponível em:

https://ourworldindata.org/explorers/covid?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&country=OWID_NAM~OWID_EUR&pickerSort=asc&pickerMetric=entityName&hideControls=false&Metric=Vaccine+doses&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+population=true. Acesso em: 26 jan. 2024.

APÊNDICE I

RESULTADO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA (RECORTE TEMPORAL: 2020 A 2025)

Busca a partir de descritores isolados

Descritor	Google Acadêmico	Scielo Br	BDTD	Periódicos da CAPES
Direito humano à saúde	24.100	65	3.358	3.000
Vacina / imunizante	15.600 / 3.910	276 / 4	1.840 / 353	1.570 / 188
Colonialidade	16.200	231	5.253	1.802
Indústria Farmacêutica / Corporações Transnacionais	16.600 / 14.200	54 / 9	980 / 41	664 / 40
COVID-19	834.000	817	13.833	1.053.793

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Interlocução entre direito humano à saúde e os demais descritores

direito humano à saúde + descritor	Google Acadêmico	Scielo Br	BDTD	Periódicos da CAPES
Vacina / imunizante	170 / 23	1 / 0	56 / 5	8 / 3
Colonialidade	43	0	225	16
Indústria Farmacêutica / Corporações Transnacionais	102 / 13	0 / 0	25 / 5	4 / 1
COVID-19	561	10	546	367

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Pesquisa específica com expressões booleanas relacionada ao objeto da tese

Expressão booleana	Google Acadêmico	Scielo Br	BDTD	Periódicos da CAPES
("direito humano à saúde") AND ("vacina" OR "imunizante") AND ("colonialidade") AND ("covid-19")	4 – (0)*	0	0	110 – (0)*
("direito humano à saúde") AND ("vacina" OR "imunizante") AND ("colonialidade") AND ("covid-19") AND ("Indústria Farmacêutica" OR "Corporações Transnacionais")	1 – (0)*	0	0	–**
* trabalhos selecionados				
** pesquisa não realizada devido ao limite de descritores permitidos na expressão booleana				

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

APÊNDICE II

LEIS ORDINÁRIAS PUBLICADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 ENTRE 2020 A 2022

Número da Legislação	Ementa
<u>Lei nº 13.979, de 6.2.2020</u> Publicada no DOU de 7.2.2020	Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
<u>Lei nº 13.982, de 2.4.2020</u> Publicada no DOU de 2.4.2020 -Edição extra-A	Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
<u>Lei nº 13.987, de 7.4.2020</u> Publicada no DOU de 7.4.2020 - Edição extra	Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.
<u>Lei nº 13.989, de 15.4.2020</u> Publicada no DOU de 16.4.2020	Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
<u>Lei nº 13.992, de 22.4.2020</u> Publicada no DOU de 23.4.2020	Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
<u>Lei nº 13.993, de 23.4.2020</u> Publicada no DOU de 24.4.2020	Dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil.
<u>Lei nº 13.995, de 5.5.2020</u> Publicada no DOU de 6.5.2020	Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 13.998, de 14.5.2020</u> Publicada no DOU de 15.5.2020	Promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.006, de 28.5.2020</u> Publicada no DOU de 29.5.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.010, de 10.6.2020</u> Publicada no DOU de 12.6.2020	Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
<u>Lei nº 14.016, de 23.6.2020</u> Publicada no DOU de 24.6.2020	Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano.
<u>Lei nº 14.017, de 29.6.2020</u> Publicada no DOU de 30.6.2020	Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública

Número da Legislação	Ementa
	reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. _
<u>Lei nº 14.018, de 29.6.2020</u> Publicada no DOU de 30.6.2020	Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
<u>Lei nº 14.019, de 2.7.2020</u> Publicada no DOU de 3.7.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.020, de 6.7.2020</u> Publicada no DOU de 7.7.2020	Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.021, de 7.7.2020</u> Publicada no DOU de 8.7.2020	Dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública.
<u>Lei nº 14.022, de 7.7.2020</u> Publicada no DOU de 8.7.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
<u>Lei nº 14.023, de 8.7.2020</u> Publicada no DOU de 9.7.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
<u>Lei nº 14.024, de 9.7.2020</u> Publicada no DOU de 10.7.2020	Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. <u>Mensagem de veto</u>
<u>Lei nº 14.025, de 14.7.2020</u> Publicada no DOU de 15.7.2020	Altera excepcionalmente as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos que especifica e ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.

Número da Legislação	Ementa
<u>Lei nº 14.028, de 27.7.2020</u> Publicada no DOU de 28.7.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para garantir que o receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo tenha validade pelo menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19, na forma que especifica.
<u>Lei nº 14.029, de 28.7.2020</u> Publicada no DOU de 29.7.2020	Dispõe sobre a transposição e a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.
<u>Lei nº 14.030, de 28.7.2020</u> Publicada no DOU de 29.7.2020	Dispõe sobre as assembleias e as reuniões de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020; altera as Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.032, de 4.8.2020</u> Publicada no DOU de 5.8.2020	Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R\$ 2.113.789.466,00 (dois bilhões, cento e treze milhões, setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais), para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.033, de 4.8.2020</u> Publicada no DOU de 5.8.2020	Abre crédito extraordinário em favor da Presidência da República, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R\$ 639.034.512,00 (seiscentos e trinta e nove milhões, trinta e quatro mil quinhentos e doze reais), para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.034, de 5.8.2020</u> Publicada no DOU de 6.8.2020	Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19; e altera as Leis nos 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.319, de 25 de julho de 2016, 13.499, de 26 de outubro de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de 1999.
<u>Lei nº 14.035, de 11.8.2020</u> Publicada no DOU de 12.8.2020	Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
<u>Lei nº 14.036, de 13.8.2020</u> Publicada no DOU de 14.8.2020	Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, para estabelecer a forma de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as regras para a restituição ou a suplementação dos valores por meio de outras fontes próprias de recursos pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal.
<u>Lei nº 14.040, de 18.8.2020</u> Publicada no DOU de 19.8.2020	Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
<u>Lei nº 14.041, de 18.8.2020</u> Publicada no DOU de 19.8.2020	Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.042, de 19.8.2020</u> Publicada no DOU de 20.8.2020	Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro de 2009, e 13.999, de 18 de maio de 2020; e dá outras providências.

Número da Legislação	Ementa
<u>Lei nº 14.043, de 19.8.2020</u> Publicada no DOU de 20.8.2020	Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos; altera as Leis nos 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 13.999, de 18 de maio de 2020; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.045, de 20.8.2020</u> Publicada no DOU de 21.8.2020	Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, para instituir linha de crédito destinada aos profissionais liberais que atuem como pessoa física, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, para criar o Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Microempresas e para Pequenas e Médias Empresas e o Conselho de Participação em Operações de Crédito Educativo.
<u>Lei nº 14.046, de 24.8.2020</u> Publicada no DOU de 25.8.2020	Dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.047, de 24.8.2020</u> Publicada no DOU de 25.8.2020	Dispõe sobre medidas temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do setor portuário, sobre a cessão de pátios da administração pública e sobre o custeio das despesas com serviços de estacionamento para a permanência de aeronaves de empresas nacionais de transporte aéreo regular de passageiros em pátios da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e altera as Leis nºs 9.719, de 27 de novembro de 1998, 7.783, de 28 de junho de 1989, 12.815, de 5 de junho de 2013, 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 10.233, de 5 de junho de 2001.
<u>Lei nº 14.048, de 24.8.2020</u> Publicada no DOU de 25.8.2020	Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da Covid-19; altera as Leis nos 13.340, de 28 de setembro de 2016, e 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e dá outras providências (Lei Assis Carvalho).
<u>Lei nº 14.054, de 10.9.2020</u> Publicada no DOU de 11.9.2020	Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações Exteriores, no valor de R\$ 418.800.000,00 (quatrocentos e dezoito milhões e oitocentos mil reais), para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.055, de 10.9.2020</u> Publicada no DOU de 11.9.2020	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 5.566.379.351,00 (cinco bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, trezentos e setenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais), para os fins que especifica; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.056, de 10.9.2020</u> Publicada no DOU de 11.9.2020	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), para os fins que especifica; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.057, de 11.9.2020</u> Publicada no DOU de 14.9.2020	Disciplina o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais e o acordo terminativo de litígio contra a Fazenda Pública e dispõe sobre a destinação dos recursos deles oriundos para o combate à Covid-19, durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
<u>Lei nº 14.058, de 17.9.2020</u> Publicada no DOU de 18.9.2020	Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.
<u>Lei nº 14.060, de 23.9.2020</u> Publicada no DOU de 24.9.2020	Prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback que tenham sido prorrogados por 1 (um) ano pela autoridade fiscal e

Número da Legislação	Ementa
	que tenham termo em 2020; e altera a Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009.
<u>Lei nº 14.061, de 23.9.2020</u> Publicada no DOU de 24.9.2020	Prorroga até 30 de setembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecida na Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.063, de 23.9.2020</u> Publicada no DOU de 24.9.2020	Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
<u>Lei nº 14.065, de 30.9.2020</u> Publicada no DOU de 1º.10 de 2020	Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
<u>Lei nº 14.067, de 1º.10.2020</u> Publicada no DOU de 2.10 de 2020	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 4.489.224.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais), para o fim que especifica.
<u>Lei nº 14.068, de 1º.10.2020</u> Publicada no DOU de 2.10 de 2020	Abre crédito extraordinário em favor de Encargos Financeiros da União, no valor de R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), para o fim que especifica; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.072, de 14.10.2020</u> Publicada no DOU de 15.10.2020	Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.
<u>Lei nº 14.073, de 14.10.2020</u> Publicada no DOU de 15.10 de 2020	Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
<u>Lei nº 14.075, de 22.10.2020</u> Publicada no DOU de 23.10.2020	Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital; e altera as Leis nºs 13.982, de 2 de abril de 2020, e 14.058, de 17 de setembro de 2020.
<u>Lei nº 14.107, de 3.12.2020</u> Publicada no DOU de 4.12.2020	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 1.994.960.005,00, (um bilhão, novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta mil e cinco reais), para o fim que especifica; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.114, de 29.12.2020</u> Publicada no DOU de 29.12.2020 - Edição extra	Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial no valor de R\$ 4.223.266.669,00, para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.115, de 29.12.2020</u> Publicada no DOU de 29.12.2020 - Edição extra	Estabelece o aumento da participação da União no Fundo Garantidor de Operações (FGO), no montante equivalente ao dos recursos devolvidos à União em conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 10 da Lei nº 14.043, de 19 de agosto de 2020.
<u>Lei nº 14.117, de 8.1.2021</u> Publicada no DOU de 11.1.2021	Suspende o pagamento do parcelamento de dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), criado pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, durante a vigência de calamidade pública nacional reconhecida pelo Congresso Nacional; e altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, e 10.671, de 15 de maio de 2003.

Número da Legislação	Ementa
<u>Lei nº 14.121, de 1º.3.2021</u> Publicada no DOU de 2.3.2021	Autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e estabelece diretrizes para a imunização da população.
<u>Lei nº 14.122, de 3.3.2021</u> Publicada no DOU de 4.3.2021	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 2.513.700.000,00 (dois bilhões, quinhentos e treze milhões e setecentos mil reais), para o fim que especifica; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.123, de 10.3.2021</u> Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição extra	Altera a Lei nº 13.650, de 11 de abril de 2018, e prorroga até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020.
<u>Lei nº 14.124, de 10.3.2021</u> Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição extra	Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
<u>Lei nº 14.125, de 10.3.2021</u> Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição extra	Dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado.
<u>Lei nº 14.128, de 26.3.2021</u> Publicada no DOU de 26.3.2021 - Edição extra D	Dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito; e altera a Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.
<u>Lei nº 14.131, de 30.3.2021</u> Publicada no DOU de 31.3.2021	Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
<u>Lei nº 14.147, de 26.4.2021</u> Publicada no DOU de 27.4.2021	Cria o Programa Pró-Leitos, com aplicação enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19. <u>Mensagem de veto</u>
<u>Lei nº 14.148, de 3.5.2021</u> Publicada no DOU de 4.5.2021	Dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19; institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC); e altera as Leis nos 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e 8.212, de 24 de julho de 1991. <u>Mensagem de veto</u>
<u>Lei nº 14.150, de 12.5.2021</u> Publicada no DOU de 13.5.2021	Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), para estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
<u>Lei nº 14.151, de 12.5.2021</u> Publicada no DOU de 13.5.2021	Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
<u>Lei nº 14.152, de 19.5.2021</u> Publicada no DOU de 20.5.2021	Dispõe sobre a extensão do prazo de validade de prescrições médicas e de pedidos de exames complementares de diagnóstico emitidos para gestantes e puérperas, e sobre o acesso facilitado a

Número da Legislação	Ementa
	cuidados intensivos e à internação em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) enquanto perdurar a pandemia de covid-19.
<u>Lei nº 14.160, de 2.6.2021</u> Publicada no DOU de 4.6.2021 - Edição extra	Dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas.
<u>Lei nº 14.171, de 10.6.2021</u> Publicada no DOU de 11.6.2021	Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer medidas de proteção à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio emergencial de que trata o seu art. 2º; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.174, de 17.6.2021</u> Publicada no DOU de 18.6.2021	Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, para prorrogar o prazo de vigência de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.179, de 30.6.2021</u> Publicada no DOU de 1º.7.2021	Estabelece normas para facilitação de acesso a crédito e para mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19; e revoga dispositivos das Leis nºs 8.870, de 15 de abril de 1994, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
<u>Lei nº 14.186, de 15.7.2021</u> Publicada no DOU de 16.7.2021	Altera a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, para dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.
<u>Lei nº 14.187, de 15.7.2021</u> Publicada no DOU de 16.7.2021	Dispõe sobre a autorização para que estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário sejam utilizadas na produção de insumos farmacêuticos ativos (IFA) e vacinas contra a covid-19 no Brasil.
<u>Lei nº 14.189, de 28.7.2021</u> Publicada no DOU de 29.7.2021	Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
<u>Lei nº 14.190, de 29.7.2021</u> Publicada no DOU de 30.7.2021	Altera a Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, para determinar a inclusão como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 de gestantes, puérperas e lactantes, bem como de crianças e adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade.
<u>Lei nº 14.198, de 2.9.2021</u> Publicada no DOU de 3.9.2021	Dispõe sobre videochamadas entre pacientes internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares.
<u>Lei nº 14.199, de 2.9.2021</u> Publicada no DOU de 3.9.2021	Altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da Previdência Social durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.200, de 2.9.2021</u> Publicada no DOU de 3.9.2021	Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), para dispor sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional.
<u>Lei nº 14.215, de 7.10.2021</u> Publicada no DOU de 8.10.2021	Institui normas de caráter transitório aplicáveis a parcerias celebradas pela administração pública durante a vigência de medidas restritivas relacionadas ao combate à pandemia de covid-19, e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.216, de 7.10.2021</u> Publicada no DOU de 8.10.2021	Estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em

Número da Legislação	Ementa
	imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.
<u>Lei nº 14.217, de 13.10.2021</u> Publicada no DOU de 14.10.2021	Dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e de insumos e para a contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.218, de 13.10.2021</u> Publicada no DOU de 14.10.2021	Altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, para dispor sobre a validade das normas educacionais a serem adotadas, em caráter excepcional, enquanto perdurarem a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 e suas consequências.
<u>Lei nº 14.225, de 19.10.2021</u> Publicada no DOU de 20.10.2021	Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e da Cidadania, no valor de R\$ 235.348.850,00 (duzentos e trinta e cinco milhões trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.259, de 7.12.2021</u> Publicada no DOU de 8.12.2021	Altera a Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
<u>Lei nº 14.275, de 23.12.2021</u> Publicada no DOU de 24.12.2021	Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar, para mitigar os impactos socioeconômicos da Covid-19; altera as Leis nºs 13.340, de 28 de setembro de 2016, e 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e dá outras providências (Lei Assis Carvalho II).
<u>Lei nº 14.297, de 5.1.2022</u> Publicada no DOU de 6.1.2022	Dispõe sobre medidas de proteção asseguradas ao entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega durante a vigência da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pela covid-19.
<u>Lei nº 14.301, de 7.1.2022</u> Publicada no DOU de 7.1.2022 - Edição extra	Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar); altera as Leis nºs 5.474, de 18 de julho de 1968, 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13 de julho de 2004, e 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e revoga o Decreto do Poder Legislativo nº 123, de 11 de novembro de 1892, e o Decreto-Lei nº 2.784, de 20 de novembro de 1940, e dispositivos da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, e das Leis nºs 6.458, de 1º de novembro de 1977, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 11.483, de 31 de maio de 2007, 11.518, de 5 de setembro de 2007, 12.599, de 23 de março de 2012, 12.815, de 5 de junho de 2013, e 13.848, de 25 de junho de 2019. <u>Mensagem de veto</u>
<u>Lei nº 14.305, de 23.2.2022</u> Publicada no DOU de 24.2.2022	Cria o Programa Prioritário Pró-Pesquisa Covid-19 enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19.
<u>Lei nº 14.311, de 9.3.2022</u> Publicada no DOU de 10.3.2022	Altera a Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, para disciplinar o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra o coronavírus SARS-Cov-2 das atividades de trabalho presencial quando a atividade laboral por ela exercida for incompatível com a sua realização em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, nos termos em que especifica.
<u>Lei nº 14.314, de 24.3.2022</u> Publicada no DOU de 25.3.2022	Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para ajustar o período de suspensão da contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos econômicos

Número da Legislação	Ementa
	decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da covid-19.
<u>Lei nº 14.343, de 19.5.2022</u> Publicada no DOU de 20.5.2022	Autoriza o Poder Executivo federal a doar imunizantes contra a covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária internacional.
<u>Lei nº 14.347, de 25.5.2022</u> Publicada no DOU de 26.5.2022	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R\$ 6.412.000.000,00 (seis bilhões quatrocentos e doze milhões de reais), para os fins que especifica.
<u>Lei nº 14.357, de 1º.6.2022</u> Publicada no DOU de 2.6.2022	Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 167.288.600,00 (cento e sessenta e sete milhões duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), para o fim que especifica.
<u>Lei nº 14.366, de 8.6.2022</u> Publicada no DOU de 9.6.2022	Dispõe sobre a prorrogação excepcional de prazos de isenção, de redução a zero de alíquotas ou de suspensão de tributos em regimes especiais de drawback ; altera as Leis nºs 9.365, de 16 de dezembro de 1996, 13.483, de 21 de setembro de 2017, 10.893, de 13 de julho de 2004, e 14.060, de 23 de setembro de 2020; e revoga dispositivo da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
<u>Lei nº 14.370, de 15.6.2022</u> Publicada no DOU de 15.6.2022 - Edição extra	Institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas.
<u>Lei nº 14.390, de 4.7.2022</u> Publicada no DOU de 5.7.2022	Altera a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, para dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura; revoga dispositivos da Lei nº 14.186, de 15 de julho de 2021; e dá outras providências.
<u>Lei nº 14.458 de 19.10.2022</u> Publicada no DOU de 20.10.2022	Dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas.
<u>Lei nº 14.466, de 16.11.2022</u> Publicada no DOU de 17.11.2022	Revoga a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, que "dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado".

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

APÊNDICE III

LEIS COMPLEMENTARES PUBLICADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 ENTRE 2020 A 2022

Número da Lei complementar	Ementa
Lei Complementar nº 172, de 15.4.2020 Publicada no DOU de 16.4.2020	Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.
Lei Complementar nº 173, de 27.5.2020 Publicada no DOU de 28.5.2020	Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Mensagem de veto
Lei Complementar nº 180, de 14.4.2021 Publicada no DOU de 15.4.2021	Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Lei Complementar nº 181, de 6.5.2021 Publicada no DOU de 7.5.2021	Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, e a Lei nº 14.029, de 28 de julho de 2020, para conceder prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios executem atos de transposição e de transferência e atos de transposição e de reprogramação, respectivamente; altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, para conceder prazo adicional para celebração de aditivos contratuais e permitir mudança nos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento de dívidas; altera a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, para permitir o afastamento de vedações durante o Regime de Recuperação Fiscal desde que previsto no Plano de Recuperação Fiscal; altera a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, para conceder prazo adicional para celebração de contratos e disciplinar a apuração de valores inadimplidos de Estado com Regime de Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de 2020; e revoga o art. 27 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.
Lei Complementar nº 191, de 8.3.2022 Publicada no DOU de 9.3.2022	Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Lei Complementar nº 195, de 8.7.2022 Publicada no DOU de 8.7.2022 - Edição extra	Dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para não contabilizar na meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da Federação para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes de calamidades públicas ou pandemias; e altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para atribuir outras fontes de recursos ao Fundo Nacional da Cultura (FNC).
Lei Complementar nº 197, de 6.12.2022 Publicada no DOU de 7.12.2022	Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, e a Lei nº 14.029, de 28 de julho de 2020, para conceder prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios executem atos de transposição e de transferência e atos de transposição e de reprogramação, respectivamente.

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

APÊNDICE IV

EMENDAS CONSTITUCIONAIS PUBLICADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 ENTRE 2020 A 2022

Número da Emenda	Ementa
Emenda Constitucional nº 106, de 7.5.2020 Publicado no DOU de 8.5.2020	Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia.
Emenda Constitucional nº 107, de 2.7.2020 Publicada no DOU de 3.7.2020	Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos.
Emenda Constitucional nº 109, de 15.3.2021 Publicado no DOU 16.3.2021	Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 169 da Constituição Federal e os arts. 101 e 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; acrescenta à Constituição Federal os arts. 164-A, 167- A, 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G; revoga dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e suspende condicionalidades para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19.
Emenda Constitucional nº 119, de 27.4.2022 Publicado no DOU 28.4.2022	Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Fonte: Elaborado pela autora (2026)